Guía Práctica de **ENFERMERÍA**

Ana María López Calleja, Noelia Cano Sanz



en EII

ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL

© Abbvie 2017.

Coordinadoras:

Ana María López Calleja (Enfermera Coordinadora de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid)

Noelia Cano Sanz (Enfermera Colaboradora de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Doctora en Enfermería. Complejo Asistencial Universitario, León [CAULE])

Editado por:

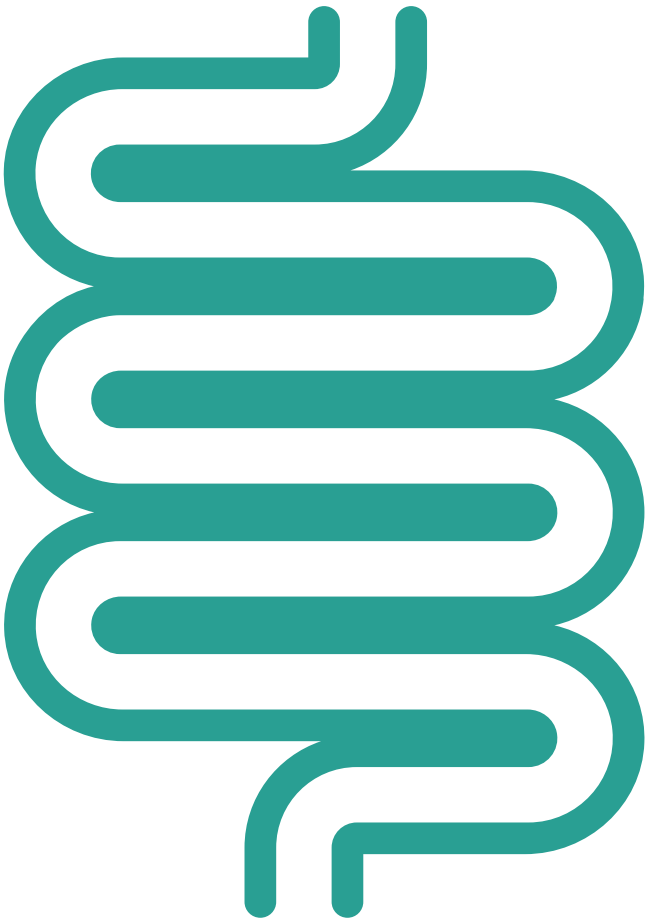
INspira Network

INSPIRA NETWORK GROUP SL
C/ Irún, 21. 28008 Madrid. Tel. +34 607 82 53 44 / Fax. +91 547 05 70

Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida, total o parcialmente, por cualquier medio, electrónico o mecánico, ni por fotocopia grabación u otro sistema de reproducción de información sin el permiso por escrito de los titulares del Copyright.
El contenido de este libro es responsabilidad exclusiva de los autores. La editorial declina cualquier responsabilidad sobre el mismo.

Impreso en España
ISBN: 978-84-608-4295-8. Depósito Legal: M-26694-2016

Guía Práctica de **ENFERMERÍA**



en **EII**

ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL

índice

Página

AUTORES 5

PRÓLOGO 7

1. INTRODUCCIÓN 9

2. PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES INTEGRALES DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) 15

3. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 23

3.1. Introducción 25

3.2. Valoración 29
3.2.1. Acogida al paciente de reciente diagnóstico 30
3.2.2. Seguimiento del paciente en la consulta 35

3.3. Tratamientos 39
3.3.1. Aminosalicilatos, antibióticos, corticoides e inmunosupresores 40
3.3.2. Biológicos 53
3.3.3. Aféresis terapéutica en la EII 67

3.4. Intervenciones 71
3.4.1. Adhesión al tratamiento 72
3.4.2. Cirugía. Ostomía 78
3.4.3. La transición de pacientes pediátricos a la edad adulta 87
3.4.4. Nutrición y recomendaciones dietéticas 96
3.4.5. Beneficios del ejercicio 103
3.4.6. Aspectos psicosociales 106
3.4.7. Vacunas 112
3.4.8. Viajes y EII 122
3.4.9. Sexualidad y embarazo en la EII 127
3.4.10. Tabaco 140
3.4.11. Aspectos sociolaborales 144

3.5. Actividades no presenciales 151
3.5.1. Atención telemática 152
3.5.2. Enfermería 2.0 y EII 162

4. ACTIVIDAD DOCENTE 167

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 171

SIGLAS Y ABREVIATURAS 177

autores

GUILLERMO ÁLVAREZ CALATAYUD
Médico de Pediatría. Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

NOELIA CANO SANZ
Enfermera Colaboradora de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Doctora en Enfermería
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

M.ª MERCEDES CAÑAS GIL
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

MARTA GALLEGO BARRERO
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hopital Clínic. Barcelona

BELÉN GONZÁLEZ GARCÍA
Enfermera de Pediatría
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

MONTSERRAT GONZÁLEZ LÓPEZ
Psicóloga
Terapeuta EMDR. León

M.ª JOSÉ JIMÉNEZ BARBERO
Supervisora de la UGC de Medicina Interna
Hospital Virgen de Valme. Sevilla

ANA MARÍA LÓPEZ CALLEJA
Enfermera Coordinadora de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio de Gastroenterología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

IGNACIO MARÍN JIMÉNEZ
Médico Gastroenterólogo de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio de Gastroenterología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

LAURA MARÍN SÁNCHEZ
Enfermera Coordinadora de Ensayos Clínicos de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio de Gastroenterología
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona

M.ª ÁNGELES MARINERO MUÑOZ
Enfermera de Consulta Monográfica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio Digestivo
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

MILAGROS MARTÍN FERNÁNDEZ
Estomoterapeuta. Consulta de Enfermería de Ostomías
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

INMACULADA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Enfermera de Pediatría
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

LUIS ALBERTO MENCHÉN VISO
Médico Gastroenterólogo de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Servicio de Gastroenterología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

JOSÉ LUIS MORALES PÉREZ
Médico de Pediatría. Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

M.ª DEL CARMEN MORETE PÉREZ
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. A Coruña

DIANA MUÑOZ GÓMEZ
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hospital la Fe. Valencia

FRANCISCA MURCIANO GONZALO
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hospital del Mar. Barcelona

ESTER NAVARRO CORREAL
Enfermera. UACC
Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona

OLGA NÚÑEZ GARCÍA
Enfermera de Investigación de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

PILAR PINILLA SAN MARTÍN
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid

JUAN FRANCISCO PULIDO PULIDO
Jefe de Unidad de Enfermería. Servicio de Nefrología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

LUCIANO SAN ROMÁN ÁLVAREZ
Enfermero de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Área de Gestión Integrada Vigo
Hospital Universitario Álvaro Cunquéiro. Vigo

CÉSAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Médico de Pediatría. Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

MAR TOLÍN HERNANI
Médico de Pediatría. Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

ANTONIO TORREJÓN HERRERA
Director de Sistemas de Información y TIC (CIO)
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers. Barcelona

ÁNGELES VILLANUEVA TREVIÑO
Enfermera del Servicio de Digestivo
Hospital Universitario La Paz. Madrid

prólogo

El término «enfermedad inflamatoria intestinal» (EII) engloba un grupo de patologías inflamatorias intestinales de etiología desconocida, mediadas inmunológicamente y de curso crónico, que afectan al tubo digestivo. En sentido estricto, las entidades nosológicas que quedan agrupadas dentro de este concepto son dos: la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). Existe además otra enfermedad conocida como colitis indeterminada (CI), que representa aproximadamente un 10 % del total de los pacientes en los que la distinción clínica, endoscópica e histológica entre CU y EC del colon no es posible en el momento del diagnóstico.

La EII es una patología muy compleja, en la que se pone de manifiesto la importancia del trabajo en equipos multidisciplinares especializados, con un importante papel desarrollado por el colectivo enfermero, para conseguir resultados en salud de máxima calidad.

Así, para optimizar la práctica diaria de nuestro colectivo, se propone la elaboración de una Guía de Práctica de Enfermería ante la necesidad de homogeneizar y optimizar las estrategias y procedimientos, aportando «recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones terapéuticas más adecuadas»[1] que conduzcan a una optimización del manejo clínico de esta entidad, con medidas centradas en los pacientes.

Con esta guía, desde GETEII hemos pretendido actualizar, de forma científica y comprensible, los principales temas en el conocimiento de la EII que pueden ser de interés para la enfermería. Para ello, un grupo de trabajo nacional de enfermeras/os especializados en el campo de la EII hemos colaborado en su confección, incluyendo un compendio de capítulos que abarcan temas relacionados con la práctica clínica cotidiana del manejo de los pacientes con EII.

El propósito de esta guía es el de servir de ayuda en la formación de todos aquellos profesionales de enfermería implicados en el manejo de pacientes afectados por esta patología, prestando especial atención a su repercusión en la calidad de vida de estos. Asimismo, pretende ser una herramienta útil en el trabajo diario en las Unidades Integrales de EII que facilite a los profesionales el manejo de algunos problemas de salud que aparecen a lo largo del seguimiento, en ocasiones de alta complejidad.

Confiamos en que su diseño eminentemente práctico sea un estímulo para su lectura y que ello mejore el conocimiento de sus lectores.

La colaboración prestada por los distintos profesionales de enfermería implicados en la atención de estos pacientes permite la publicación de esta guía, que no dudamos será de gran utilidad y que abrirá las puertas a la elaboración y publicación de otras en el futuro más amplias y con mayor repercusión.

Nuestro agradecimiento a los componentes del grupo de trabajo por su colaboración y esfuerzo, y a sus lectores por su interés y atención.

Ana María López Calleja
Noelia Cano Sanz
(Coordinadoras)

[1]Institute of Medicine Commitee to Advise the Public Health Service on Clinical Practice Guidelines: directions for a new program. Field MJ, Lohr KN, editors. Washinggton DC: National Academy Press; 1990.



1

INTRODUCCIÓN

Ana M.ª López Calleja[1] y Noelia Cano Sanz[2]

[1]Enfermera Coordinadora de la Unidad de EII. Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
[2]Enfermera Colaboradora de la Unidad de EII. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) agrupa una serie de trastornos de causa desconocida, asociados a una respuesta inmune desmesurada que produce lesiones de profundidad y extensión variable en el intestino. Diferentes teorías han sido propuestas para justificar una probable etiología multifactorial, fundamentalmente centradas en la «teoría de la higiene»* y en desequilibrios de la respuesta inmune y la flora bacteriana, aunque otros factores como el papel del tabaco, una genética poligénica no mendeliana, la interacción con agentes ambientales o la influencia del estado psicológico han sido también relacionados.
Se trata de una patología de curso crónico, sin tendencia a la curación y con una evolución difícil de predecir, en la que alternan periodos de mayor y menor intensidad sintomática. Nos referimos, por lo general, a la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). Cada una de ellas presenta características clínicas y anatomopatológicas específicas aunque, en ocasiones, pueden presentarse casos clínicos con combinación de hallazgos compatibles tanto con uno u otro trastorno. Es por lo que se hace necesario definir un tercer subtipo de patología, como la colitis indeterminada.
Esta enfermedad puede debutar de muy distintas maneras, pero en general debe sospecharse que un paciente padece enfermedad inflamatoria intestinal ante la presencia crónica o recurrente de algunos de los siguientes signos o síntomas: rectorragia, dolor abdominal, distensión abdominal, episodios de diarrea, tenesmo o urgencia defecatoria, presencia de lesiones perianales y existencia de determinadas manifestaciones extraintestinales o sistémicas.
La incidencia anual de EII en países desarrollados es de 10-20 casos/100.000 habitantes. La prevalencia es de 200-300 casos/100.000 habitantes. En España, la incidencia es de 5,5 casos/100.000 habitantes para la enfermedad de Crohn, y 8 casos/100.000 habitantes para la colitis ulcerosa, con una progresiva tendencia a la aparición en edades cada vez más tempranas, incluso antes de los 16 años, particularmente para la enfermedad de Crohn.
Para su diagnóstico es esencial un elevado índice de sospecha ante la presencia de sintomatología compatible en la historia clínica y determinaciones analíticas (calprotectina fecal, proteína C reactiva). Asimismo, la anamnesis y la exploración resulta fundamental a la hora de establecer la fase de actividad inflamatoria en la que se encuentra, así como la respuesta al tratamiento farmacológico. Serán de gran utilidad índices clínicos que permitirán puntuar el grado de afectación clínica y comprobar la evolución del control de la actividad de la enfermedad. No obstante, tanto para el diagnóstico inicial como en el seguimiento posterior, son necesarios hallazgos de pruebas complementarias compatibles con la enfermedad, incluyendo la toma de biopsias vía endoscopia para diagnóstico histológico, aunque también es común la aplicación de pruebas de imagen (ecografía abdominal, tomografía computarizada o resonancia magnética).
Independientemente de la posibilidad de que existan pacientes con una afectación sin características definitorias de las formas de presentación de la EII, con mayor frecuencia los cuadros se muestran con características diferenciales típicas que permiten su reconocimiento y diagnóstico. La Tabla I resume dichas características diferenciales. La fisiopatolo-

*Teoría de la higiene: esta teoría fue propuesta por David Strachan en 1989. Sugería que el avance de una enfermedad de carácter alérgico o autoinmune estaba relacionado con la exposición a ciertos tipos de gérmenes. Este científico llegó a la conclusión de que si un paciente con estas dolencias se ha sometido a microbios de forma continua a una edad temprana, la expansión y los efectos de la alergia pueden ser mucho menos intensos. Nuestro sistema defensivo adquiere inmunidad frente a algunas bacterias del entorno. De esta forma, es cierto que las personas con mayor contacto con antígenos o gérmenes desarrollan un sistema inmunitario con mejor funcionamiento, más fuerte para la defensa frente a infecciones y con menor frecuencia de desarrollo de enfermedades autoinmunes.

Tabla I
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA ENFERMEDAD DE CROHN Y LA COLITIS ULCEROSA

	ENFERMEDAD DE CROHN	COLITIS ULCEROSA
Clínica	Predominio de síntomas sistémicos Dolor abdominal, plastrón por adherencia de asas que condiciona masa abdominal Enfermedad perianal Síntomas gastrointestinales altos	Predominio de rectorragia Deposiciones numerosas Tenesmo rectal Síntomas generales sólo en brote grave
Endoscopia	Afectación rectal ocasional Afectación parcheada Aftas y úlceras profundas, lineales y geográficas Estenosis frecuente Afectación ileal frecuente	Afectación rectal casi constante Afectación continua Superficie mucosa granujienta con pseudopólipos y úlceras en casos graves
Histología	Afectación parcheada Transmural Granulomas Fibrosis cicatricial	Afectación difusa Limitada a la mucosa Abscesos crípticos Depleción de células mucinosas y caliciformes Distorsión arquitectural
Manejo terapéutico	Aminosalicilatos con limitada/nula utilidad Restricción de la indicación de tratamiento quirúrgico, con resección intestinal limitada, tratamiento de estenosis y fístulas	Frecuente utilización de aminosalicilatos Indicación quirúrgica más extendida, curativa o cuasicurativa con la realización de colectomía indicada en caso de mal control clínico, megacolon tóxico o desarrollo de neoplasia

gía de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa presenta, asimismo, procesos diferentes, lo cual condiciona manifestaciones clínicas y cursos evolutivos específicos. De esta forma, la enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación de tipo granulomatoso que puede afectar a cualquier tramo del tubo digestivo, de forma no continua desde el punto de vista longitudinal pero sí transmuralmente, afectando a todas las capas del tubo digestivo. Ello condiciona la posibilidad de desarrollar enfermedad perianal con mayor frecuencia así como manifestarse, en las fases de brote, predominantemente con clínica de dolor abdominal, pérdida de peso y síndrome constitucional. Dado que el intestino delgado es el segmento de mayor longitud, puede ser frecuentemente afectado por el proceso inflamatorio desarrollando adherencias y estenosis responsables de cuadros oclusivos/suboclusivos. Por el contrario, la colitis ulcerosa afecta exclusivamente al colon de forma continua, generalmente de distal a proximal con diferente grado de extensión, involucrando exclusivamente a la mucosa. Este hecho condiciona una clínica predominante en fases de brote de rectorragia

y diarrea que, en grados máximos, alcanzan la complicación en forma de megacolon tóxico. La presencia de inflamación crónica sobre la mucosa del colon se asocia a una mayor susceptibilidad para el desarrollo de neoplasia. La Tabla II (A y B) resume el estadiaje según extensión y gravedad/comportamiento de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Tabla II A
CLASIFICACIÓN DE MONTREAL DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

A. Edad de comienzo *(age)*	A1: comienzo hasta los 16 años inclusive A2: comienzo entre los 17 y los 40 años A3: comienzo por encima de los 40 años
L. Localización *(location)* Para definir un segmento como afecto es necesaria, al menos, la presencia de aftas; no es suficiente que haya lesiones menores, como eritema y edema	L1: afecta al íleon distal, incluyendo si se afecta el ciego por continuidad L2: afecta al colon L3: afecta al íleon distal y colon L4: se añade a cualquiera de las anteriores si se afecta tubo digestivo alto (de boca a íleon proximal)
B. Comportamiento *(behaviour)* Debe permitirse un periodo de observación, ya que hay cambios de B1 a B2 o B3	B1: comportamiento ni estenosante ni perforante B2: comportamiento estenosante B3: comportamiento perforante (incluye la masa abdominal) p: se añade a cualquiera de las anteriores si hay enfermedad perianal

Tabla II B
CLASIFICACIÓN DE MONTREAL DE LA COLITIS ULCEROSA

Extensión	E1: proctitis ulcerosa, afectación limitada al recto E2: colitis izquierda o CU distal, afectación distal al ángulo esplénico E3: colitis ulcerosa extensa/pancolitis, afectación proximal al ángulo esplénico
Gravedad *(severity)*	S0: remisión clínica, asintomático S1: leve, cuatro o menos deposiciones diarias con o sin sangre, ausencia de síntomas sistémicos y marcadores de inflamación normales S2: moderada, cinco o más deposiciones diarias, pero con mínimos signos de afectación sistémica S3: grave, al menos seis deposiciones diarias, taquicardia de más de 90 l.p.m. Temperatura de más de 37,5 °C, hemoglobina menor de 10,5 g/100 ml y VSG mayor de 30 mm/h

Aunque la etiología de la EII sigue siendo incierta, las manifestaciones extraintestinales que comunmente la acompañan podrían justificarse por un componente autoinmune en su fisiopatología. Las manifestaciones extraintestinales más frecuentes son las articulares, afectando tanto a las axiales (sacroileítis, espondilosis anquilosante) como periféricas en dos formas: tipo I (pauciarticular, asimétrica, no erosiva, asociada a los brotes de actividad) y tipo II (poliarticular, simétrica, erosiva, no asociada a los brotes de actividad). Otras manifestaciones son oculares (epiescleritis, uveitis), cutáneas (eritema nodoso, pioderma gangrenoso) o hepatobiliares (conlangitis esclerosante, esteatosis, cirrosis biliar primaria), entre otras. Una vez establecido el diagnóstico y la extensión de la enfermedad, la terapia farmacológica está basada fundamentalmente en la depresión de la respuesta inmune en fases de brote, fundamentalmente mediante corticoterapia e inmunosupresores. La asociación de otros tratamientos como antibióticos, suplementos nutricionales y pre/probióticos es también habitual. La limitación de respuesta al tratamiento y, por consiguiente, la dificultad para el control de la actividad inflamatoria, viene determinada por la dependencia de la terapia con corticoides. Así, la corticodependencia se refiere a la imposibilidad de emancipar el tratamiento de la corticoterapia o de reducir la dosis de los mismos, ya que condicionan la aparición del brote. La corticorrefractariedad se refiere a la falta de respuesta a la terapia con corticoides, a pesar del incremento de la dosis administrada. La necesidad de granuloacitoaféresis para fases de brote de muy difícil control, así como de cirugía de resección intestinal (refractariedad al tratamiento, megacolon tóxico o neoplasia en la colitis ulcerosa) o de resolución de complicaciones derivadas de los brotes inflamatorios de repetición (enfermedad perianal y estenosis intestinal en la enfermedad de Crohn), es ocasional aunque no infrecuente a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad. Recientes avances terapéuticos incluyen el desarrollo de nuevos fármacos biológicos más específicos, así como la utilidad del trasplante fecal para modificación de la flora nativa, piedra angular de la posible etiopatogenia de la EII.

Debido a sus características, el diagnóstico de EII constituye un impacto de gran importancia en el curso vital del paciente, de cuyo correcto manejo puede depender el éxito terapéutico y la minimización de la repercusión de la enfermedad sobre su calidad de vida. A este efecto, las unidades multidisciplinares de enfermedad inflamatoria intestinal constituyen una pieza clave para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad donde, en particular, la enfermería especializada en EII constituye una piedra angular en el proceso asistencial de nexo entre los especialistas integrantes de la misma, así como con el enfermo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

– De la Coba C, Saro C. Epidemiología, herencia y factores de riesgo. En: Todo sobre la enfermedad de Crohn. Manual de ayuda para el paciente. Chaparro M, Gómez S (Coords.) GETECCU.



2

PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES INTEGRALES DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)

Diana Muñoz Gómez

Enfermera de la Unidad de EII. Hospital La Fe. Valencia

DEFINICIÓN Y UNIDADES INTEGRALES Y CONSULTA DE ENFERMERÍA

A la hora de referirnos a la enfermedad de Crohn o a la colitis ulcerosa, si deseamos referirnos a ellas conjuntamente se pueden nombrar como *enfermedad inflamatoria intestinal*, pero también podemos denominarlas como *enfermedad inflamatoria crónica intestinal* (EICI), ya que esta última designación, además de englobarlas, hace hincapié en uno de los aspectos que las definen: la cronicidad. Son numerosas las definiciones que encontramos para enfermedad crónica, pero básicamente podemos indicar que, en medicina, se define como «crónica» aquella enfermedad de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica pero, por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como tal.

Este aspecto es importante y se encuentra incluido como área de actuación clave en el actual Sistema Sanitario de Salud, el cual define estrategias para el abordaje de la cronicidad donde priman la continuidad asistencial, así como la corresponsabilidad y el empoderamiento del paciente en la gestión de la enfermedad. Estos aspectos, unidos a la coordinación y visión integral multidisciplinar de los pacientes, constituyen las piezas clave sobre las que debe girar toda estrategia de cronicidad.

En esta línea la EICI, al igual que previamente otras enfermedades crónicas (diabetes, insuficiencia cardiaca crónica, EPOC, etc.), ha luchado por la integración y existencia de la consulta de enfermería especializada entre sus equipos de asistencia.

Hoy en día en nuestro país, cada vez más hospitales apuestan por la integración de la figura del personal del enfermería de EII como parte del equipo de digestivo, así como por la creación de la consulta de enfermería en unidades especializadas, que se conocen como unidades integrales de atención de Crohn y colitis ulcerosa.

Éstas se definen como unidades que ofrecen una atención especializada, rápida, flexible y multidisciplinar que, además, aportan continuación del cuidado, reforzando aspectos como la atención a demanda. Esta atención viene marcada por las múltiples y oscilantes necesidades de los pacientes, a su vez derivadas de las características propias de ambas patologías, ya mencionadas en el capítulo anterior, como el hecho de que cursen con brotes de inicio incierto y evolución impredecible, precisen de controles periódicos incluso en los momentos de inactividad de la enfermedad, que exista en la mayoría de casos una dependencia que les obligue a tener un tratamiento farmacológico continuado, junto a la posible necesidad de intervenciones quirúrgicas en algún momento de la vida del paciente, etc.

Este tipo de unidades están conformadas por equipos multidisciplinares de especialistas, como recientemente se expuso en la *I Jornada de enfermedad inflamatoria intestinal* «La gestión clínica en EII: en busca de la excelencia», organizada por el Ministerio de Sanidad, el Grupo Español de Trabajo de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), el Grupo Enfermero de Trabajo en EII (GETEII) y la Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis (ACCU). En la Jornada se analizaron algunos de los estándares de calidad obtenidos para las unidades de EII; éstos habían sido consensuados por expertos y pacientes, siendo uno de los marcadores de calidad fijados el hecho de contar entre sus recursos humanos con un equipo de diferentes especialistas, entre los que, al menos, deben encontrarse el gastroenterólogo, enfermería, el cirujano, el radiólogo, el endoscopista y el estomatoterapeuta. Asimismo, no se debe olvidar la importancia de contar con la colaboración de otros profesionales de áreas relacionadas, como endocrinología/nutrición, dermatología, reumatología, oftalmología, farmacia, hospital de día, servicio de preventiva (vacunología), psicólogo o trabajador social

(en los siguientes capítulos de la guía se detallará por qué y en qué momentos los pacientes diagnosticados de EII precisan de la asistencia de estos profesionales).
Otro indicador a remarcar, que es unánime respecto a la calidad, es el hecho de disponer de una consulta de enfermería especializada, ya que juega un papel clave en las intervenciones y programas encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente en las diferentes fases de la enfermedad.
La enfermera/o puede intervenir en diferentes procesos de la enfermedad desde el mismo momento del diagnóstico, con la acogida del paciente, hasta el periodo en el que la enfermedad se encuentra en remisión, proporcionando la información necesaria para mejorar la calidad de vida y, cómo no, en los periodos de exacerbación, facilitando el acceso a tratamientos, pruebas e incluso ingresos hospitalarios. Es muy importante que, durante todo el transcurso de la enfermedad, se establezca un proceso de ayuda, educación sanitaria y seguimiento para favorecer la adaptación del paciente a su nueva situación, necesidades e implicaciones en sus actividades cotidianas.

OBJETIVOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE EII

A nivel europeo, a través de la N-ECCO (ECCO IBD nurse - grupo enfermero formado por representantes enfermeros de diversos países, entre los que se encuentra representación española), quedan definidos en una guía de consenso los objetivos y el papel de la enfermería especialista en EII, denominada como enfermería avanzada:

> *«Declaración 3A/3B: la enfermera avanzada EII es un experto clínico autónomo en la EII, que es responsable de la evaluación y aporte de evidencias basadas en la planificación de los cuidados y la evaluación del tratamiento, y que proporciona una información práctica, educación y el apoyo emocional a los pacientes con EII. Realizará su actividad dentro de su propio ámbito de competencia y responsabilidad, con el apoyo de guías y protocolos.*
>
> *El papel de enfermería avanzada EII incluye la educación, la investigación, el desarrollo de servicios y el liderazgo. Para lograr estas habilidades, una amplia experiencia clínica y el desarrollo de las competencias clínicas, debe ser complementado, a poder ser por una formación de postgrado.»*

En cuanto a las competencias de enfermería que describe la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la enfermería trabajará con la cronicidad en general, y con las personas afectadas de EII de una manera holística, reconociendo e interpretando signos cambiantes de su salud (periodos de remisión y exacerbación), facilitando el contacto con otros especialistas. Asimismo, se describen competencias relacionadas con ser capaz de dar respuesta a las necesidades de los afectados ante situaciones similares a las que se presentan en esta patología, identificando estados de depresión, miedo, ansiedad e incertidumbre, proporcionándoles apoyo y cuidados emocionales que permitan que los enfermos de EII expresen sus preocupaciones e intereses, promoviendo su bienestar.
El modo de organización, tiempo de dedicación a la consulta y dotación de personal, aún hoy en día es bastante diferente entre unidades.

A pesar de la heterogeneidad, a continuación se muestran algunas de las **actividades principales que desarrolla el personal de enfermería en el control y atención de pacientes con EII:**

– Acoger al paciente ante el debut y diagnóstico reciente.
– Valoración de enfermería: en el proceso asistencial se presta una atención integral e integrada basada en el paciente, en el respeto por sus derechos, en la participación en su proceso, en la atención teniendo en cuenta sus necesidades, expectativas y preferencias, en la asunción de su corresponsabilidad en el cuidado de su salud (Anexo I).

  Hay que educar al paciente y a su entorno en promoción de la salud, con la adquisición y refuerzo de hábitos de vida saludables (alimentación, ejercicio, hábito tabáquico, higiene del sueño, etc.) desde cualquier ámbito (hogar, unidad, hospitalización), en cualquier fase de su enfermedad y teniendo en cuenta el abordaje terapéutico.
– Pasar índices de actividad para valorar estado del paciente. Entre los diferentes índices existentes, destacamos los siguientes por su uso más habitual en nuestra práctica clínica (Anexo II).
– Concienciar al paciente y a su entorno sobre la importancia que tiene la adherencia al tratamiento.
– Comprobar el estado de inmunización del paciente (estado de vacunación y enfermedades infecciosas que el paciente haya padecido a lo largo de su vida) antes de comenzar con cualquier tratamiento inmunosupresor y/o terapia biológica. Para ello se colabora con el servicio de medicina preventiva o el médico de atención primaria (programar, actualizar y administrar las vacunas necesarias y el registro de su efectividad).
– Administrar los tratamientos biológicos pautados, vigilando posibles efectos adversos y resolviendo dudas sobre el mismo. En el caso de tratamientos subcutáneos o tópicos, el personal de enfermería se encargará de explicar y adiestrar al paciente para su correcta autoadministración, ofreciendo información para reconocer posibles efectos adversos o signos de alarma.
– Realizar detección y seguimiento de las posibles manifestaciones extraintestinales de la enfermedad.
– Valorar los aspectos psico-socio-laborales, orientando al paciente a los profesionales oportunos para la resolución de dudas y problemas.
– Coordinar las derivaciones sanitarias a las diferentes especialidades y las pruebas diagnósticas que requieren los pacientes para evitar pérdidas de días laborales y/o formativos.

PILARES DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA

1. **Accesibilidad y agilidad:** proporcionando diferentes vías de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.) y de atención (consultas programadas y/o a demanda).
2. **Trabajo en equipo:** relación fluida con miembros directos de la unidad y resto de profesionales que interaccionen con el paciente.
3. **Continuidad de cuidados:** profesionales de referencia que facilitan la comunicación con otros niveles asistenciales (atención primaria, urgencias, hospitalización, domiciliaria) y aquellas especialidades que pueden precisar los pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad.

4. **Escucha empática y apoyo emocional al paciente y familia:** promover un entorno favorable y educar a la persona y a su familia para recuperarse de la enfermedad y afrontar el resto de aspectos psico-emocionales de la EII.
5. **Resolución de problemas:** detección de necesidades, fijar objetivos individualizados, planificar las intervenciones y evaluar los resultados.
6. **Educación hacia la auto-gestión:** fortalecer el empoderamiento del paciente para lograr una mayor autonomía y auto-gestión de su salud/enfermedad.

En conclusión, las unidades multidisciplinares de enfermedad inflamatoria intestinal constituyen una pieza clave para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. En particular, la enfermería especializada en EII puede considerarse una piedra angular en todo el proceso asistencial, ejerciendo tanto de nexo entre los diferentes especialistas, como de apoyo directo al paciente en la gestión de múltiples aspectos de su enfermedad.

Cabe destacar las siguientes acciones de mejora para el desarrollo de nuestra profesión:

1. Fomentar un mayor grado de colaboración y coordinación entre Atención Primaria y Especializada.
2. Promover el desarrollo y estandarización de unidades especializadas en EII. Creación de protocolos y guías.
3. Impulso a la Atención Telemática: mejora del seguimiento, predicción de brotes, adherencia al tratamiento.
4. Promover la investigación.
5. Visibilidad a la enfermería: revistas, publicaciones, asociaciones, herramientas 2.0.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Enfermedad inflamatoria intestinal Crohn y Colitis ulcerosa - ¿Cuál es el papel de la Enfermería en el control de la EII? [Internet] [citado el 29 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.educainflamatoria.com/cual-es-el-papel-de-la-enfermeria-en-el-control-de-la-eii
- Ferrer-Arrendo C, Orozco D, Román P. Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social, 2012. Disponible en : http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf
- García Sanjuan S, Lillo Crespo M, Sanjuan Quiles A, Richart Martínez M. Enfermedad de Crohn, cronicidad y rol enfermero: revisión integradora y estado de la cuestión. Enfermería Global 2014;13(36):323-35.
- GETECCU. I Jornada EII. Gestión de la clínica en busca de la excelencia. Ponencia 03 Dr Xavier Calvet. [Internet] [citado el 29 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: https://www.youtube.com/watch?v=41IQQRd6DSk
- O'Connor M, Bager P, Duncan J, Gaarenstroom J, Younge L, Détré P, et al. N-ECCO Consensus statements on the European nursing roles in caring for patients with Crohn's disease or ulcerative colitis. Journal of Crohn's and Colitis. 1 de octubre de 2013;7(9):744-64.
- Oltra L. Importancia de la enfermería en EII. EII al día; 10(1). Revisiones. Disponible en: http://www.eiialdia.com/2011/05/vol-10-num-1-revisiones-importancia-de-la-enfermeria-en-eii
- Torrejón A, Oltra L, Hernández-Sampelayo P, Marín L, García-Sánchez V, Casellas F, et al. Desarrollo de estándares de calidad para la enfermedad inflamatoria intestinal y diseño de un instrumento de evaluación de los cuidados de enfermería. Rev Esp Enferm Dig 2013;105(5):262-71.

ANEXO I. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

- **Diagnóstico**
- **Alergias - fiebre - infecciones previas - peso**
- **Manifestaciones digestivas:** número de deposiciones, forma, consistencia, con o sin sangre, tenesmo, urgencia, dolor (índices)
- **Manifestaciones extraintestinales:** Articulares y musculares
  Piel
  Ojos y mucosas
- **Calendario vacunal**
- **Tratamiento actual**
- **Medidas higiénico-dietéticas**
- **Aspectos psicosociales:** no aceptación, miedo, tristeza, aislamiento escolar, laboral o social
- **Pruebas pendientes:** preparación, dudas y resultados de las mismas
- **Próxima cita**
- **Resolución de dudas y preguntas**

ANEXO II. ÍNDICES DE ACTIVIDAD

ÍNDICES: enfermedad de Crohn

ÍNDICE HARVEY-BRADSHAW MODIFICADO POR LA OMGE	
VARIABLE	**PUNTUACIÓN**
Número diario de deposiciones	**[1]** por deposición
Dolor abdominal	**[0]** ninguno **[1]** suave **[2]** moderado **[3]** muy intenso
Estado general	**[0]** bueno **[1]** regular **[2]** malo **[3]** muy malo **[4]** terrible
Masa abdominal	**[0]** ausente **[1]** dudosa **[2]** definida **[3]** definida y dolorosa
Manifestaciones extraintestinales	**[1]** por manifestación

(Continúa en la página siguiente)

ANEXO II. ÍNDICES DE ACTIVIDAD

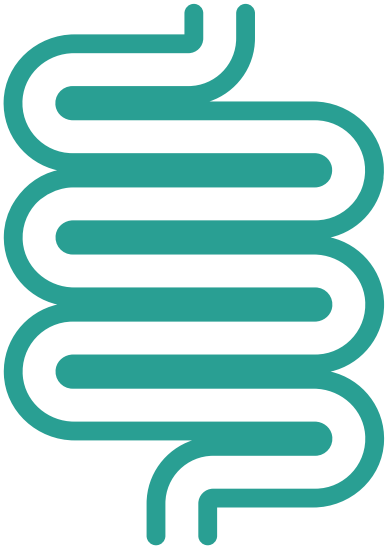
ÍNDICES: colitis ulcerosa

ÍNDICE SIMPLIFICADO DE WALMSLEY	
VARIABLE	**PUNTUACIÓN**
Número diario de deposiciones	**[0]** 1-3 **[1]** 4-6 **[2]** 7-9 **[3]** > 9
Deposiciones nocturnas	**[1]** 1-3 **[2]** 4-6
Urgencia deposicional	**[0]** no **[1]** inmediatez **[2]** incontinencia
Presencia de sangre en heces	**[0]** no **[1]** ocasional **[2]** franca
Valoración global por el investigador	**[0]** buena **[1]** regular **[2]** mala **[3]** muy mala
Manifestaciones extradigestivas	**[1]** por manifestación



3

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



3.1
INTRODUCCIÓN

Marta Gallego Barrero[1] y Francisca Murciano Gonzalo[2]

[1] *Enfermera de la Unidad de EII. Hospital Clínic. Barcelona*
[2] *Enfermera de la Unidad de EII. Hospital del Mar. Barcelona*

La valoración enfermera es un proceso constante. Ocurre, a menudo inconscientemente, en una variedad de escenarios: en la consulta, a través del teléfono, junto a la cama, incluso cuando te encuentras con un paciente en el pasillo. Dependiendo del escenario, el propósito de la valoración será diferente e influirá en el qué, cómo y por qué evalúas.

Saber que se padece una enfermedad crónica desencadena, en respuesta a la adaptación, una serie de reacciones y manifestaciones como la vulnerabilidad, la inseguridad, el miedo o la ansiedad. Vivir con una patología crónica plantea, por lo tanto, nuevos retos. Cada paciente es una persona autónoma que interactúa con el entorno acorde a su personalidad y sus habilidades de afrontamiento, pero éste es un proceso largo que implica entender lo que te ocurre y participar activamente en el cuidado de tu salud.

Como respuesta a ello, nacen las unidades asistenciales de carácter multidisciplinar, y es dentro de este marco donde el papel de la enfermería se constituye como un instrumento clave para garantizar la calidad de la asistencia.

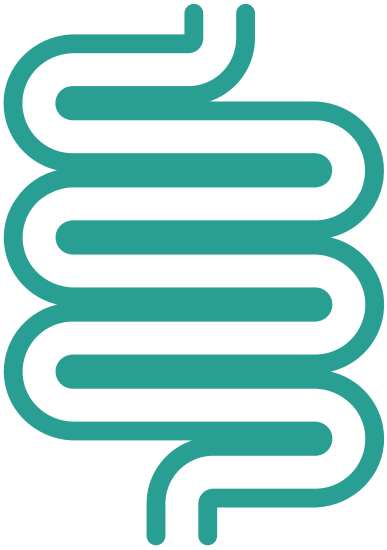
En los últimos años se está produciendo un cambio en el abordaje tradicional de las enfermedades crónicas, como la EII. La aparición de nuevas tecnologías en el campo de la salud está permitiendo acercar la asistencia sanitaria y poner el énfasis del cuidado en el paciente. La accesibilidad de la enfermera de manera continuada, ya sea de forma presencial en la consulta o a distancia vía respuesta telefónica, mediante fax, correo electrónico o portales web, es clave para una asistencia precoz a aquellos pacientes que requieran alguna intervención. Este modelo de atención integral permite dar respuesta de una manera ágil y cómoda a problemas de salud.

Llevar a cabo el proceso de valoración enfermera implica saber qué datos recogidos son relevantes, cuáles son nuestras competencias y cuál es la finalidad que se quiere alcanzar.

En el contexto de los pacientes con EII, el diagnóstico inicial puede ser tardío. Los síntomas poco específicos durante meses o años, su intermitencia y su diversidad son responsables de las dificultades en el diagnóstico, haciendo que el curso y la cronología de la enfermedad no quede clara durante todo ese tiempo. Es posible que el paciente haya sido objeto de numerosas pruebas o diferentes tratamientos y disponga a su diagnóstico de deficiente información, además de poca familiaridad con los recursos para obtenerla. No hay dos enfermos afectados por esta patología que sean iguales, por lo que individualizar y adaptar el enfoque de las intervenciones es fundamental.

Habituarse a vivir con una patología crónica exige paciencia, tiempo, apoyo y ganas de aprender y de participar en el cuidado de la propia salud.

Este capítulo se centra en facilitar recomendaciones a considerar durante la visita de enfermería en el debut, así como en las futuras visitas de seguimiento.



3.2

VALORACIÓN

3.2.1. ACOGIDA AL PACIENTE DE RECIENTE DIAGNÓSTICO

Marta Gallego Barrero[1] y Francisca Murciano Gonzalo[2]
[1]Enfermera de la Unidad de EII. Hospital Clínic. [2]Enfermera de la Unidad de EII. Hospital del Mar. Barcelona

El profesional de enfermería especializado en EII es parte esencial del equipo multidisciplinar y desempeña un papel clave como eje central en la coordinación de la asistencia. Asimismo, proporciona un adecuado aporte de información e implicación de los pacientes en su cuidado a través de las diferentes intervenciones educativas, tal y como determinan los indicadores de calidad recientemente publicados[1].

Además, en las declaraciones de consenso de la N-ECCO[2] (Nurse-European Crohn's & Colitis Organisation) se describen, como parte de las competencias de la enfermería avanzada en EII, evaluar los conocimientos actuales existentes de los pacientes y proporcionar educación para la salud a los pacientes y sus familiares, en función de las necesidades, preferencias y capacidad de afrontamiento de cada persona en concreto.

En relación a estas bases, y dentro del modelo de atención del paciente crónico, el objeto principal de este capítulo es diseñar una guía de actuación en el paciente de reciente diagnóstico, considerando un principio fundamental el desarrollar programas de educación que ayuden a los pacientes a manejar su propia enfermedad, evitar complicaciones, tomar decisiones informadas y mejorar su calidad de vida. En este sentido, se recomienda incluir la educación terapéutica, definida por la Organización Mundial de la Salud[3] (OMS)como parte esencial del tratamiento de enfermedades crónicas como la EII, con un efecto terapéutico en el control de la enfermedad adicional al que producen otras intervenciones (farmacológicas, etc.).

La educación terapéutica será mucho más eficiente si se dispone de un programa de educación estructurado en base a unos estándares de calidad de las actividades educativas donde estén bien definidas la estructura, el proceso y la evaluación del programa[4].

La puesta en marcha de una guía de actuación para el paciente de reciente diagnóstico constituye un abordaje recomendable para mejorar la calidad asistencial del paciente en el debut de la enfermedad, y tiene como objetivo proporcionar respaldo emocional, consejo médico, información sobre la enfermedad y su tratamiento, así como facilitar educación terapéutica estructurada *(ver apartado «2. Algoritmo de actuación»)*. Algunos autores sugieren que el aporte de información al diagnóstico de la enfermedad debería ser relativamente precoz para aportar mayores beneficios. En este sentido se refuerza la idea de diseñar una guía de actuación para el debut de la enfermedad.

OBJETIVOS

Objetivo general: conocer el proceso de cuidado del paciente y familiares en el debut de la enfermedad para favorecer la adaptación a su nueva situación y ofrecer una atención de calidad.

Objetivos específicos:

- Desarrollar habilidades para estructurar visitas de enfermería en el abordaje del paciente de reciente diagnóstico de una EII.
- Conocer el contenido educativo recomendable para abordar en el debut de la enfermedad.
- Reorganizar los conocimientos en relación al cuidado del paciente de reciente diagnóstico.
- Realizar un proceso continuo de actividades educativas que fomente el autocuidado y el apoyo psicosocial del paciente.

ACOGIDA AL PACIENTE DE RECIENTE DIAGNÓSTICO

La educación terapéutica es un proceso que debe formar parte del tratamiento, mediante la cual los pacientes deben contar con información que puedan comprender y utilizar para poder tomar decisiones de manera libre e informada, y que permita ayudarles a manejar su propia enfermedad, evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida.

El procedimiento se inicia tras la primera visita con el gastroenterólogo, cuando el paciente, junto con la familia, es derivado a la consulta de enfermería. Es a partir de este momento cuando empieza el abordaje del paciente desde la perspectiva enfermera.

La primera visita de un paciente a la consulta de enfermería de EII puede ser una experiencia desafiante, tanto para el paciente como para el profesional. Para su éxito, es necesaria la consideración de factores como el entorno social, actitudes, creencias, percepciones y aspectos físicos y emocionales de la persona afectada. Algunos pacientes y sus familiares desean tener mucha información específica; otros prefieren menos detalles. Además, la necesidad de información puede cambiar a medida que el paciente pasa por diferentes momentos, por ejemplo del diagnóstico al tratamiento. Como respuesta a ello es recomendable facilitar documentación escrita que dé soporte a la información verbal proporcionada, así como informar de los recursos electrónicos acreditados a los que los pacientes o familiares pueden dirigirse si desean más información.

La visita de enfermería en el debut de la EII comienza en el momento que se llama al paciente por su nombre en la sala de espera. Observar su postura mientras está sentado, su andar cuando se dirige hacia la consulta, su rostro y gestos, incluso su manera de presentarse, nos proporcionan pistas sobre su estado físico y psicológico. En este breve encuentro, a menudo se puede evaluar que un paciente esté, por ejemplo, ansioso o preocupado. El profesional de enfermería que desarrolla la entrevista debe tener un conocimiento experto sobre la patología, tener habilidades en la educación terapéutica y conocer cuáles son los aspectos que más preocupan a los pacientes, especialmente en el debut de la enfermedad, aportando la información de forma gradual y de una manera clara y concisa, teniendo en cuenta qué aspectos son esenciales abordar justo después del diagnóstico[5,6].

En este primer contacto, que denominamos *visita de acogida,* se explica el funcionamiento del circuito de atención y las vías de acceso. A su vez, se lleva a cabo el diagnóstico educacional y se recogen datos clínicos y socio-demográficos que se muestran en la Tabla I. Posteriormente, se programan las sucesivas sesiones educativas en un tiempo no superior a siete/diez días. El contenido de las sesiones es susceptible de ser adaptado y personalizado de acuerdo a las características y necesidades de cada paciente. El número, duración, temporalización y periocidad de las actividades puede ser modificado en función de los profesionales que la realizan, teniendo presentes los estándares de calidad que se han mencionado anteriormente.

Como sugerencia para el lector de este capítulo, el contenido educativo se agrupa en tres sesiones.

– La *Sesión I* aborda el concepto de EII, las recomendaciones para un buen manejo de la enfermedad, el tratamiento y los hábitos de vida saludables.
– La *Sesión II* aborda el impacto psicosocial de la EII, cómo convivir con la EII y las revisiones de salud y medidas preventivas.
– Finalmente, la *Sesión III* aborda la sexualidad, fertilidad y embarazo, viajes internacionales y EII, y para concluir los recursos y apoyo de los cuales disponen.

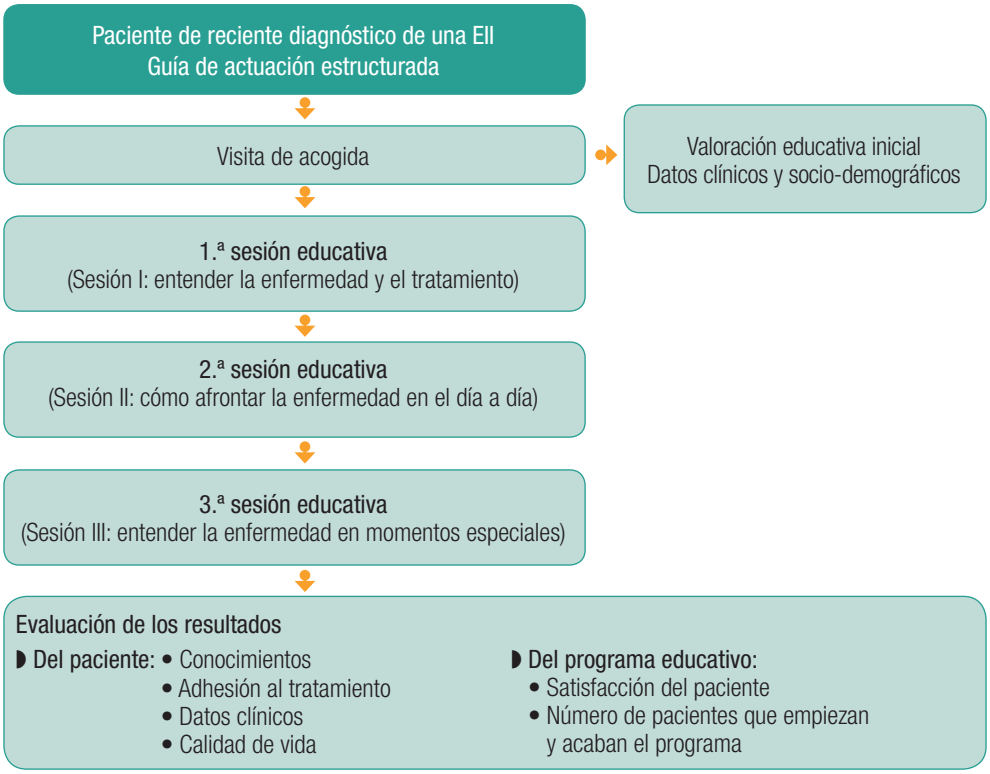
Tabla I
LISTA DE VERIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SOCIO-DEMOGRÁFICAS	ÍNDICES DE GRAVEDAD Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD	INMUNIZACIÓN	CONOCIMIENTOS DE LA ENFERMEDAD
– Diagnóstico – Edad de debut – Antecedentes familiares – Localización y comportamiento de la enfermedad – Síntomas digestivos – Deposiciones (Bristol) – Tratamiento previo/actual – Escala de dolor – Uso de AINE – Cirugías, hospitalizaciones previas – Hábitos tóxicos, alergias – Nutrición/intolerancias – Embarazos/abortos/citologías – Manifestaciones extraintestinales – Descanso nocturno – Ejercicio – Actividad laboral – Nivel de estudios – Estructura familiar – Preocupación o temor – Creencias y calidad de vida	– CDAI, Harvey-Bradshaw, Simple Activity Index, índice Mayo, IBDQ, calprotectina fecal, analítica completa con reactantes de fase aguda	– Conocer historia previa de infecciones[a] – Conocer riesgo de infección activa o latente de TB[b] – Historia de viajes[c] – Carnet de vacunación[d] – Comprobar estado inmunológico[e]	– Comprobar conocimientos del paciente mediante la entrevista utilizando técnicas activas y participativas de educación individual[f]

a. Bacterianas, víricas y fúngicas. b. Conocer Mantoux previo. En caso de resultado positivo, tratamiento realizado. Vacunación previa con BCG. Contacto previo con pacientes infectados. País de origen. Viajes a países donde la tuberculosis (TB) es endémica. Historia de TB latente o activa. Conocer determinación actual Mantoux y/o IGRAs (Quantiferon TB Test). c. Países con alta prevalencia de infecciones endémicas. Planes futuros de viajar a estas zonas. d. Valoración del estado de inmunización (ver apartado «Vacunas»). e. Hepatitis B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs), hepatitis A (IgG hepatitis A), hepatitis C (anticuerpos anti-VHC), virus varicela-zóster (IgG anti-VVZ), parotiditis (IgG anti-parotiditis), rubeola (IgG anti-rubeola), sarampión (IgG anti-sarampión) y virus de la inmunodeficiencia humana (anticuerpos anti-VIH). Rahier. ECCO Statements. JCC 2013. f. Escucha activa. Preguntas abiertas para conocer sus puntos de partida y luego completar con información. Identificar con el paciente sus objetivos y necesidades de salud (conocimiento de la enfermedad, educación, nutrición, tratamiento, derivar a otras fuentes de apoyo, seguimiento, monitorización, apoyo).

La metodología de aprendizaje será activa y participativa, basándose en que el paciente aprenda desde su experiencia, vivencia y preconceptos, reorganizándolos y modificándolos a lo largo del proceso educativo.
Dentro del programa, los objetivos educativos hacen referencia a tres áreas de aprendizaje:
– Los conocimientos sobre la enfermedad (lo que sabe el paciente).
– Las habilidades (lo que sabe hacer), cómo adoptar comportamientos y estilos de vida saludables o desarrollar habilidades para la toma de decisiones ante la aparición de problemas.
– Las actitudes (lo que cree y siente), es decir, la capacidad de afrontar la enfermedad.
Para permitir una continuidad en los cuidados a lo largo del proceso, se debe facilitar una tarjeta informativa en la que conste el nombre de la enfermera/o referente, un teléfono y correo electrónico de contacto, así como el horario de atención. El acceso directo permite una asistencia precoz del paciente ante la sospecha de brote, proporciona refuerzo educativo y afianza la confianza en el equipo asistencial.
La atención de enfermería en el debut es un proceso clave que debe ser evaluado sistemáticamente. Conocer los resultados, la efectividad de los mismos y la satisfacción del paciente nos permite no sólo empatizar con el usuario y familiares, sino proporcionar cuidados de calidad sin olvidar dos aspectos esenciales del ser humano: la dignidad y la privacidad.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN



BIBLIOGRAFÍA

1. Calvet X, Panés J, Alfaro N, Hinojosa J, Sicilia B, Gallego M, et al. Delphi consensus statement: Quality Indicators for Inflammatory Bowel Disease Comprehensive Care Units. J Crohns Colitis 2014;8(3):240-51.
2. O'Connor M, Bager P, Duncan J, Gaarenstroom J,Younge L, Détré P, et al. N-ECCO Consensus statements on the European nursing roles in caring for patients with Crohn's disease or ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2013;7(9):744-64. doi:10.1016/j.crohns. 2013.06.004.
3. World Health Organization. Therapeutic Patient Education Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the Field of Prevention of Chronic Diseases Report of a WHO Working Group; 1998.
4. Bertran MJ, Jansà M, Santiná M, Prat A, Trilla A. Estándares de calidad de actividades educativas dirigidas a pacientes y familiares en un hospital universitario. Rev Calid Asist 2010;26(1):5-11. Doi:10.1016/j.cali.2010.07.002
5. Protheroe J, Rogers A, Kennedy AP, Macdonald W, Lee V. Promoting patient engagement with self-management support information: A qualitative meta-synthesis of processes influencing uptake. Implement Sci 2008;3:44. doi: 10.1186/1748-5908-3-44.
6. Bernstein KI, Promislow S, Carr R, Rawsthorne P, Walker JR, Bernstein CN. Information needs and preferences of recently diagnosed patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2011;17(2):590-8. doi: 10.1002/ibd.21363.

3.2.2. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EN LA CONSULTA

M.ª José Jiménez Barbero
Supervisora de la UGC de Medicina Interna. Hospital Virgen de Valme. Sevilla

Como estamos viendo en los diferentes capítulos, el carácter de cronicidad de la EII hace que se haga sumamente necesario el seguimiento de los pacientes por parte de enfermería, con continuas valoraciones de su estado, desde un punto de vista holístico. Además, se trata de una patología donde se alternan estados distintos de actividad con periodos de brotes y periodos de remisión, recaídas y recidivas, que requieren, por tanto, distintos abordajes terapéuticos. Tanto la aparición de manifestaciones digestivas como extraintestinales obliga a la necesidad de vigilancia por nuestra parte. No debemos olvidar la edad de aparición de esta enfermedad, siendo una edad productiva y/o formativa, lo que genera la necesidad de aceptar su patología y saber resolver las diferentes situaciones que se pueden presentar. Entre los aspectos claves para afrontar de forma efectiva la enfermedad están la información y la toma de control por parte del paciente.

El conocimiento que poseemos de la evolución natural de la enfermedad y la aparición temprana de la misma, hace que el seguimiento de los pacientes en la consulta se convierta en una actividad fundamental de la enfermería.

La consulta, donde se crea un ambiente de cordialidad y confianza, es el lugar más favorable para el seguimiento de estos pacientes y su familia, así como para ofrecerles la educación sanitaria que precisan durante su enfermedad y que, sin duda, ayuda a despejar las dudas que les van a surgir. Así, conseguiremos una mayor adhesión al tratamiento, lo que favorece su evolución y pronóstico.

OBJETIVOS

Objetivo general: proporcionar una atención integral e integrada al paciente y su entorno, con el fin de mejorar la calidad de vida.

Objetivos específicos:

- Proporcionar educación para la salud, tanto a los pacientes como a la familia, desde el debut con la consulta de acogida como de forma continua y constante mediante las consultas de seguimiento.
- Prevenir las posibles complicaciones que puedan presentarse y, en el caso de que aparecieran, detectarlas lo más precozmente posible, minimizando los impactos negativos.
- Diferenciar los síntomas de alarma. La aparición de los brotes es impredecible.
- Conocer su tratamiento y efectos adversos más habituales.
- Fomentar hábitos saludables: dieta, tabaco. Un estilo de vida saludable no evita la aparición de brotes, pero sí nos puede proporcionar mayor bienestar y prolongar los periodos de remisión.
- Coordinar los recursos del hospital con el fin de disminuir las visitas al centro, minimizando el número de urgencias y visitas innecesarias.
- Potenciar la asistencia no presencial para aprovechar las nuevas tecnologías.
- Promocionar y participar en la investigación biomédica.

Con la consecución de todos estos objetivos, lo que se persigue, en definitiva, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entendemos por calidad de vida el bienestar subjetivo del paciente, que está relacionado con las experiencias que le ha tocado vivir, con sus creencias y con las expectativas de cada persona. Para ello existen múltiples cuestionarios sobre calidad de vida, como el IBDQ-9.

La calidad de vida puede mejorar siguiendo diferentes pautas:
- Aceptando y aprendiendo a vivir con la enfermedad.
- Valorando la importancia de los tratamientos desde un punto de vista global, es decir, tanto farmacológico como dietético.
- Manteniendo buena comunicación con los profesionales sanitarios.
- Contando con el apoyo familiar, que cobra gran relevancia en la evolución porque suponen un sustento psicológico importante.

Por el contrario, la calidad de vida se puede ver reducida por otras razones como pueden ser:
- Síntomas y signos de la enfermedad que pueden ser invalidantes. Durante las primeras etapas de la enfermedad y en los brotes es cuando las personas pueden sentirse más vulnerables en los aspectos físicos y psicológicos.
- Efectos secundarios e indeseables de los tratamientos prescritos.
- Dependencia de la consulta y de los profesionales sanitarios.
- Necesidad de realización de pruebas diagnósticas.
- Limitaciones en el día a día, tanto físicas, psíquicas como sociales.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el apartado anterior se describe la valoración que debe hacer la enfermera en la primera visita o la acogida al debut del paciente. Esa visita es muy importante porque puede marcar el devenir de las siguientes consultas.

La principal misión en las consultas de seguimiento, además de la educación de nuestros pacientes, es controlar la eficacia y efectividad del tratamiento así como comprobar y controlar el correcto cumplimiento terapéutico lo que favorece la adhesión.

La monitorización del paciente en la consulta persigue valorar el tratamiento farmacológico, nutricional y psicológico, además de resolver dudas y preguntas.

Este tratamiento persigue que la fase de remisión se haga lo más larga posible en el tiempo, pero es fundamental seguir la pauta indicada por el facultativo, aunque puede invitar a que el paciente se sienta tentado de abandonarlo al encontrarse asintomático. En la fase aguda, lo que se persigue es conocer lo más precozmente posible los síntomas y signos de alarma para poner en marcha su resolución a través de la atención de enfermería, su gastroenterólogo o el servicio de urgencias. De esta manera se evita la hospitalización del paciente y las posibles complicaciones.

Por otra parte, es importante mantener un buen estado nutricional para favorecer la cicatrización de las mucosas y evitar pérdidas de electrolitos y otros nutrientes.

Sin duda, cobra relevancia mantener un buen estado psicológico que ayude a afrontar los distintos estados de la enfermedad.

El equipo de enfermería debe desarrollar todas sus actividades propias de su competencia, es decir:

a. **Actividades asistenciales:**
   La valoración de enfermería basándose en los patrones funcionales de Gordon o en las necesidades de Virginia Henderson, según diferentes centros. Tras realizar esa valoración y la recogida de otros datos de la historia clínica, se formulan los diagnósticos de enfermería, se planifican los objetivos y las intervenciones que, posteriormente, se deben evaluar.
   Hay datos muy relevantes, como la presencia de dolor (escala EVA), el número de deposiciones, la consistencia de las mismas, la presencia o no de sustancias patológicas (moco, sangre, pus, etc.), tenesmo, urgencia defecatoria, manifestaciones extraintestinales, con los índices mencionados en capítulos anteriores.
   En este proceso asistencial es donde se debe prestar una atención integral e integrada basada en el respeto por sus derechos, sin olvidar que el paciente es el eje del sistema sanitario. Debemos promocionar la participación activa del paciente y su familia en el proceso de salud, teniendo en cuenta sus expectativas, necesidades y preferencias, esto es, realizar una atención individualizada, continuada e integral tanto al paciente como a la familia. Para ello, debemos utilizar una información clara, tanto verbal como escrita, y atender al paciente en sus tres dimensiones: biológica, psicológica y social.
   Los cuestionarios de valoración que se utilizaron en el momento del diagnóstico de la enfermedad se deben volver a pasar para reevaluar la situación del paciente transcurrido cierto tiempo.
b. **Actividades docentes:**
   - Educación sanitaria sobre su enfermedad y sus cuidados.
   - Promoción de la salud: adhesión al tratamiento, programas de vacunación, deshabituación tabáquica, nutrición, etc., favoreciendo hábitos saludables.
c. **Actividades de investigación:** participando de forma activa en trabajos científicos, congresos, ensayos clínicos y estudios. Son muchos los datos que se recogen en la consulta que nos aportan conocimiento sobre el cuidado de la enfermedad.
d. **Actividades de gestión:** gestión de citas de consulta y de pruebas diagnósticas, así como la revisión de los resultados y enlace con otros facultativos.

En resumen, el control y seguimiento de la enfermedad en la consulta se deben llevar a cabo una serie de procedimientos, como son:

1. Apoyo emocional y educación sanitaria.
2. Comprobación y revisión de los tratamientos con el fin de detectar alguna anomalía o efectos indeseables del mismo.
3. Citación en el hospital de día para la administración de biológicos.
4. Monitorización del paciente con analíticas.
5. Aprendizaje en el manejo de fármacos de administración subcutánea y posterior seguimiento.
6. Llevar a cabo sesiones clínicas con el facultativo responsable para la puesta en común de la evolución del paciente.
7. Realización de test, cuestionarios e índices para la reevaluación del estado de la enfermedad y del paciente.
8. Supervisar el seguimiento de las consultas y pruebas diagnósticas.

Esta actividad se hace tanto de manera presencial como no presencial. La consulta telemática se ha convertido en una herramienta muy útil entre los profesionales que realizan su labor de seguimiento en las consultas. Esto permite optimizar el tiempo de resolución

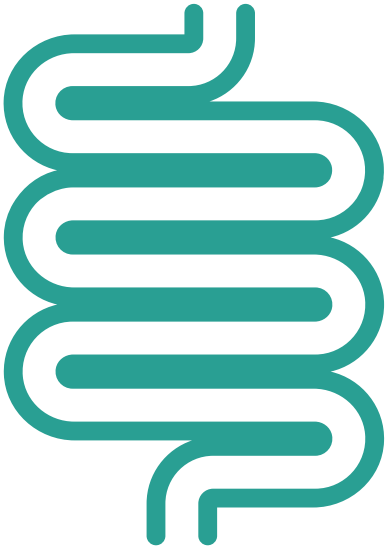
de problemas y dudas prestando al paciente una atención personalizada, directa, rápida y resolutiva, con lo que se trasmite a nuestros pacientes seguridad, tranquilidad y confianza.

CONCLUSIÓN

La Consulta de Enfermería proporciona una atención integral a los pacientes y su familia. Esto ha supuesto unos efectos positivos para la sociedad, tanto para el propio paciente como para el centro sanitario, ya que disminuye los ingresos por urgencias.
Las consultas de seguimiento serán programadas por su enfermera de referencia según las necesidades de cada paciente.
La consulta proporciona:
– Accesibilidad y flexibilidad.
– Dedicación a los aspectos no médicos de la enfermedad.
– Mayor participación del paciente y la familia en su educación sobre la enfermedad y el manejo de la medicación. Se educa en el autocuidado.
– Se trata de un lugar agradable que preserva la intimidad del paciente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

– Amo L, González Y, Suárez C, Blázquez I, Matallana V, Calvo M, et al. Impacto de la incorporación de la enfermera a una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol 2016;39(5):318-23.
– Herrerías JM, Argüelles F, Moreno M, De dios J, Martín R, Domínguez A, et al. Results of a survey about specific inflammatory bowels disease units in Andalusia. Rev Esp Enfer Dig 2009;101(3):187-94.
– Sanromán L, De Castro ML, Hernández V, Pineda JR, Salgado C, Rodríguez JM. Consulta telemática realizada por enfermería en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: valoración de su capacidad resolutiva y costes. Enferm Clin 2014;24(2);102-10.
– Torrejón A, Masachs M, Borruel N, Castells I, Castillejo N, Malagelada JR, et al. Aplicación de un modelo de asistencia continuada en la enfermedad Inflamatoria Intestinal: La IUnidad de atención Crohn-colitis. Gastroenterol Hepatol 2009;32(2);77-82.



3.3

TRATAMIENTOS

3.3.1. AMINOSALICILATOS, ANTIBIÓTICOS, CORTICOIDES E INMUNOSUPRESORES

M.ª Ángeles Marinero Muñoz
Enfermera de Consulta Monográfica de EII. Servicio Digestivo.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Son fármacos usados como terapia de primera línea en el tratamiento de la EII, dependiendo de si la enfermedad se encuentra en brote o en remisión, y cuyo fin es mejorar rápidamente los síntomas agudos, prevenir complicaciones y mantener al paciente el mayor tiempo posible en remisión.

El conocimiento sobre estos fármacos por el personal de enfermería es básico para que el propio personal de enfermería especializado monitorice correctamente su administración.

OBJETIVOS

Objetivo general: conocer el arsenal terapéutico más utilizado, las causas de variabilidad en la respuesta a estos fármacos y sus efectos adversos, para poder asesorar e informar a los pacientes, conseguir la máxima eficacia terapéutica y detectar precozmente posibles efectos secundarios (farmacovigilancia).

Objetivos específicos: para conseguir el objetivo principal, debemos conocer formas de presentación, vías y modos de administración, lugar de liberación y alcance, interacciones con otros medicamentos, efectos secundarios que producen, así como qué parámetros monitorizar y qué medidas preventivas realizar para atajar posibles efectos adversos a corto y largo plazo.

AMINOSALICILATOS

Contienen en su estructura la molécula del ácido 5-aminosalicílico (5ASA). Actúan sobre el epitelio intestinal bloqueando enzimas y moléculas intermediarias en el proceso de la inflamación a su paso por el colon (prostaglandinas y leucotrienos). Utilizados como primer eslabón de tratamiento para inducir y mantener la remisión en la CU con actividad leve-moderada, es cuestionable su efectividad en Crohn colónico pero está demostrado que su uso a largo plazo previene el desarrollo de cáncer colorrectal en pacientes con EII y afectación colónica[1] (Tabla I).

Sulfasalazina

Fueron los primeros utilizados en el tratamiento de CU, pero en la actualidad muy poco prescritos debido a la elevada incidencia de efectos secundarios, en gran parte producidos por la sulfapiridina (transportadora de la molécula 5-ASA). Los efectos adversos aparecen

TABLA I
AMINOSALICILATOS[2]

VÍA	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN COMERCIAL
Vía oral	Sulfasalazina	Salazopyrina® Comprimidos
	Mesalazina	Claversal® Comprimidos Lixacol® Comprimidos Asacol® Comprimidos Mezavant® Comprimidos Pentasa® Comprimidos (500 mg) Pentasa® Comprimidos (1 g) Pentasa® Granulado Sobres (1 g) Pentasa® Granulado Sobres (2 g) Salofalk® Granulado Sobres (1 g) Salofalk® Granulado Sobres (1,5 g) Salofalk® Granulado Sobres (3 g)
Vía rectal	Mesalazina	Claversal® Espuma rectal Claversal® Supositorios Pentasa® Supositorios Pentasa® Suspensión rectal Salofalk® Espuma rectal Salofalk® Supositorios Salofalk® Suspensión rectal

en el 33-50 % de los pacientes, según autores, y son tales como fiebre, cefaleas, vértigos, náuseas, dolor abdominal, ictericia, tos, dolor de garganta, artralgias, cristaluria, formación de cálculos renales y oligospermia (reversible); otros trastornos más graves, como toxicidad hematológica, hepática, renal o cuadros de hipersensibilidad sistémica, obligan a suspender la medicación[3]. Interaccionan reduciendo la absorción de digoxina y ciclosporina, potencian con los tiopurínicos la supresión de médula ósea y leucopenia, y reducen su efectividad con el uso de resinas de colesteramina[4].

Mesalazina

Son fármacos bien tolerados y relativamente inocuos con alto perfil de seguridad. Pueden ser utilizados en el embarazo y la lactancia, y tienen su mayor efectividad en el mantenimiento de la remisión. En las formulaciones orales, las distintas combinaciones y enlaces permiten una liberación del fármaco activo desde el tramo final del intestino delgado hasta el colon distal; la eliminación de la mesalazina absorbida se efectúa por vía renal. Sus efectos secundarios son raros, pero pueden causar náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, cefalea, exantema, urticaria, erupción eritematosa, fiebre medicamentosa, a veces provocan fenómenos de hipersensibilidad (neumonitis, miocarditis o nefritis intersticial) y, en raras ocasiones, pancreatitis, alergias o alteraciones graves. Retrasa la excreción del metotrexato, atenúa el efecto tubeculostático de la rifampicina y el efecto anticoagulante de la wafarina, y potencia el efecto mielosupresor de la azatioprina porque inhibe la enzima TPMT (tiopurina metiltransferasa)[4].

Su formulación galénica permite tanto su uso oral en comprimidos, cápsulas y granulados, como su uso tópico vía rectal en presentaciones de supositorios indicados en rectitis, espumas en rectosigmoiditis y enemas en colitis izquierdas o extensas.

Importante recordar para aminosalicilatos

- En las presentaciones orales no masticar ni machacar. Aplicadas en dosis única mejora adherencia.
- En tratamiento con sulfasalazinas obliga a mantener una ingesta adecuada de líquidos y a realizar tratamiento concomitante con suplementos de folato. Administrada con comida y fraccionando la dosis, mejora los efectos adversos digestivos leves; el uso de colesteramidas reduce su efectividad.
- En tratamiento tópico, la elección del tipo de presentación depende de la localización de la enfermedad; siempre es recomendable en situación de brote.
- Monitorizar la función renal, hepática y recuento hematológico previo al inicio del tratamiento y posteriormente control frecuente (3-4 meses) para las sulfasalazinas y control función renal 1 o 2 veces al año para las mesalazinas[4].

ANTIBIÓTICOS

El ciprofloxacino y el metronidazol son los antibióticos más utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Estos fármacos están indicados para inducir la remisión en la EC perianal o reservoritis, y en situaciones especiales como megacolon tóxico, complicaciones sépticas, absceso abdominal o sospecha de perforación.
El metronidazol es empleado también en prevención de la recurrencia postquirúrgica en la EC.
La duración del tratamiento dependerá de la gravedad y la evolución clínica[3] (Tabla II).

TABLA II
ANTIBIÓTICOS[2]

VÍA	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN COMERCIAL
Vía oral	Metronidazol	Flagyl® Comprimidos
	Ciprofloxacino	Araxacina® Comprimidos Baycip® Comprimidos Cetraxal® Comprimidos Ciprofloxacino EFG® 500 mg Comprimidos Doriman® 500 mg Comprimidos Globuce® 750 mg Comprimidos

Ciprofloxacino

Las reacciones adversas más frecuentes son la disminución del apetito, náuseas, vómitos, diarreas y elevación transitoria de transaminasas. Ocasionalmente se asocia también a tendi-

nitis y roturas de tendón hasta varios meses después de suspender el tratamiento. Puede producir reacciones de fotosensibilidad, por lo que se aconseja evitar exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Interacciona con fármacos como la fenitoína y ciertos anticoagulantes.
Hay que evitar ingerir con productos lácteos y bebidas enriquecidas con minerales porque disminuyen la absorción; también en tratamiento concomitante con omeprazol, porque disminuye su biodisponibilidad[4].

Metronidazol

Los efectos adversos más frecuentes son el sabor metálico en boca e intolerancia digestiva; a largo plazo puede haber efectos más graves, como neuropatía periférica sensitiva (parestesias o adormecimiento de una extremidad), vértigo o confusión mental, y a veces efectos llamativos como diplopía, la cual desaparecerá tras suspender el tratamiento[3]. Presenta una semivida de eliminación de 8 horas.
Hay que administrar durante la comida y tener en cuenta que potencia los efectos de anticoagulantes orales, que el efecto antibiótico se ve disminuido en tratamiento concomitante con fenitoina y que debe evitarse la ingesta de alcohol hasta 3 días después de suspender el tratamiento, ya que puede ocasionar calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor de cabeza o sofocos. Hay que vigilar la función hepática y hay que tener en cuenta que puede interferir en la determinación de valores GOT, GPT, LDH y triglicéridos[4].

CORTICOIDES

Son antiinflamatorios muy potentes usados como tratamiento en brotes moderados y graves de la EII. El 30 % de los pacientes sufre enfermedad refractaria a corticoesteroides y el 30 % se convierte en dependiente. No deben emplearse como tratamiento de mantenimiento.
Provocan efectos secundarios agudos en tratamientos cortos que, principalmente, son estéticos, como aumento de peso y cara de luna por retención hídrica, acné o aumento de vello. También presentan labilidad emocional e insomnio, aumento del apetito, de niveles de transaminasas, de TA, colesterol y glucosa, así como disminución de calcio y vitamina K.
Provocan también efectos secundarios crónicos en tratamientos largos o a altas dosis, como neuropatías, fragilidad de la piel, dolores articulares y musculares, osteoporosis, cataratas, glaucoma, riesgo de infecciones, retraso en el crecimiento y descompensación en pacientes con psicopatologías[4,5].
Precisan de descenso progresivo y tratamiento concomitante con calcio y vitamina D.
Existen corticoides sistémicos y corticoides de baja disponibilidad (Tabla III).

Corticoides sistémicos

Son de acción sistémica (prednisona, metilprednisolona, deflazacort). Para tratar la EII existen presentaciones orales, tópicas, vía rectal e intravenosa, usadas sólo en casos graves. En tratamiento oral precisan de descenso progresivo de 10 mg/día cada 7 días hasta suspender en el caso de la prednisona, o dosis equivalentes para el resto de agentes. El principal inconveniente son los efectos secundarios[6].

TABLA III
CORTICOIDES[2]

VÍA	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN COMERCIAL
Vía oral	Beclometasona	Clipper® Comprimidos
	Budesonida	Intestifalk® Comprimidos Intestifalk® Uno Granulado Sobres Entocord® Comprimidos
	Deflazacort	Deflazacort® EFG 6 mg Comprimidos Deflazacort® EFG 30 mg Comprimidos Dezacor® 6 mg Comprimidos Dezacor® 30 mg Comprimidos Zamene® 6 mg Comprimidos Zamene® 30 mg Comprimidos
	Metilprednisolona	Urbason® 4 mg Comprimidos Urbason® 16 mg Comprimidos Urbason® 40 mg Comprimidos
	Prednisona	Dacortin® 4 mg Comprimidos Dacortin® 30 mg Comprimidos Perdnisona alonga® 5 mg Comprimidos Perdnisona alonga® 10 mg Comprimidos Perdnisona alonga® 50 mg Comprimidos Prednisona EFG 5 mg Comprimidos Prednisona EFG 10 mg Comprimidos Prednisona EFG 30 mg Comprimidos
Vía rectal	Beclometasona	Becloenema®
	Budesonida	Intestifalk® Espuma rectal Entocord® Enema

Corticoides de baja disponibilidad

Son de acción tópica, con menos efectos nocivos y con presentaciones oral y tópica para budesonida y beclometasona. Precisan también de descenso progresivo[2].

Importante recordar para corticoides

– Evitar su uso prolongado.
– Recomendable tomar en ayunas.
– Se puede tomar en dosis única o fraccionada.
– Realizar descenso progresivo y nunca suspender bruscamente.
– Requieren co-tratamiento con vitamina D y calcio, y seguimiento evolutivo de densitometría ósea.
– Control de tensión arterial en pacientes hipertensos y de glucemias en diabéticos.
– Vigilantes ante pacientes con patología psiquiátrica.
– Contraindicados en infecciones víricas agudas (por ejemplo herpes simple, herpes zóster o varicela).

– Precisan de tratamiento concomitante con antibióticos si existen infecciones bacterianas agudas, inhibidores de la bomba de protones si presentan riesgo y antifúngicos si presentan micosis sistémica.
– Evitar su uso en un periodo aproximado de entre 8 semanas antes a 2 semanas después de una vacuna de gérmenes vivos o atenuados[4].

INMUNOSUPRESORES

Los inmunosupresores son fármacos esenciales en el tratamiento de la EII. Inhiben la proliferación de los linfocitos T y B y bloquean su acción. Cada año aumenta el porcentaje de pacientes tratados con ellos y cada vez se utilizan de forma más precoz en un intento por modificar la historia natural de la enfermedad y disminuir el uso de corticoides. Son fármacos seguros con un control adecuado.
Los inmunosupresores (no biológicos) más utilizados en la EII son: tiopurínicos, metotrexato, anticalcineurínicos y micofenolato de mofetilo (Tabla IV).

TABLA IV
INMUNOSUPRESORES[2]

VÍA	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN COMERCIAL
Vía oral	Azatioprina	Imurel® Comprimidos
	Mercaptopurina	Mercaptopurina EFG Comprimidos
	Ciclosporina	Sandimmun neoral® 25 mg Cápsulas Sandimmun neoral® 50 mg Cápsulas Sandimmun neoral® 100 mg Cápsulas
	Metotrexato	Metotrexato EFG 2,5 mg Comprimidos
	Micofenolato de mofetilo	Cellcept® 250 mg Cápsulas Cellcept® 500 mg Comprimidos Micofenolato de mofetilo EFG 250 mg Cápsulas Micofenolato de mofetilo EFG 500 mg Comprimidos Myfenax® 250 mg Cápsulas Myfenax® 500 mg Comprimidos
Vía subcutánea	Metotrexato	Bertanel® Jeringa precargada Metoject® Jeringa precargada
Vía intravenosa	Ciclosporina	Sandimmun concentrado para sol. perfusión 250 mg i.v. 5 ml Sandimmun concentrado para sol. perfusión 50 mg i.v. 1 ml

Tiopurínicos (azatioprina [AZA] y 6-mercaptopurina [6-MP])

Indicados en la EII corticodependiente o refractaria, toxicidad corticoidea, retraso del crecimiento en niños, prevención de la recurrencia postquirúrgica, EC con patrón penetrante, reservoritis refractaria a antibióticos y/o corticoides y enfermedad perianal. Se absorben en

el tracto gastrointestinal alto, se metabolizan en el hígado ayudado por la enzima TPMT y se excretan por la orina.
Tienen como principales inconvenientes un periodo de acción lento (por lo que se debe esperar 6 meses para valorar su eficacia) y presentan una tasa de efectos secundarios del 15 % que obliga a su retirada en el 10 % de los casos. Durante el embarazo y la lactancia no se recomienda suspender.
La dosis se ajusta en función del peso del paciente y de los efectos secundarios; habitualmente se ajusta a dosis de 2,5 mg/kg para AZA y 1,5 mg/kg para 6-MP.
Los efectos secundarios más frecuentes son sintomatología digestiva dispéptica, vómitos, síntomas pseudogripales o exantema. Los problemas digestivos suelen solventarse con el aumento progresivo de dosis hasta alcanzar dosis plenas o, en otras ocasiones, sustituyendo AZA por 6-MP. También tiene otros efectos secundarios como mialgias, mareos, fiebre, artralgias diseminadas y alopecia. Pueden aparecer efectos secundarios más importantes o graves, como alteraciones analíticas hepáticas que obligan a mantener una estrecha monitorización si es leve, a reducir dosis al 50 % si aparecen alteraciones citolíticas, o suspender si aparecen signos de colestasis. La mielotoxicidad generalmente puede aparece en forma de leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y aplasia medular como efecto más grave, el cual puede darse en cualquier momento del tratamiento, siendo más frecuente en los primeros meses y con el uso de 6-MP; ello obliga a reducir o suspender el tratamiento hasta su normalización. La retirada definitiva del fármaco se efectuará si aparece pancreatitis, lo que ocurre en el 1-3 % de los pacientes y no depende de la dosis ni del tiempo de tratamiento.
Interaccionan con el alopurinol y las infecciones víricas cursan con mayor incidencia, por lo que a veces se recomienda la supresión temporal hasta su resolución. También se ha descrito un incremento de riesgo de linfomas, carcinoma basocelular de piel y carcinoma de cérvix[7] (Tabla V y Anexo I).

Importante recordar para tiopurínicos

– Se puede administrar en dosis única y así mejorar adherencia.
– Administrada tras la toma de alimentos y en varias tomas mejora la tolerancia digestiva.
– Hay que monitorizar el peso. Ajustar las dosis en función del peso y los efectos secundarios.
– Durante el embarazo y la lactancia se recomienda no suspender el tratamiento.
– No lactar hasta 4 horas después de la toma.
– Suprimir temporalmente si aparecen infecciones víricas graves.
– Monitorizar la función hematológica y hepática previa al inicio, estricta tras él o si aparecen efectos secundarios, y posteriormente cada 3-4 meses.
– Determinar serología virus Epstein-Barr previa al inicio del tratamiento, fundamentalmente en varones jóvenes.
– Existe reducción de la respuesta inmune a las vacunas. Está contraindicado administrar vacunas con virus vivos o atenuados.
– Se deben realizar medidas preventivas regladas para evitar infecciones oportunistas (vacunaciones antigripales, antineumococo, VPH, VHA, VHB, etc).
– Realizar revisiones ginecológicas regulares a partir de los 25 años.
– Realizar revisión dermatológica anual y aplicar protección solar UVA > 30 para siempre[7] (Anexo I).

Tabla V

EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES DE LOS FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES UTILIZADOS EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

EFECTO ADVERSO	AZATIOPRINA O 6-MP	METOTREXATO	CICLOSPORINA	TACRÓLIMUS
Supresión médula ósea	+ + +	+ +	+	+
Toxicidad gastrointestinal	+ +	+	+	+
Hepatotoxicidad	+	+ + +	-	-
Nefrotoxicidad	-	-	+ + +	+ + +
Neurotoxicidad	-	-	+ +	+ +
Hipertensión arterial	-	-	+ + +	+ +
Dislipemia	-	-	+ +	+
Dermatitis	-	-	-	+ (rash/prurito)
Hirsutismo o hiperplasia gingival	-	-	+	-
Alopecia	+	-	-	+
Linfoma	+	-	+ +	+ +
Hiperglucemia	-	-	+	+
Tumores cutáneos no melanoma	+ +	-	-	-
Mialgias o artralgias	+	+	-	-
Pancreatitis	+ +	-	-	-
Neumonitis	-	+	-	-

Metotrexato

El metotrexato (MTX) es un fármaco teratógeno. Su metabolito es análogo del ácido fólico por lo que, a dosis bajas, posee efecto antiinflamatorio al limitar la proliferación de los leucocitos. Es eficaz para inducir y mantener la remisión en EC luminal activa corticodependiente y refractaria a IMM tiopurínicos. Aún no se ha demostrado su eficacia en la CU. Su efectividad es menor que la de los tiopurínicos y sus complicaciones mayores. En la EII se usa de forma semanal vía s.c. o i.m. Produce efectos secundarios en el 40 % de los casos y obliga a suspender el tratamiento en el 10-15 % de ellos.
Entre los efectos adversos más frecuentes destacan náuseas, vómitos, diarrea, alteración de las enzimas hepáticas, cefalea e infecciones. Son menos frecuentes las artromialgias, las parestesias, la neumonitis o toxicidad medular y osteoporosis, si existe una administración prolongada. El MTX puede potenciar su efecto con la administración de cotrimoxazol, aspirina y AINE, y disminuirse con tetraciclinas cloranfenicol y antibióticos de amplio espectro[7].

Importante recordar para metotrexato

– Administrar una vez por semana en co-tratamiento con ácido fólico vía oral 5-6 días a la semana, excepto el día de la inyección.
– Contraindicado en embarazo y lactancia.
– Obligatorio el uso de método anticonceptivo eficaz para paciente o pareja. Si hay deseo de embarazo, suspender 6 meses antes.
– Contraindicada la administración de vacunas vivas o atenuadas.
– Se deben realizar medidas preventivas regladas para evitar infecciones oportunistas (vacunaciones antigripales, antineumococo, VPH, VHA, VHB, etc.).
– Monitorizar hemograma y función hepática cada 3 meses, o estricta si aparecen alteraciones.

Anticalcineurínicos (ciclosporina y tacrólimus)

Actúan directamente sobre la mucosa intestinal provocando la supresión de mediadores locales de la inflamación (calcineurina). Son fármacos muy utilizados para evitar rechazo en el trasplante de órganos y, a veces, en brotes agudos o graves de CU corticorefractaria, demostrándose que induce la remisión clínica a corto plazo en un 80 % y la mantienen si existe asociación con otro inmunosupresor.
No existe evidencia del uso de ciclosporina en la EC pero sí del tacrólimus en la EC fistulizante y como tratamiento tópico de manifestaciones cutáneas.
Debido a los efectos secundarios se consideran como tratamiento de segunda o tercera línea. Los efectos adversos más frecuentes son la neurotoxidad en forma de convulsiones (sobre todo en pacientes con hipocolesterolemia e hipomagnesemia), la nefrotoxicidad, HTA, dislipemia, hirsutismo y alopecia. Interaccionan con zumo de pomelo y numerosos fármacos (Tabla VI).
La ciclosporina suele emplearse en régimen de hospitalización debido al estricto control de niveles plasmáticos que precisa.

El tacrólimus tiene mayor perfil de seguridad y mayor potencia inmunosupresora que la ciclosporina. No obstante, tiene una aplicación más limitada en cuanto a indicaciones para pacientes con EII.
La toxicidad y la eficacia dependen de los niveles plasmáticos, que son los que determinarán la dosis definitiva[7].

Tabla VI
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN INMUNOSUPRESORES (IMM)

Fármacos interaccionan AZA/6MP
- Alopurinol

Fármacos interaccionan metotrexato
- Cotrimoxazol
- AAS
- AINE
- Tetraciclinas-cloramfenicol
- Antibióticos amplio espectro

Fármacos disminuyen concentr. plásmaticas CyA

Fenitoína	Fenobarbital	Carbamazepina
Bromocriptina	Rifampicina	Nafcilina
Octeotrido	Cotrimoxazol	Isoniazida

Fármacos aumentan concentr. plásmáticas CyA

Macrólidos, eritromicina y fluorquinolonas		
Imipenen/ cilastatina	Antifúngicos	Antagonistas calcio
Corticoides	Acatazolamida	Etanol
Colchicina	Metoclopramida	Andrógenos
Anticonceptivos orales	Danazol	AntiH2
Sulindac	Lovastatina	Zumo de uva

Fármacos nefrotóxicos

AINE	Anfotericina B	Aminoglucósidos
Contrastes i.v.	Metotrexato	

Importante recordar para anticalcineurínicos

– Monitorizar niveles del fármaco; realizar extracción sanguínea justo antes de administrar la dosis pautada.
– Extremar medidas higiénicas y preventivas.
– El tacrólimus vía oral hay que administrarlo 1 hora antes o 2-3 horas después de las comidas.
– Control estricto de TA: su elevación > 150/90 mmHg obliga a reducir la dosis.
– Control analítico estricto de hemograma, bioquímica, función renal y hepática, iones, magnesio, colesterol, albumina y VSG.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pajares JM. Algunas ideas sobre el tratamiento no quirúrgico. En: Pajares JM. Crohn y colitis ulcerosa: comprender para aceptar la enfermedad. 1ª Edición. Madrid: Editorial médica panamericana; 2010. p. 43-62.
2. Centro de información online de medicamentos (CIMA). Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://www.aemps.gob.es
3. Marín Jiménez I, Menchén Viso L. Tratamiento farmacológico. En: Conductas de actuación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Manual práctico Manual práctico. 6ª Edición; 2014. P. 47-68.
4. Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS. [acceso 4 de Abril de 2016].Disponible en: https://www.google.es/?gfe_rd=ssl&ei=_IQSV5yxA4rFaNfJhKAJ#q=agencia+espa%C3%B1ola+del+medicamento.
5. Ponferrada A. Efectos adversos de fármacos en EII.Geteccu.org. [actualizado el 18 de noviembre de 2015; acceso el 4 de abril 2016] Disponible en: http://geteccu.org/pacientes/efectos-adversos-de-farmacos-en-eii
6. Sicilia B, Gomollón F, Vicente R, García S. Tratamiento farmacológico: mecanismo de acción, forma de administración y dosis. En: Conductas de actuación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Manual práctico. 5ª Edición; 2010. p. 55-85.
7. Miguel Medrano A, Marinero Muñoz A, Atienza Sánchez R, Barrio Andrés J. Actuación de enfermería en el seguimiento de fármacos inmunosupresores en la enfermedad inflamatoria intestinal. [Aegastro.es] Madrid: Asociación española de gastroenterología; 2013 [acceso el 28 de marzo de 2016]. Disponible en: http://docplayer.es/15269748-Actuacion-de-enfermeria-en-el-seguimiento-de-farmacos-inmunosupresores-en-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal.html

ANEXO I. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE ENFERMERÍA

Seguimiento de fármacos inmunosupresores

Apellidos			
Nombre		**F. Nac**	
Hª Nº		**Teléfono**	

DIAGNOSTICO	

Valor TPMT	**Fecha inicio:**	**Fecha revisión y dosis**	**Fecha revisión y dosis**	**Fecha revisión y dosis**
AZATIOPRINA				
MERCAPTOPURINA				
METOTREXATE/FOLICO				
CICLOSPORINA				
TACROLIMUS				
BIOLOLGICOS				
QUIMIOPROFILAXIS				

Fármacos interaccionan AZA/6MP
-Alopurinol

Fármacos interaccionan Metotrexate
-Cotrimoxazol
-AINEs
-Antibióticos amplio espectro
-AAS
-Tetraciclinas-Cloramfenicol

Fármacos disminuyen concentr. plásmaticas CyA
-Fenitoína
-Carbamazepina
-Rifampicina
-Octeotrido
-Isoniazida
-Fenobarbital
-Bromocriptina
-Nafcilina
-Cotrimoxazol

Fármacos aumentan concentr. plásmáticas CyA
-Macrólidos, eritromicina y fluorquinolonas
-Imipenen/cilastatina
-Antagonistas calcio
-Acatazolamida
-Colchicina
-Andrógenos
-Danazol
-Sulindac
-Zumo de uva
-Antifúngicos
-Corticoides
-Etanol
-Metoclopramida
-Anticonceptivos orales
-AntiH2
-Lovastatina

Fármacos nefrotóxicos
-AINEs
-Aminoglucósidos
-Metotrexate
-Anfotericina B
-Contrastes iv

ANALITICA	Leucos/Neutr:			
	Plaquetas:			
	VCM:			
	VSG:			
	GOT/GPT:			
	FA/GGT:			
	Bil total/dir:			
	Albúmina:			
	PCR:			
	Calprotectina:			
	Ferritina:			
	Vit B12/Fólic:			
	VHB:			
	HIV:			
	Mantoux/QTF:			
	Rx Tórax:			
	IgG VEB:			

AZA/6MP
-Leucos < 4.000 ó plaquetas < 120.000 → dosis 50%
-Leucos < 3.000 ó neutrófilos < 1.500 → suspender
-Elevación GOT/GPT → reducir dosis 50%
-Elevación FA/GGT o bilirrubina → suspender

Metotrexate
-Elevación GOT/GPT → repetir al mes y si persiste en 3 analíticas consecutivas → biopsia hepática
-Mielotoxicidad

Ciclosporina
-Hipocolesterolemia < 120 mg/dl
-Hipomagnesemia
- Vigilar TA y creatinina

ANEMIA-EII

Vigilar
- Anemia ferropénica
- Ferropenia latente
- Déficit B12-fólico

Mantoux
-Positivo > 5 mm
-Si negativo → Booster
-No determinar QTF 3 días siguientes al Mantoux
- Repetición Mantoux y/o QTF anual

(Continúa en la página siguiente)

ANEXO I. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE ENFERMERÍA
Seguimiento de fármacos inmunosupresores

ANAMNESIS		Fecha revisión	Fecha revisión	Fecha revisión
HABITOS	Alcohol, tabaco, dieta			
CONTACTO PACIENTES	TBC, Varicela			
CONSTANTES FISICAS	Peso, Fc, HTA, nutrición			
ESTADO GENERAL	Fiebre, Pérdida de peso, adenopatías,			
GASTROINTESTINAL	Diarrea, dispepsia, dolor abdominal			
M. RESPIRATORIAS	Tos, disnea, dolor torácico, sibilancias			
M. CUTANEAS	Prurito, exantemas, lesión cutáneas, protección solar			
M. NEUROLOGICAS	Convulsiones, parestesias, cefalea			
REV. GINECOLOGICA	Mét. Anticonceptivo, deseo embarazo, displasia cervical			
GESTACION/LACTANCIA	Sem Gestación, lactancia			

Recomendaciones
-No fumar
-Tomar leche pasteurizada y quesos curados
-Higienizar vegetales frescos
-Evitar agua de fuentes, carnes poco cocinadas, visitas granjas
-Extremar higiene cutánea

Ajustar dosis AZA/6MP: (si no hay contraindicación)
-AZA: 2.5 mg/Kg peso
-6MP: 1.5 mg/Kg peso

Rango terapéutico calcinurínicos (ng/ml)
-CyA 300-400
-Tacrolimus 10-15

Ajuste dosis (Descenso 25%)
-Rango terapeútico
-TA >150/90 sin respuesta Nifedipino
-Aumento creatinina>30% basal

AZA Y 6MP
-Factor protección solar > 30
-Revisión dermatológica anual

Metotrexate
-Usar método anticonceptivo
-Deseo embarazo suspender 3 meses antes ambos sexos

AZA Y 6MP
-Revisión ginecológica anual (displasia cervical)

VACUNACIONES	Fecha vacunación	Tipo vacunación	Fecha revacunación	Fecha última serología
HEPATITIS B				
GRIPE				
NEUMOCOCO				
PAPILOMA				
HEPATITIS A OTRAS VACUNAS				

Gripe
-Vacunación anual
Neumococo
-Vacunación cada 5 años
Papiloma
-9 a 26 años

Reevalución vacunas previas
-Sarampión, Rubeola, Tétanos cada 10 años, VHA cada 10 años
Considera según los casos
-Haemophilus B, Meningococo C, Zoster

VIAJES P. ENDEMICOS	Fecha viaje	Vacunaciones recomendadas	Profilaxis farmacológica	Programar fármacos

3.3.2. BIOLÓGICOS

Ángeles Villanueva Treviño
Enfermera del Servicio de Digestivo. Hospital Universitario La Paz. Madrid

El tratamiento «clásico» de la EII tiene limitaciones; por este motivo surgió la necesidad de nuevos tratamientos.

Estas limitaciones son:

- Durante brote agudo:
  - Cuando los corticoides no controlan el brote.
  - Con el uso de inmunomoduladores (azatioprina/metotrexato), debido a su lento mecanismo de acción.
- En la fase de mantenimiento:
  - Los corticoides no sirven para mantener la enfermedad inactiva a largo plazo y tienen efectos secundarios importantes.
  - Los inmunomoduladores (azatioprina/metotrexato) sólo controlan un porcentaje de pacientes a largo plazo y también producen efectos secundarios.

OBJETIVOS

Objetivo general: conocer las principales características de los fármacos biológicos para su manejo.

Objetivos específicos:

- ¿Qué son los fármacos biológicos?
- ¿Cuándo se utilizan?
- Biológicos aprobados en España para su uso en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
- Conservación.
- Puntos clave antes de comenzar el tratamiento con biológicos.
- Contraindicaciones.
- Olvido de la dosis.
- ¿Qué biológico elegir?

Objetivos docentes: en este capítulo se exponen de forma resumida los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre los fármacos biológicos.

¿QUÉ SON LOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS?

Los fármacos biológicos son un tipo de medicamentos producidos a partir de un organismo vivo, que son útiles en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) para controlar la inflamación en el intestino que causa los síntomas de la enfermedad[1].

¿CUÁNDO SE UTILIZAN?

Los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa moderada o grave pueden necesitar para el control de la inflamación y los síntomas el tratamiento con un fármaco biológico. El médico valorará si el paciente puede beneficiarse de estos medicamentos de forma individualizada según la agresividad de su enfermedad y de cómo haya respondido a otros tratamientos (corticoides, mesalazina, azatioprina, mercaptopurina o metotrexato)[1].

BIOLÓGICOS APROBADOS EN ESPAÑA PARA SU USO EN ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA

Hoy en día disponemos para el tratamiento de la EII de 4 biológicos aprobados en España: adalimumab (Humira®), golimumab (Simponi®), infliximab (Remicade®, Remsima®, Inflectra®, Flixabi®) y vedolizumab (Entyvio®)[2].

Adalimumab (Humira®)[3]

Aprobado para su uso en España desde 2003.

– **Composición:** adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α).
– **Indicaciones:**
  • Enfermedad de Crohn. Humira® está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que no hayan respondido a un tratamiento, completo y adecuado, con corticosteroides y/o inmunosupresores, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas para dichos tratamientos.
  • Enfermedad de Crohn pediátrica: Humira® está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes pediátricos (a partir de los 6 años de edad) que han presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional, incluyendo tratamiento nutricional primario y un corticosteroide y/o un inmunomodulador, o que son intolerantes o tienen contraindicados dichos tratamientos.
  • Colitis ulcerosa: Humira® está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones médicas a dichos tratamientos.
– **Presentación:**
  • Humira® 40 mg solución inyectable en jeringa/pluma precargada.
  • Humira® 40 mg solución inyectable en vial para uso pediátrico.
– **Administración:** se administran por vía subcutánea. La primera dosis debe realizarse en la consulta/hospital de día y, posteriormente, supervisar la habilidad del paciente por parte del profesional sanitario para que el paciente/familiar pueda ponerlo en futuras ocasiones.

Golimumab (Simponi®)[4]

Aprobado en España desde el año 2014.

– **Composición:** anticuerpo monoclonal IgG1κ humano inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α).

– **Presentación:**
  • Simponi® 50 mg solución inyectable en pluma/jeringa precargada.
  • Simponi® 100 mg solución inyectable en pluma/jeringa precargada.
– **Indicaciones:**
  • Colitis ulcerosa (CU): Simponi® está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias.
– **Administración:** se administra por vía subcutánea. La primera dosis debe realizarse en la consulta/hospital de día y, posteriormente, supervisar la habilidad del paciente por parte del profesional sanitario para que el paciente/familiar pueda ponerlo en futuras ocasiones.

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Inflectra®, Flixabi®)[5-8]

Aprobado en España desde el año 2000.
– **Composición:** infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano-murino quimérico.
– **Presentación:**
  • Infliximab 100 mg polvo concentrado para solución para perfusión.
– **Indicaciones:**
  • Enfermedad de Crohn en adultos: infliximab está indicado en:
    - El tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con un corticosteroide y/o un inmunosupresor, o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones médicas a dichas terapias.
    - El tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora).
  • Enfermedad de Crohn en pediatría: infliximab está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, grave, en niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que no han respondido a la terapia convencional, incluidos un corticosteroide, un inmunomodulador y una terapia nutricional primaria, o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias. Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia inmunosupresora convencional.
  • Colitis ulcerosa: infliximab está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias.
– **Administración:** infliximab debe ser administrado por vía intravenosa. Las perfusiones de infliximab deben ser administradas por profesionales sanitarios cualificados, entrenados en la detección de cualquier efecto relacionado con la perfusión.
  Infliximab debe ser administrado por vía intravenosa durante un periodo de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre infliximab se les mantendrá en observación durante, al menos, 1 o 2 horas después de la perfusión debido a las reacciones agudas relacionadas con la perfusión.

Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial.

Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones relacionadas con la perfusión, puede tratarse previamente a los pacientes, por ejemplo, con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol, y se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido previamente reacciones relacionadas con la perfusión.

– **Reconstitución:**

1. Calcular la dosis y el número de viales de infliximab necesarios. Cada vial contiene 100 mg de infliximab. Calcular el volumen total de solución reconstituida de infliximab necesaria.
2. En condiciones asépticas, reconstituir cada vial de infliximab con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una jeringa equipada con una aguja de calibre 21 (0,8 mm) o menor. Retirar el tapón expulsor del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Insertar la aguja de la jeringa en el vial en el centro del tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial.

   Remover con suavidad la solución mediante un movimiento rotatorio del vial para disolver el polvo liofilizado. Evitar la agitación prolongada o vigorosa. NO AGITAR. No es raro que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. Dejar reposar la solución reconstituida durante 5 minutos. Comprobar que la solución sea incolora o amarillo claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas finas partículas translúcidas, ya que infliximab es una proteína. No utilizar si la solución presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas.
3. Diluir el volumen total de dosis de solución reconstituida de infliximab hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. No diluir la solución reconstituida de infliximab con cualquier otro diluyente. Esto puede realizarse extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de perfusión de 250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico igual al volumen de infliximab reconstituido. Añadir lentamente el volumen total de solución reconstituida de infliximab al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml. Mezclar suavemente.
4. Administrar la solución para perfusión intravenosa durante un periodo no inferior al tiempo de perfusión recomendado. Usar sólo un equipo para perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Como no incluye conservantes, se recomienda que la administración de la solución para perfusión intravenosa se comience lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Cuando la reconstitución y dilución se realizan bajo condiciones asépticas, la solución para perfusión de infliximab se puede utilizar dentro de las 24 horas si se conserva entre 2 y 8 °C. No conservar las porciones no utilizadas de solución para perfusión intravenosa para su reutilización.
5. No se han realizado estudios de compatibilidad física bioquímica para evaluar la administración conjunta de infliximab con otros agentes. No perfundir infliximab concomitantemente con otros agentes en la misma línea intravenosa.
6. Antes de su administración, inspeccionar visualmente infliximab en cuanto a partículas o alteración del color. No utilizar si se observan partículas opacas visibles, alteración del color o partículas extrañas.

Vedolizumab (Entyvio®)[9]

– **Composición:** vedolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1 que se une a la integrina $\alpha 4\beta 7$ humana.
– **Presentación:**
  • Entyvio® 300 mg polvo para concentrado para solución para perfusión.
– **Indicaciones:**
  • Colitis ulcerosa: Entyvio® está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta o sean intolerantes al tratamiento convencional o con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα).
  • Enfermedad de Crohn: Entyvio® está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta o sean intolerantes al tratamiento convencional o con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα).
– **Administración:** el tratamiento con Entyvio® debe ser iniciado y supervisado por profesionales sanitarios especialistas con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.
  Entyvio se debe administrar únicamente por vía intravenosa. Se debe reconstituir y diluir antes de la administración intravenosa. Entyvio® se administra como perfusión intravenosa durante 30 minutos. Se debe monitorizar a los pacientes durante y después de la perfusión.
  Vedolizumab se debe administrar en un centro de salud equipado que permita controlar las reacciones de hipersensibilidad agudas, si ocurrieran, incluyendo las reacciones anafilácticas. Cuando se administre vedolizumab se monitorizará adecuadamente al paciente y se tendrán disponibles medidas de apoyo médico para su uso inmediato. Es necesario monitorizar a todos los pacientes de forma continua durante cada perfusión. Además, en las dos primeras perfusiones, es necesario monitorizarlos durante aproximadamente dos horas después de haber finalizado la perfusión para detectar signos y síntomas de reacciones de hipersensibilidad agudas. En todas las perfusiones posteriores se debe monitorizar a los pacientes durante, aproximadamente, una hora después de haber finalizado la perfusión.
– **Reconstitución:** Entyvio® debe estar a temperatura ambiente (20-25 °C) cuando se reconstituya.
  1. Use una técnica aséptica para preparar la solución de Entyvio® para perfusión intravenosa.
     Retire la tapa de apertura fácil del vial y limpie la parte superior con un algodón humedecido en alcohol. Reconstituya vedolizumab con 4,8 ml de agua estéril para inyección, usando una jeringa con una aguja de calibre 21-25.
  2. Inserte la aguja en el vial a través del centro del tapón y dirija el líquido hacia la pared del vial para evitar la formación excesiva de espuma.
  3. Mueva suavemente el vial en círculos durante, al menos, 15 segundos. No lo agite enérgicamente ni lo invierta.
  4. Deje reposar el vial durante unos 20 minutos para permitir la reconstitución y eliminar cualquier resto de espuma; durante este tiempo puede mover en círculos el vial y comprobar la disolución. Si no se ha disuelto completamente al cabo de 20 minutos, déjelo reposar otros 10 minutos.

5. Antes de la administración, inspeccionar la presencia de partículas y de decoloración en la solución reconstituida. La solución debe ser transparente u opalescente, incolora a amarillo pálido y sin partículas visibles. La solución reconstituida que presente un color no característico o contenga partículas no debe administrarse.
6. Antes de retirar la solución reconstituida del vial, inviértalo 3 veces suavemente.
7. Extraiga 5 ml (300 mg) de Entyvio® reconstituido usando una jeringa con una aguja de calibre 21-25.
8. Añada los 5 ml (300 mg) de Entyvio® reconstituido a 250 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9 % y mezcle suavemente en la bolsa de perfusión (no hay que extraer 5 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9 % de la bolsa de perfusión antes de añadir Entyvio®). No añada otros medicamentos a la solución para perfusión preparada o al equipo para perfusión intravenosa.
   Administre la solución para perfusión durante 30 minutos.
   Entyvio® no contiene conservantes. Una vez reconstituida, la solución para perfusión debe utilizarse lo antes posible. Sin embargo, si es necesario, la solución para perfusión puede conservarse durante un máximo de 24 horas. Estas 24 horas de conservación pueden incluir hasta un máximo de 12 horas entre 20 y 25 °C; si se prolonga la conservación, esta debe realizarse entre 2 y 8 °C. No congelar.
   No conservar las cantidades no utilizadas de la solución para perfusión para su reutilización.

CONSERVACIÓN

Infliximab y vedolizumab son de uso hospitalario.
Adalimumab y golimumab deben ser almacenados en la nevera y deben transportarse siempre refrigerados. Hay que conservar en nevera. No congelar. Mantener dentro del embalaje para protegerlo de la luz.
La jeringa/pluma precargada de adalimumab se puede almacenar a una temperatura máxima de 25 °C durante un periodo de hasta 14 días. La jeringa se tiene que proteger de la luz y desechar si no se usa dentro de este periodo de 14 días.

PUNTOS CLAVE ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO CON BIOLÓGICOS (Tablas I y II)

Tabla I

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE INICIO Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON AGENTES ANTI-TNF DE NECROSIS TUMORAL DE GETECCU (GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO)[10]

PROCESOS	ACTITUD CLÍNICA	INDICACIÓN-CONTRAINDICACIÓN DE ANTI-TNF
Infección activa[a]	Fiebre, signos de alarma Cultivo y serologías apropiados	Contraindicación hasta resolución
Absceso abdominal o perianal	Sospecha clínica Pruebas de imagen	Drenaje. Contraindicación hasta resolución
Infección intestinal	Estudio coproparasitario con ausencia de infección por *Clostridium difficile*	Contraindicación hasta resolución
Revisar calendario e indicación de vacunas	Varicela: antecedente o vacunación Serología si antecedentes no conocidos	Vacunas con microorganismos vivos: - Inicio de anti-TNF: contraindicación si no han transcurrido, al menos, 3 semanas - Bajo tratamiento anti-TNF: retirar el tratamiento, al menos, 3 meses antes de la vacunación
TBC[b]	Anamnesis adecuada Radiografía de tórax PPD-booster. Text de interferón (IGRA) especialmente si hay inmunosupresión o vacunación BCG previa	TBC latente: quimioprofilaxis. Inicio anti-TNF no antes de un mes TBC activa: tratamiento. Inicio anti-TNF tras curación o, al menos, 2 meses de tratamiento antituberculoso Paciente en tratamiento anti-TNF: retestar periódicamente (anual)
VHB[c]	Investigar status de la infección: HBsAg, HBcAc, HBsAc Si HBsAg (+) o HBcAc (+) determinar ADN-VHB	HBsAg (+): tratamiento antiviral (al menos desde 2 semanas antes de iniciar anti-TNF) HBsAg (-) y HBcAc (+): monitorizar periódicamente ADN-VHB: si se positiviza tratamiento antiviral
VHC	Serología: si VHC Ac (+), determinar ARN-VHC	No contraindicación. Seguimiento y monitorización de la función y biología hepática
VIH	Determinación IgG-VIH	Contraindicación relativa

(Continúa en la página siguiente)

PROCESOS	ACTITUD CLÍNICA	INDICACIÓN-CONTRAINDICACIÓN DE ANTI-TNF
Herpes	Antecedentes de herpes oral o genital	No contraindica anti-TNF salvo infección grave activa Antiviral oral si hay herpes recidivante
Pneumocystis jirovecii		Quimioprofilaxis con cotrimoxazol si hay triple inmunosupresión
Viajes a zonas endémicas	Fiebre amarilla (vacua de virus vivos) *Strongylodes*: eosinofilia, serología	Vacuna contraindicada si hay inmunosupresión No iniciar inmunosupresión hasta 3 semanas después de la vacunación
Neoplasia previa	Historia clínica	Contraindicación relativa. Individualizar casos. Decisión multidisciplinaria
Enfermedad neurológica desmielinizante	Historia clínica	No recomendable (consulta con neurología si es preciso)
Insuficiencia cardiaca	Sospecha clínica	Contraindicación si moderada-grave (grado III-IV) de la NYHA
Embarazo[d]	Interrogar. Test de embarazo si dudas	Individualizar
Lupus	Historia clínica	No recomendable

a. incluidos infección activa por varicela, virus de Epstein-Barr (VEB), herpes, gripe, infecciones por hongos y parásitos.

b. recomendaciones GETECCU.

c. VHB:

Tratamiento antiviral: lamivudina 100 mg/día, en los casos que se estime un tratamiento corto (< 1 año). El tratamiento debe comenzar 1 o 2 semanas antes de iniciar el anti-TNF y mantenerse durante todo el tiempo que este dure y hasta 12 meses después de su suspensión. Si se espera que el tratamiento con anti-TNF se prolongue más de un año, se recomienda entecavir o tenofovir a las dosis habituales durante el tiempo que dure el tratamiento anti-TNF y hasta 12 meses después de su retirada. *Vacunación de la hepatitis B en todos los pacientes seronegativos:* se sugiere utilizar pauta rápida (0, 1 o 2 meses) con doble dosis dada la alta tasa de fracaso a la vacunación en caso de estar con tratamiento anti-TNF. Comprobar niveles de HBsAc postvacunación y revacunación siguiendo la misma pauta con dosis doble si no se consiguen valores de HBsAc > 100 U/ml tras la primera vacunación.

d. se recomienda que el recién nacido de madre expuesta a anti-TNF no reciba vacunas de virus vivos hasta los 6 meses de vida.

Tabla II
LISTADO DE COMPROBACIONES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES AL INICIO Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON BIOLÓGICO DE LA ECCO (EUROPEAN CROHN'S AND COLITIS ORGANISATION)[11]

BIOLÓGICOS

Comentarios generales:

- «Considerar» significa que la sugerencia de la lista no debe aplicarse automáticamente sino sopesarse con detenimiento.
- Inicio y seguimiento del tratamiento: evaluar la actividad de la enfermedad mediante una u otra de las siguientes medidas combinadas: ileocolonoscopia/endoscopia, proteína C-reactiva, calprotectina fecal, enterografía por resonancia magnética y/o ecografía, según la disponibilidad.
- Control de infecciones: véase la lista de comprobación adjunta que debe cumplimentarse, preferiblemente, en la primera visita y siempre antes del tratamiento inmunosupresor, de conformidad con el consenso de la ECCO sobre infecciones oportunistas.

MEDICACIÓN	ANTES DEL TRATAMIENTO	POSOLOGÍA	SEGUIMIENTO	INTERACCIONES PELIGROSAS	COMENTARIOS
Adalimumab	- Evaluación de infecciones oportunistas conforme a la lista de comprobación de la ECCO - Hemograma completo, creatinina, enzimas hepáticas; la insuficiencia cardiaca o los antecedentes de enfermedad desmielinizante son contraindicaciones relativas del tratamiento	- Dosis de carga subcutánea para la CU o EC con 160 mg; después, 80 mg al cabo de 2 semanas y 40 mg cada 2 semanas a continuación - La subida escalonada de la dosis (40 mg cada semana) puede estar justificada si hay signos objetivos de enfermedad activa o niveles mínimos del fármaco bajos durante el tratamiento	- Vigilar el hemograma completo y las enzimas hepáticas cada 3-4 meses - Vigilar los niveles de fármaco y anticuerpos contra el fármaco cuando sea posible	- Una nueva elevación de las enzimas hepáticas debe llevar a considerar la suspensión del tratamiento si no puede detectarse ninguna otra causa - Los síntomas respiratorios pueden indicar una infección oportunista y deben investigarse - Puede producirse una dermatitis psoriasiforme, como con el infliximab	- Evitar las vacunas vivas - Considerar la repetición de las pruebas de la tuberculosis después de un viaje a una zona endémica - Profilaxis de *P. jiroveci* cuando se utilice inmunosupresión triple - No es aconsejable iniciar el tratamiento durante una infección activa

(Continúa en la página siguiente)

MEDICACIÓN	ANTES DEL TRATAMIENTO	POSOLOGÍA	SEGUIMIENTO	INTERACCIONES PELIGROSAS	COMENTARIOS
Golimumab	- Evaluación de infecciones oportunistas conforme a la lista de comprobación de la ECCO - Hemograma completo, creatinina, enzimas hepáticas; la insuficiencia cardiaca o los antecedentes de enfermedad desmielinizante son contraindicaciones relativas del tratamiento	- Subcutánea solo para CU. Si el peso corporal es < 80 kg, dosis inicial de 200 mg, seguida de 100 mg en la semana 2 y después 50 mg cada 4 semanas - Si el peso corporal es > 80 kg, dosis inicial de 200 mg, seguida de 100 mg en la semana 2 y después 100 mg cada 4 semanas - La subida escalonada de la dosis puede estar justificada si hay signos objetivos de enfermedad activa durante el tratamiento	- Similar al adalimumab	- Similar al adalimumab	- Similar al adalimumab - La monitorización farmacológica no siempre está disponible

(Continúa en la página siguiente)

MEDICACIÓN	ANTES DEL TRATAMIENTO	POSOLOGÍA	SEGUIMIENTO	INTERACCIONES PELIGROSAS	COMENTARIOS
Infliximab	- Evaluación de infecciones oportunistas conforme a la lista de comprobación de la ECCO - Hemograma completo, creatinina, enzimas hepáticas; la insuficiencia cardiaca o los antecedentes de enfermedad desmielinizante son contraindicaciones relativas del tratamiento	- 5 mg/kg por vía intravenosa en las semanas 0, 2 y 6, y después cada 8 semanas para la CU o EC - La subida escalonada de la dosis puede estar justificada dependiendo de las consideraciones clínicas	- Hemograma completo y enzimas hepáticas cada 4-6 meses - Vigilar los niveles de fármaco y de anticuerpos contra el fármaco cuando sea posible y si corresponde	- La anafilaxia durante la infusión contraindica más infusiones - Una nueva elevación de las enzimas hepáticas debe llevar a considerar la suspensión del tratamiento si no puede detectarse ninguna otra causa - Los síntomas respiratorios pueden indicar una infección oportunista - Tener presentes las complicaciones dermatológicas, como la psoriasis palmoplantar, y considerar la suspensión del tratamiento	- Recomendación: tratamiento combinado con tiopurinas - Infundir las primeras 5 dosis durante 2 horas; la duración de la infusión podrá acortarse después conforme al protocolo local - Evitar las vacunas vivas - Considerar la repetición de las pruebas de la tuberculosis después de un viaje a una zona endémica - Considerar la administración intravenosa de ahidrocortisona antes de la dosis si el paciente no está tomando esteroides o tiopurinas - Profilaxis de *P. jiroveci* cuando se utilice inmunosupresión triple - No es aconsejable iniciar el tratamiento durante una infección activa

(Continúa en la página siguiente)

MEDICACIÓN	ANTES DEL TRATAMIENTO	POSOLOGÍA	SEGUIMIENTO	INTERACCIONES PELIGROSAS	COMENTARIOS
Vedolizumab	- Evaluación de infecciones oportunistas conforme a la lista de comprobación de la ECCO	- Infusión intravenosa para la CU o EC - 300 mg i.v. en las semanas 0, 2 y 6, y cada 8 semanas a continuación - La subida escalonada de la dosis (acortando el intervalo posológico) puede estar justificada si hay signos objetivos de enfermedad activa durante el tratamiento		- Se deben investigar los síntomas y signos neurológicos, aunque el perfil de efectos secundarios obtenido a raíz de los ensayos publicados no presenta diferencias con respecto al placebo	- Infusión durante 30 min - Aporta una inmunosupresión específica del tracto digestivo

CONTRAINDICACIONES

Las principales contraindicaciones están expuestas de forma general en la Tabla III. Sin embargo, algunos aspectos, bien por las últimas novedades, bien porque los datos son contradictorios, merecen ser tratados individualmente[10].

Tabla III
CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DEL TRATAMIENTO CON AGENTES ANTI-TNFα DE NECROSIS TUMORAL[10]

Absolutas	Alergia a proteínas de origen murino (para IFX) Insuficiencia cardiaca congestiva moderada-grave Enfermedades neurológicas desmielinizantes Infecciones bacterianas activas (especial atención a abscesos) Infecciones virales activas no tratadas (especial atención al VHB) TBC activa o latente no tratada Vacunación reciente (< 3 semanas) con gérmenes vivos
Relativas	Reacciones graves previas al fármaco Estenosis intestinales no inflamatorias Infección por VIH Lupus eritematoso sistémico Antecedentes de neoplasia (individualizar casos)

OLVIDO DE LA DOSIS

Si un paciente olvida acudir a su cita para poner la dosis de infliximab y vedolizumab, deberá ponerse en contacto lo antes posible con el hospital de día para concertar una nueva cita lo antes posible[5-9].
Si un paciente olvida inyectarse adalimumab o golimumab, debe ponérsela tan pronto como sea posible y continuar el tratamiento según calendario habitual. No usar una dosis doble para compensar la dosis olvidada[3,4].
En el caso del golimumab, la siguiente dosis se debe administrar conforme a las siguientes recomendaciones:
– Si la dosis se ha retrasado menos de 2 semanas, el paciente debe inyectarse la dosis olvidada y mantener su calendario original.
– Si la dosis se ha retrasado más de 2 semanas, el paciente debe inyectarse la dosis olvidada y se debe establecer un nuevo calendario a partir de la fecha de esta inyección.

¿QUÉ BIOLÓGICO ELEGIR?

Es importante conocer las preferencias de los pacientes con respecto al tratamiento, involucrar al paciente en la toma de decisiones sobre él y hacer que juegue un papel activo en el manejo de su enfermedad. A la hora de elegir el tipo de tratamiento biológico debemos tener en cuenta una serie de factores:
– **Eficacia:** según estudios realizados, hasta la fecha infliximab y adalimumab presentan similar eficacia[12].
– **Seguridad:** efectos secundarios similares con infliximab y adalimumab[12].
– **Preferencias del paciente:** considerar si para el paciente es importante depender del hospital para el tratamiento y cómo interfiere en su vida diaria. También si será capaz de autoinyectarse la medicación, o si tiene familiares/amigos que lo hagan si fuera necesario. Conocer el grado de seguridad del paciente respecto al tratamiento, y su compromiso y cumplimiento.
– **Otros:** nos referimos a la inmunogenicidad del paciente (anticuerpos generados por nuestro cuerpo que bloquean y anulan el efecto de los biológicos). Su aparición se relaciona con reacciones alérgicas y pérdida de respuesta al tratamiento. Se puede evitar, con el uso conjunto de inmunomoduladores.

También condiciona la elección del fármaco su disponibilidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Moreira VF, Garrido E. Fármacos biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal: indicación y cuidados. Rev Esp Enferm Dig 2015;107(6):389.
2. https://www.aemps.gob.es
3. Ficha técnica de Humira®.
4. Ficha técnica de Simponi®.
5. Ficha técnica de Remicade®.
6. Ficha técnica de Remsima®.

7. Ficha técnica de Inflectra®.
8. Ficha técnica de Flixabi®.
9. Ficha técnica de Entyvio®.
10. Cabriada JL, Vera I, Domenech E, Barreiro-de Acosta M, Esteve M, Gisbert JP, et al; Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). Recomendaciones del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa sobre el uso de fármacos antifactor de necrosis tumoral α en la enfermedad inflamatoria intestinal (2013). Gastroenterol Hepatol 2013;36(3):127-46. DOI: 10.1016/j.gastrohep.2013.01.002.
11. https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/toolkits.html
12. https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/ecco-guidelines-science/published-ecco-guidelines.html

3.3.3. AFÉRESIS TERAPÉUTICA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Juan Francisco Pulido Pulido
Jefe de Unidad de Enfermería. Servicio de Nefrología.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

La aféresis terapéutica para el tratamiento de la enfermedad intestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn) es una técnica que consisten en hacer pasar la sangre del paciente por una columna o filtro, en la que mediante un proceso de adsorción se quedan pegados los monocitos, macrófagos y leucocitos de la sangre y los niveles de mediadores inflamatorios (TNF-α, IL-6, IL-8 y IL-1b), que son los causantes del cuadro de inflamación de la mucosa intestinal.

Está indicada en pacientes con enfermedad moderada-severa, refractarios a otros tratamientos o con efectos secundarios a los mismos.

Existen dos técnicas de aféresis que se diferencian en el material adsorbente empleado en la columna:

- Granulocitoaféresis: la sustancia adsorbente son esferas de 2 mm de diacetato de celulosa, consiguiendo una reducción del 65 % de granulocitos y 58 % de monocitos/macrófagos.
- Leucocitoaféresis: la sustancia adsorbente es una malla de poliéster, consiguiendo una reducción del 90 % de granulocitos y un 70 % de monocitos/macrófagos.

Las dos columnas han demostrado tener una respuesta equivalente en los pacientes con enfermedad inflamatoria.

Para la realización de la técnica es necesario que el paciente posea un adecuado acceso vascular. El paciente necesita una vena periférica en ambos brazos, y si sólo tuviera una o ninguna, sería necesaria la colocación de un catéter central para que la técnica se lleve siempre a cabo. Es imprescindible que, antes del tratamiento, se evalúen las venas por parte de la enfermera que va a realizar la técnica.

La aféresis está contraindicada en los casos de anemia grave, enfermedad cardiaca y renal y en los pacientes alérgicos a la heparina. Son técnicas seguras para los pacientes, con escasos efectos adversos (hipotensión y pérdida del acceso vascular).

La técnica de aféresis se realiza 1-2 veces a la semana durante cinco semanas consecutivas. Luego se debe evaluar al paciente y, si fuera necesario, puede quedarse en tratamiento de mantenimiento de una vez al mes, según la indicación del médico.

OBJETIVOS

Objetivo general: realizar la técnica de aféresis terapéutica con la máxima efectividad.

Objetivos específicos: garantizar la seguridad y la tolerancia del paciente al tratamiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento será realizado por el personal de enfermería y un auxiliar de enfermería.

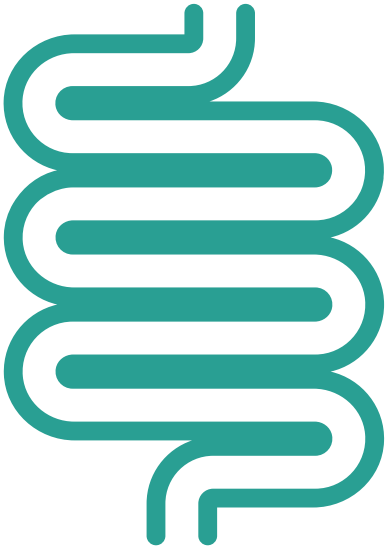
1. Realice un correcto lavado de manos antes y después de cada intervención directa con el paciente y/o su entorno (monitor, cama o sillón, carpetas).
2. Compruebe la identidad del paciente.
3. Verifique el tratamiento prescrito.
4. Prepare el monitor instalando el set de líneas y columnas, extremando las medidas de asepsia.
5. Proceda al cebado del circuito (los monitores poseen un programa de cebado automático).
6. Cebamos línea arterial hasta extremo de conexión al filtro, paramos la bomba y luego conectamos a la columna, al estar las columnas precebadas.
7. Terminamos el cebado y pinzamos las líneas.
8. Preséntese al paciente.
9. Valore el estado hemodinámico del paciente, controlando las constantes vitales.
10. Canalice una vena en ambos brazos del paciente con agujas o catéteres del número 16 o 17, con las técnicas asépticas precisas.
11. Si fuera necesario la utilización de un catéter venoso central, conectar según protocolo hospitalario.
12. Proceda a la conexión del paciente de ambas ramas (arterial y venosa) sin desechar la solución de cebado del circuito, y a un flujo de sangre de 20 ml/min.
13. Pulsar aféresis o inicio cuando la sangre esté a punto de alcanzar el extremo superior del filtro o columna.
14. Subir flujos o automáticamente se sube (según monitor y programación) a 30 ml/min y el tiempo de duración del tratamiento es de 60 minutos. La cantidad de sangre a tratar es de 1.800 cc.
15. Administrar dosis de heparina inicial prescrita.
16. Conectar la bomba de heparina a 15 ml/h (5.000 UI de heparina sódica en 50 cc de suero fisiológico 0,9 %).
17. El flujo de sangre ha de estar entre 20 y 30 ml/min para que los granulocitos, monocitos y macrófagos puedan unirse a la sustancia adsorbente. El tiempo aumentará automáticamente en función del lujo obtenido.
18. Controle las constantes vitales del paciente post-conexión y cada 30 minutos, o según las necesidades durante toda la sesión.
19. Registre cada 30 minutos el volumen de sangre tratado.
20. Revise periódicamente la cámara venosa del circuito, detectando precozmente la formación de coágulos, y modifique la pauta de anticoagulación si es preciso.
21. Proceda a la desconexión ante la aparición de complicaciones técnicas, por orden médica ante la aparición de complicaciones clínicas, o cuando el objetivo de tratamiento se haya alcanzado.
22. Retornar la sangre con suero fisiológico y/o aire dependiendo de la columna.

23. Desconectar las líneas y coagular al paciente o cerrar el catéter venoso central según protocolo hospitalario.
24. Registre las actividades realizadas, fecha y profesionales que las han llevado a cabo.
25. Compruebe que el material utilizado es depositado en los contenedores adecuados.

Hay que extremar las precauciones al realizar el cebado del circuito, completando el programa establecido por el fabricante del equipo, evitando dar golpes en la columna con la finalidad de eliminar todo resto de aire existente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Cabriada JL. La aféresis en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Una opción válida? Gastroenterol Hepatol 2012;35(1):22-3.
- Fernández Lomana AF. Aféresis terapéutica. Madrid: Norma-Capitel; 2005.
- Fernández Lomana AF. Manual de aféresis terapéutica basada en la evidencia. Editorial Plus Medical; 2012.
- Nos P, Domenech E. Tratamiento con aféresis en la enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol 2009;01:183.



3.4

INTERVENCIONES

3.4.1. ADHESIÓN AL TRATAMIENTO

Pilar Pinilla San Martín
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la relevancia de la adhesión al tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). La idiosincrasia de esta patología confiere mayor riesgo de falta de cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas, lo que implica mayor probabilidad de recaída. Los profesionales sanitarios debemos tener presente cómo prevenir, detectar y corregir la falta de adhesión al tratamiento.

El papel de la enfermería en el cuidado de pacientes crónicos como los de EII es fundamental. Existen varios estudios que evidencian la trascendencia de su labor en las intervenciones para mejorar su calidad de vida[1]. Una parte de estos cuidados se relaciona con la adhesión al tratamiento.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Conocer la importancia de la adhesión al tratamiento.
- Aprender estrategias para mejorarla.

Objetivos específicos:

- Distinguir adhesión y cumplimiento.
- Entender las consecuencias de la falta de adhesión.
- Reconocer los factores que influyen en la falta de adhesión.

DEFINICIÓN DE ADHESIÓN AL TRATAMIENTO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adhesión como el grado de concordancia de la conducta del paciente con los consejos sanitarios recibidos[2]. Se trata de un concepto amplio que incluye, además del cumplimiento del tratamiento médico, la aplicación de modificaciones en el estilo de vida y un compromiso para que el resultado del tratamiento sea óptimo. Además implica que las decisiones médicas tienen en cuenta la opinión del paciente. El cumplimiento hace referencia al paciente como sujeto pasivo, mientras que la adhesión lo involucra en el control de su enfermedad. El término adhesión (del inglés *adherence)* es más correcto que adherencia, que no incluye entre sus acepciones estos conceptos.

IMPORTANCIA DE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO

Si bien no podemos asegurar una buena evolución cuando el paciente sigue todas nuestras recomendaciones terapéuticas, la falta de adhesión aumenta las probabilidades de recaída

y complicaciones. Se ha constatado que el grado de cumplimiento es proporcional a las probabilidades de mantenimiento de la remisión[3]: los pacientes cumplidores se mantienen más tiempo libres de brote[4]. Por tanto, la falta de adhesión implica una mayor probabilidad de hospitalización.
Otros efectos no deseables son el aumento de resistencias bacterianas como consecuencia del mal cumplimiento del tratamiento antibiótico, o el incremento del riesgo de cáncer colorrectal debido a un peor control de la inflamación. Obviamente, todo ello tiene una importante repercusión en el gasto sanitario[5].

FACTORES PREDICTIVOS DE FALTA DE ADHESIÓN

La EII tiene ciertas características que hacen que la falta de adhesión o cumplimiento sea más frecuente entre sus pacientes. Se trata de una enfermedad crónica, lo que implica tratamientos (con sus potenciales efectos secundarios) de larga duración. Además se diagnostica en muchos casos en pacientes jóvenes, que se ven obligados a hacer modificaciones en varias esferas vitales y de por vida. Por otro lado, el curso de la enfermedad en forma de brotes alterna periodos con síntomas con otros de inactividad. El cumplimiento de la medicación de mantenimiento precisa de especial confianza en el equipo sanitario, ya que el paciente deberá tomar los fármacos encontrándose bien sin observar un resultado tangible. Según datos de la OMS, las enfermedades crónicas sólo alcanzan tasas de falta de adhesión a largo plazo de un 50 %[2] y aumentan significativamente a partir de los primeros 6 meses de tratamiento[6]. En el caso de la EII, se han comunicado cifras superiores al 40 %[7], por lo que es recomendable investigar de forma rutinaria la falta de adhesión en cada visita de seguimiento. Esto es especialmente importante en el escenario de falta de respuesta de una medicación, donde es posible que la causa sea que el paciente (de forma voluntaria o no) no esté tomando la medicación o lo esté haciendo mal. Para ello conviene conocer los factores de riesgo, que se pueden agrupar de la siguiente manera[8]:

– Factores relacionados con la enfermedad:
  - Enfermedad leve (inactiva, poco extensa) y de larga evolución (adultos).
  - Enfermedad grave (adolescentes).
  - Reciente diagnóstico.
– Factores relacionados con el paciente:
  - Adultos varones, solteros o sin relación estable.
  - Empleados a tiempo completo.
  - Depresión, ansiedad.
  - Menor calidad de vida.
  - Tabaquismo.
– Factores relacionados con el tratamiento:
  - Múltiples fármacos.
  - Varias tomas al día.
  - Administración rectal.
  - Pastillas grandes, mal sabor de la medicación.
  - Efectos adversos (reales o potenciales).
– Factores relacionados con la relación del personal sanitario con el paciente:
  - Pacientes poco informados.
  - Desconfianza en el personal que le atiende.

CÓMO IDENTIFICAR LA FALTA DE ADHESIÓN

Si bien hay métodos fiables como la medición de niveles de fármacos (tacrólimus o ciclosporina) o sus metabolitos (nucleótidos de 6-tioguanina para los tiopurínicos) en sangre o en orina (salicilatos), su papel es poco relevante en la práctica por su escasa disponibilidad y su elevado coste. En ensayos clínicos se utilizan métodos indirectos como recuento de pastillas o pastilleros de apertura controlada, que también son poco aplicables en la práctica.
Lo más sencillo es preguntar al paciente directamente en cada visita, que en general nos dará una respuesta sincera. Debemos ser cuidadosos en la manera de preguntar, ya que cuestiones como «¿tiene olvidos de alguna dosis?», «¿toma siempre las medicaciones a la misma hora?» o «¿con qué frecuencia se olvida una dosis cada semana?» permitirán detectar más defectos de cumplimiento que una pregunta general como «¿está usted tomando la medicación?»[9]. Es conveniente limitar la respuesta a un marco temporal concreto: por ejemplo, la última semana o mes. Durante la entrevista, la familia o acompañantes del paciente también nos podrán ayudar a esclarecer si el cumplimiento es adecuado. También se pueden usar cuestionarios dirigidos, como el de Morisky-Green[10], validado en la población española, que consta de 4 preguntas sencillas:
1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?

Otros métodos indirectos son el registro de la dispensación de farmacia o la identificación de alteraciones en parámetros analíticos inducidos por el fármaco. Por ejemplo, las tiopurinas en ocasiones producen macrocitosis y/o hiperbilirrubinemia; sin embargo su inconstancia no permite usarlas con total confianza.
Es recomendable que utilicemos dos métodos para la evaluación de la adhesión según las posibilidades de cada centro, especialmente en pacientes con factores de riesgo o no respondedores.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHESIÓN

En el caso de la EII es de máxima importancia establecer una relación de confianza mutua entre el paciente y el personal sanitario. La falta de satisfacción del paciente disminuye su adhesión, lo que empeora su salud, con lo que se deteriora la relación y de nuevo disminuye la satisfacción, cerrando así un círculo vicioso. Es fundamental la empatía: debemos ser capaces de ponernos en el lugar del paciente e intentar comprender los motivos que le llevan a no cumplir o cumplir parcialmente nuestras recomendaciones. El diagnóstico de la EII supone un gran impacto emocional: además de haber sufrido un deterioro en su salud, el paciente se ve obligado a modificar hábitos, es expuesto a efectos adversos, en algunos casos disminuye su calidad de vida, etc. Esto a veces va acompañado de síntomas de ansiedad y depresión que debemos saber reconocer para actuar precozmente. Es primordial que el paciente se sienta escuchado, acogido y comprendido, y que este clima de confianza se instaure desde la primera visita. De esta manera expondrá abiertamente sus problemas y responderá mejor a las intervenciones que se le propongan. Es importante tener en cuenta que debemos evitar culpabilizar a los pacientes, ya que sólo conseguiremos desmotivarlos y empeorar la relación. Por otro lado, estimular a los buenos

cumplidores felicitándolos y reconociendo su esfuerzo nos ayudará a mantener la adhesión. La Figura 1 resume la actuación en la consulta de enfermería respecto al manejo de la adhesión al tratamiento.

A la hora de afrontar un caso de falta de adhesión debemos, en primer lugar, identificar la causa. Puede deberse a barreras mentales (por ejemplo, creencias erróneas sobre la enfermedad o preocupación por los posibles efectos adversos) o a cuestiones prácticas (por ejemplo, horarios laborales). De cara al diseño de la estrategia para mejorar la adhesión, debemos individualizar cada caso teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad, respuesta a tratamientos previos, historia de efectos adversos, estilo de vida, trabajo, características del núcleo familiar, etc. En este sentido es clave la opinión del enfermo. En los últimos años el concepto de empoderamiento del paciente se ha popularizado, entendiendo como tal la participación del paciente, adquisición de conocimientos, asociación y toma de decisiones compartidas. Cuando el paciente participa en el manejo y se implica en la toma de decisiones sobre su enfermedad, se hace responsable de ella. Es decir, acepta como propio el planteamiento terapéutico y, por tanto, es más difícil que lo abandone.

Las estrategias específicas para aumentar la adhesión se pueden dividir en educacionales y conductuales. El primer grupo se refiere a los métodos para conseguir que el paciente esté bien informado sobre su enfermedad. El segundo, a las modificaciones de hábitos. Habitualmente es necesario aplicar más de una intervención. Se resumen en los siguientes puntos.

Estrategias educacionales

- Discutir el tiempo suficiente y con un lenguaje llano la necesidad de un tratamiento, los efectos esperados y los posibles efectos secundarios.
- Insistir en la necesidad de no suspender un fármaco por decisión propia.
- Asegurarnos de que el paciente comprende lo que le explicamos.
- Reforzar la información con material escrito, como folletos informativos.
- Disponer de una línea para consultas telefónicas o por correo electrónico.
- Tener en cuenta la opinión del paciente cuando se toma una decisión sobre el manejo o tratamiento de la enfermedad.
- Promover la asistencia a grupos didácticos, charlas o coloquios en asociaciones de pacientes.
- Entregar una lista de páginas web, redes sociales y comunidades virtuales con información de confianza.
- Enseñar al paciente a actuar frente a un brote.
- Informar sobre signos y síntomas de alarma en caso de brote[11].

Estrategias conductuales

- Disponer de consultas monográficas que permitan una valoración rápida en caso de brote.
- Simplificar la posología: las formulaciones que requieren una toma al día son más fáciles de cumplir que las que requieren varias. De hecho, en un estudio la eficacia fue mayor, probablemente por un mejor cumplimiento[12].
- Tener visitas programadas.

– Alarmas-recordatorio en el teléfono móvil, aplicaciones móviles, envío de SMS o correos electrónicos.
– Colocar la medicación cerca de objetos de uso diario (por ejemplo, cepillo de dientes).
– Pastilleros con calendario.

La falta de adhesión requiere un abordaje multidisciplinar donde el papel del médico y la enfermería son preponderantes. El personal de enfermería es clave para dar información, apoyo emocional, facilitar una actitud proactiva del paciente en el control de la enfermedad y fomentar la confianza en el equipo asistencial.

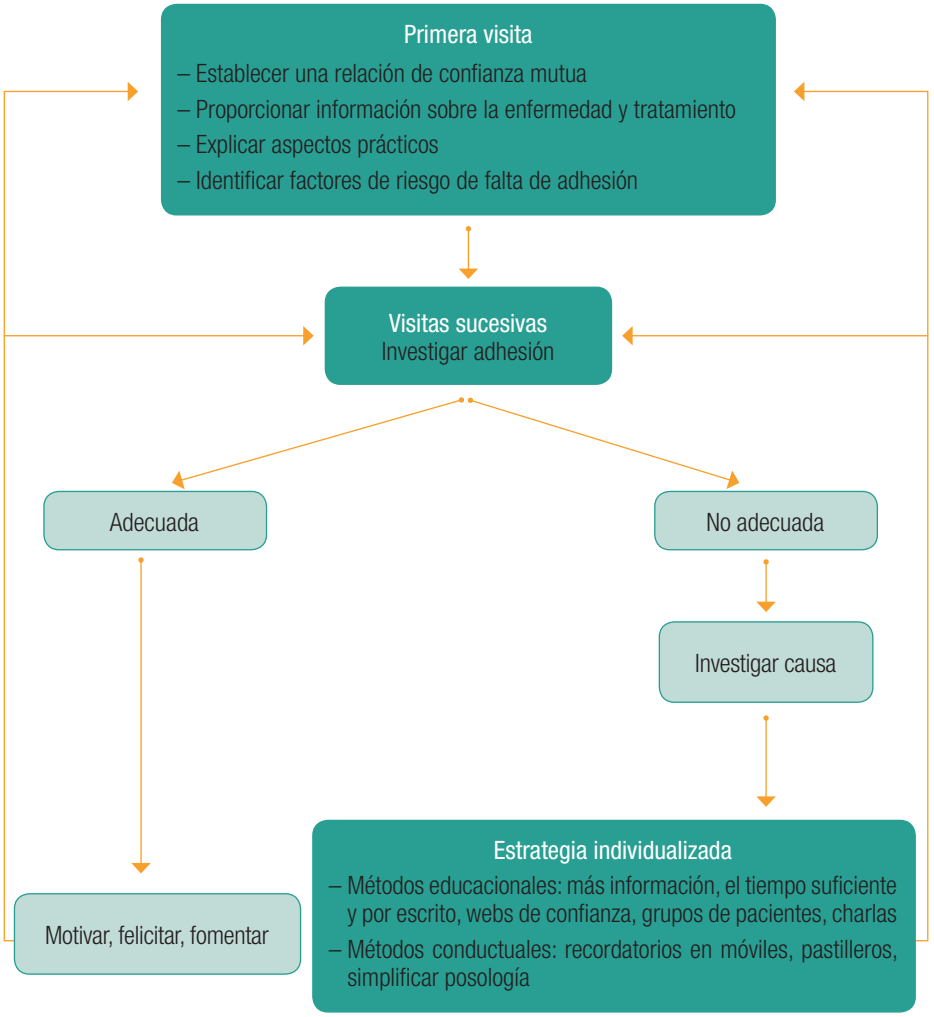


Figura 1. Diagrama de la valoración de la adhesión al tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal. Actuación en la consulta de enfermería.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hernández-Sampelayo P, Seoane M, Oltra L, Marín L, Torrejón A, Vera MI, et al. Contribution of nurses to the quality of care in management of inflammatory bowel disease: a synthesis of the evidence. J Crohns Colitis 2010;4(6):611-22.
2. Sabaté E, ed. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Ginebra, Suiza: World Health Organization; 2003. WHO.int [Internet]. Ginebra: World Health Organization; 2003 [actualizado 2003; citado el 24 de abril de 2016]. Disponible en http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
3. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther 2001;23(8):1296-310.
4. Kane S, Huo D, Aikens J, Hanauer. Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis. S Am J Med 2003;114(1):39-43.
5. Kane S, Shaya F. Medication non-adherence is associated with increased medical health care costs. Dig Dis Sci 2008;53(4):1020-4.
6. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353(5):487-97.
7. Kane SV, Cohen RD, Aikens JE, Hanauer SB. Prevalence of non adherence with maintenance mesalamine in quiescent ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001;96(10):2929-33.
8. Bermejo San José F, López San Román A, Algaba García A. Adhesión al tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estrategias para mejorarla. Gastroenterol Hepatol 2009;32 Suppl 2:31-6.
9. Bermejo San José F, López San Román A, Marín Sánchez L. Recomendaciones para mejorar el tratamiento en la colitis ulcerosa. Madrid: Ferring; 2015.
10. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986;24(1):67-74.
11. Kennedy AP, Nelson E, Reeves D, Richardson G, Roberts C, Robinson A, et al. A randomised controlled trial to assess the effectiveness and cost of a patient orientated self management approach to chronic inflammatory bowel disease. Gut 2004;53(11):1639-45.
12. Dignass AU, Bokemeyer B, Adamek H, Mross M, Vinter-Jensen L, Börner N, et al. Mesalamine once daily is more effective than twice daily in patients with quiescent ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7(7):762-9.

3.4.2. CIRUGÍA. OSTOMÍA

Milagros Martín Fernández
Estomoterapeuta. Consulta de Enfermería de Ostomías.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Un porcentaje importante de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) requerirán tratamiento quirúrgico en un momento determinado de su evolución.

Entre las intervenciones quirúrgicas más frecuentes están:

- **Resección ileocecal con anastomosis ileocólica:** resección de la zona ileocecal y anastomosis del extremo del íleon intacta con el colon ascendente.
- **Colectomía total con anastomosis íleorectal:** resección completa del colon y unión posterior del íleon y el recto.
- **Proctocolectomía total con ileostomía:** resección de la totalidad de recto y colon con ileostomía permanente.
- **Proctocolectomía restauradora con reservorio íleoanal:** resección de colon y de recto y creación de un reservorio con asas de íleon unido al ano, que funciona como un nuevo recto. Generalmente se realiza una ileostomía temporal. Es la opción más común en cirugía programada de colitis ulcerosa.

El tipo de intervención quirúrgica se decide en función de la evolución y complicaciones de la enfermedad. La cirugía conlleva un estoma de eliminación intestinal cuando fracasan otro tipo de tratamientos (Figura 1).

La palabra estoma, según la Real Academia Española, significa «Med. Abertura al exterior que se practica en un órgano hueco, como el intestino, o entre dos de ellos».

Ostomía se refiere al procedimiento quirúrgico por el que se realiza la derivación al exterior de las heces, a través de un estoma abdominal, recibiendo el nombre del órgano que se exterioriza. Lo que vemos es la mucosa del intestino tibia, húmeda y de color rosa brillante a rojo.

Es importante conocer los diferentes tipos de ostomía para realizar un cuidado adecuado del paciente. Existen diferentes tipos según el órgano exteriorizado, la forma de exteriorización o la temporalidad.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Mejorar la atención de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ostomizados.

Objetivos específicos:

- Facilitar su adaptación a la nueva situación.
- Favorecer que tengan una mejor calidad de vida.

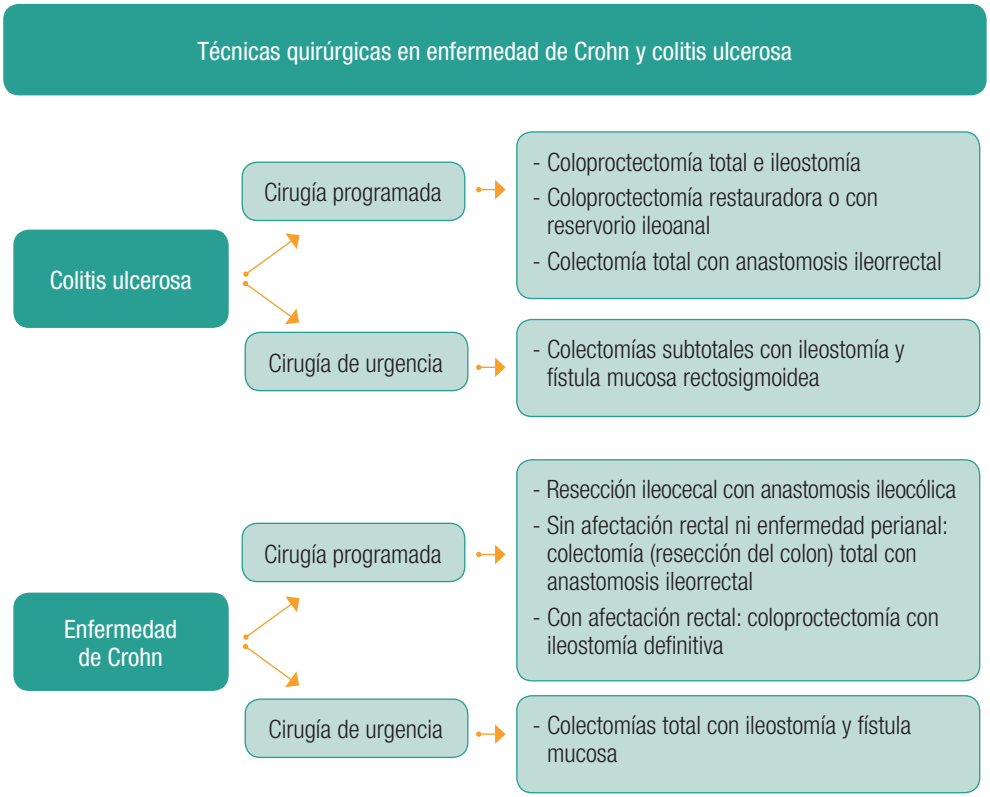


Figura 1.

CLASIFICACIÓN DE OSTOMÍAS

Según el órgano exteriorizado

– **Ileostomía:** es la exteriorización de la porción final del íleon a través de una abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal. Generalmente en el lado derecho inferior del abdomen. La consistencia del efluente será líquida o pastosa.
– **Colostomía:** es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal. Dependiendo de la afectación del colon se puede localizar el estoma en el lado inferior izquierdo del abdomen, que es la más habitual, pero también se puede localizar en el lado inferior derecho o en el abdomen superior si se exterioriza el colon transverso. La consistencia del efluente será diferente dependiendo de la localización del estoma. En el colon derecho es más líquido y continuo. En el colon izquierdo es prácticamente de consistencia espesa o sólida.

En los pacientes con colitis ulcerosa generalmente se realiza ileostomía, mientras que en los pacientes con enfermedad de Crohn se puede realizar ileostomía o colostomía.

Según la técnica de construcción quirúrgica o forma de exteriorización

– **Terminal:** se caracteriza por tener una sola boca. En el caso de la ileostomía, el íleon evertido debería tener una altura de 3 a 4 cm, con objeto de evitar complicaciones cutáneas, mientras que en las colostomías el colon evertido suele tener de 1 a 2 cm de altura.
– **Lateral:** tienen dos bocas. Generalmente se realiza para proteger una sutura o para descomprimir el colon. En las ileostomías es importante que la boca proximal sea más protruyente que la distal.

Según el tiempo de permanencia

– **Temporal:** se realiza por la necesidad de derivar temporalmente las heces. Existe la posibilidad de reconstrucción del tránsito intestinal y de cierre del estoma pasado un tiempo.
– **Permanente:** cuando no existe esa posibilidad.

ESTOMATERAPIA

Los pacientes ostomizados requieren una atención y unos cuidados especializados que fomenten su independencia y favorezcan una mejor calidad de vida. Esta atención es asumida por personal de enfermería estomaterapeuta, que son profesionales de enfermería expertos en estomaterapia, que desarrollan su labor en consultas de enfermería de ostomías.
La formación específica en el cuidado de estomas se inició en 1961, en Cleveland Clinic, por el cirujano Turnbull y una enfermera ileostomizada, Norma Gill, considerándose la estomaterapia como especialidad en EE. UU.
En España se organizó el primer curso de estomaterapia en 1985 en Pamplona.
Cuando los pacientes con EII tienen una elevada probabilidad de que se les realice una ostomía, el asesoramiento por parte de una enfermera estomaterapeuta es determinante para solucionar dudas y facilitar apoyo emocional.
La información de la necesidad de realizar una ostomía es un momento traumático para el paciente. Surgen dudas sobre cómo va a ser su vida a partir de ese momento. Es un cambio que afecta a la fisiología gastrointestinal, a la imagen corporal y a la autoestima. A veces, después de la intervención, los pacientes con EII tienen mejor calidad de vida, pero de igual manera que los demás pacientes necesitan tiempo para adaptarse a la nueva situación.
La atención a las personas ostomizadas en la consulta de enfermería de ostomía se realiza a lo largo de todo el proceso, iniciándose en el preoperatorio.

DESCRIPCIÓN

Preoperatorio

La comunicación entre el equipo multidisciplinar es esencial para que los pacientes reciban una información apropiada.

Una vez que el paciente con EII es informado de la posibilidad de necesitar un estoma, se le derivará a la consulta de enfermería de ostomías antes de la intervención.

Información preoperatoria

Los pacientes valoran positivamente la atención preoperatoria de una enfermera estomaterapeuta, que realiza asesoramiento técnico y apoyo emocional. Por una parte disminuye la percepción de angustia, miedo y ansiedad producida por el temor a la ostomía y, por otra, la información facilitada en el periodo preoperatorio influye en un manejo más rápido de la ostomía y puede ayudar a disminuir la estancia hospitalaria.
Según la *Guía de buenas prácticas clínicas RNAO* es importante «*crear una relación terapéutica con el paciente y la familia*». Para ello, es necesario conocer el diagnóstico, el motivo de la cirugía, el tipo de ostomía prevista, las necesidades, la capacidad de comprensión y perspectiva de vida y el apoyo familiar de cada paciente. La relación terapéutica comienza antes de la intervención para poder entablar una buena comunicación, permitiendo que el paciente exprese sus sentimientos, dudas, miedos o preocupaciones relacionadas con la ostomía o con la intervención.
Es necesario realizar una evaluación integral del paciente que incluya: edad, sexo, diagnóstico y problema actual, resumen de su historia, cirugía prevista, conocimiento del paciente sobre la cirugía y sobre la ostomía, preparación psicológica, actividad laboral, vida social, limitaciones, capacidades físicas y cognitivas necesarias para el autocuidado de la ostomía, y evaluación abdominal para marcar el estoma.

Marcaje del estoma

Antes de la intervención se debe marcar la ubicación del estoma por una enfermera estomaterapeuta o por el cirujano, ya que reduce las complicaciones del estoma y de la piel periestomal.
Para realizar el marcaje se valora el lugar más idóneo junto con el paciente, teniendo en cuenta el tipo de ostomía, la visibilidad del estoma, la forma de vestir, el estilo de vida, la destreza manual, el trabajo, etc. Se tienen en cuenta también consideraciones físicas como pliegues abdominales, cicatrices, otros estomas, músculo recto del abdomen, cintura o aparatos ortopédicos. Se le pedirá al paciente que adopte diferentes posturas como sentado, agachado y de pie. Es fundamental que el paciente pueda ver el estoma para poder ser autónomo en los cuidados, evitar complicaciones y conseguir mayor seguridad y mejor aceptación.

POSTOPERATORIO

Cuidados postoperatorios

Después de la intervención es importante evaluar el estado del estoma y de la piel periestomal. Se debe tener en cuenta si, además de EII, existen otros factores de riesgo que puedan influir en la aparición de complicaciones, como cirugía de urgencia, elevación del estoma, edad, obesidad, o diabetes.

El estoma debe tener un color rosado a rojo, similar al color de la mucosa oral. El edema está relacionado con la manipulación y la exteriorización del intestino, por lo que en el postoperatorio inmediato es normal y va disminuyendo en los días sucesivos. Los puntos deben unir el estoma a la piel y la piel debe estar íntegra.
Es necesario comprobar y registrar el estado del estoma, la unión mucocutánea y la piel periestomal:
– **Estoma:** tamaño, color, aspecto o elevación.
– **Unión mucocutánea:** intacta o separada.
– **Estado de la piel periestomal:** color e integridad.

Cambio de dispositivo

Para el cambio de dispositivo se debe preparar el material necesario con antelación:
– Dispositivo o bolsa de recambio.
– Bolsa de plástico para material sucio.
– Papel seca manos o pañuelos de papel.
– Gel de ducha/agua del grifo templada.
– Esponja suave.
– Tijeras curvas.
– Espejo si fuera necesario.
Para realizar el procedimiento es necesario despegar el dispositivo de arriba hacia abajo, sujetando la piel con la otra mano para evitar dermatitis traumática. Lavar con agua tibia, jabón y esponja suave. Aclarar y secar suavemente con toalla o papel. Recortar el diámetro del dispositivo de ostomía, según la medida y forma del estoma. Colocar el adhesivo centrado en el estoma y presionar suavemente, evitando que se formen pliegues y arrugas.
Si existiera vello alrededor del estoma, recortar con tijeras, no rasurar.
Evitar la utilización de cremas, ya que pueden dificultar la adhesión de los dispositivos.
Cuando se detecta o sospecha que hay fugas, es necesario cambiar el dispositivo para evitar filtraciones que puedan dañar la piel y que creen inseguridad en el paciente.

Educación del paciente ostomizado

Después de la intervención el paciente toma conciencia de lo que significa tener una ostomía, iniciándose un proceso de afrontamiento y adaptación a la nueva situación. Los factores más estresantes son ver y tocar el estoma y la falta de control sobre la salida de las heces, suponiendo una gran preocupación la posibilidad de tener fugas.
Para que el paciente ostomizado sea capaz de realizar el cambio de dispositivo y saber reconocer las complicaciones que afectan al estoma y a la piel periestomal, debe diseñarse un plan educativo y de apoyo emocional, personalizado para cada paciente, teniendo en cuenta la respuesta ante su nueva situación.
Debemos tener en cuenta que la estancia tras la cirugía cada vez es más corta y se dispone de menos tiempo para la información y la educación de los pacientes.
Antes del alta, el paciente debe ser capaz de realizar un mínimo de habilidades sobre el cuidado del estoma y el manejo de dispositivos, siendo capaz de cambiar los dispositivos correctamente.

Seguimiento del paciente ostomizado

Una ostomía provoca un cambio de imagen corporal y una disminución de la autoestima. El paciente tiene miedo al rechazo, lo que puede condicionar las relaciones personales y generar aislamiento social. Para evitarlo debemos ayudar al paciente a desarrollar una actitud positiva de sí mismo, realizando técnicas de comunicación asertivas, apoyo emocional y escucha activa. Tras el alta el paciente debe ir recuperándose poco a poco tanto física como psicológicamente.
Es recomendable que una enfermera estomaterapeuta realice una evaluación del paciente ostomizado y familia, con el fin de disminuir los problemas psicológicos, fomentar una calidad de vida óptima y evitar complicaciones.
Se debe asegurar la continuidad de cuidados por una estomaterapeuta, con un seguimiento periódico adaptado a cada paciente, durante un mínimo de 1 año.

Elección de dispositivo de ostomía

Los dispositivos de ostomía se utilizan para recoger de forma eficaz las heces, siendo importante que se adapten al tamaño del estoma, que protejan la piel periestomal, que sean de fácil manejo y que sean discretos.
Existe gran variedad de dispositivos de ostomía: por una parte existen sistemas de 1 o 2 piezas y abiertos o cerrados y, por otra, existen diferentes modelos dependiendo de la marca comercial.
Es necesario elegir el mejor dispositivo para cada paciente, teniendo en cuenta:
– Tipo de ostomía.
– Forma de construcción del estoma.
– Consistencia del efluente.
– Ubicación.
– Características del estoma y de la piel periestomal.
– Edad.
– Destreza manual.
– Habilidades cognitivas para aprender.
– Preferencia del paciente.
– Implicación laboral.
– Estilo de vida.

Complicaciones de las ostomías

Existe relación entre el tipo de ostomía y el tipo de complicaciones, siendo la complicación precoz más frecuente la dermatitis irritativa, sobre todo en ileostomías, por tener un efluente más líquido e irritante para la piel.
Las complicaciones más frecuentes en colostomías son:
– Hundimiento: el extremo del estoma se sitúa bajo la superficie de la piel.
– Necrosis: la mucosa del estoma adquiere color parduzco o negro.
– Dehiscencia mucocutánea: separación de la mucosa de la piel circundante al estoma.
Las complicaciones más frecuentes en ileostomías son:
– **Deshidratación:** disminución de diuresis, mareo, sequedad de boca, aturdimiento y deposiciones líquidas. Es necesario medir el débito de una ileostomía en el postoperatorio inmediato.

– **Dermatitis irritativa:** reacción inflamatoria que va del enrojecimiento a la ulceración con escozor, dolor y/o exudación de la piel. El efluente es muy irritante para la piel, por lo que es importante la correcta adaptación de los dispositivos de ostomía evitando el contacto con la piel.
– **Obstrucción:** dolor, distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de contenido fecal en el dispositivo de ileostomía. Mientras que una colostomía puede tardar días en empezar a funcionar, en una ileostomía el funcionamiento es más inmediato, por lo que la ausencia de heces nos debe poner en alerta.

Ostomías y dieta

La dieta influye de forma importante en la recuperación tras la intervención. Se recomienda comidas poco abundantes y frecuentes, con una ingesta de líquidos mínima de 1,5 litros al día si no hay contraindicación. Es importante una correcta masticación de los alimentos para evitar problemas de obstrucción y favorecer una correcta absorción de los nutrientes.
La colostomía no necesita ninguna dieta específica, sólo conocer los alimentos que producen gases o aumentan el mal olor como legumbres, lechuga, coliflor, cerveza, brócoli, bebidas carbonatadas, cebolla, etc. Por el contrario, yogur, mantequilla y perejil ayudan a disminuir los olores y los gases.
Para los pacientes con ileostomía es recomendable que tengan seguimiento en el servicio de nutrición. Deben seguir, al menos el primer mes, una dieta astringente o específica de ileostomía, evitando fibra, lactosa y grasas, con el objetivo de evitar heces excesivamente líquidas y disminuir el volumen diario.
Se aconseja tomar pequeñas cantidades de comidas, de 4 a 6 veces al día, y realizar cenas ligeras. Los líquidos deben tomarse 30 minutos antes de las comidas. La ampliación de la dieta y la reintroducción de alimentos se hará de manera progresiva, observando la consistencia y cantidad de las heces. Si no hay contraindicación, deben tomar alimentos ricos en sodio como jamón, bacón, sal de mesa, etc. y potasio como plátano, tomate crudo, melocotón crudo, etc. Entre las bebidas aconsejadas están el agua sin gas, bebidas isotónicas, infusiones, zumo de manzana y fruta licuada. Se desaconseja el café y las bebidas con gas.

Ostomías y medicación

Como resultado de la cirugía, los pacientes ostomizados, sobre todo con ileostomía, pueden tener cambios en la absorción de medicamentos debido al acortamiento del intestino.
Hay que observar si hay restos de medicamentos en el dispositivo de ostomía, sugiriendo presentaciones de acción rápida como comprimidos sin revestir, soluciones o suspensiones para maximizar la absorción.

Ostomías y vida diaria

La vida diaria no tiene por qué cambiar por tener un estoma. Después de un periodo de adaptación, los cuidados del estoma y los dispositivos, se incorporan como una rutina, llegando a olvidarse de la ostomía.

La incorporación al trabajo estará en relación con el estado general, pero muchos ostomizados tienen una vida laboral activa y las actividades de ocio se recuperan poco a poco, incluidos deportes o el baño en piscina o playa, que se pueden realizar sin problemas con los dispositivos de ostomía que utilicen habitualmente. Las limitaciones son en muchos casos psicológicas.

ALGORITMO

El paciente de EII que es, o va a ser, ostomizado se debe derivar a una consulta de enfermería de ostomía mediante una cita, en el caso de pacientes ambulantes, o a través de una interconsulta si son pacientes ingresados.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Arrontes Caballero G, de Frutos Muñoz R, González Rodríguez V, Ramírez Bustos M, Zabala López I, Hernando López A, et al. Necesidades de cuidados y calidad de vida de los pacientes ostomizados. Educare21 2008;50(6).
- Asociación profesional de enfermeras de Ontario (RNAO). Guías de buenas prácticas de Enfermería. Cuidado y manejo de la Ostomía [Internet]. 2009. Disponible en: http://www.rnao.org/Storage/78/7229_BPG_Ostomy.pdf.
- Birnbaum J, Bège T, Berdah V. Tratamiento quirúrgico de las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas: enfermedad de Crohn. EMC - Técnicas Quirúrgicas - Aparato Digestivo 2015;31(2):1-13. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1282912915708433
- Campo Cascón J, Caparrós Sanz MR, Díaz Millán MI, Sánchez Martín MR. Necesidad de atención especializada e individualizada al paciente ostomizado: un caso clínico. Nursing (Ed. española) 2007;25(3):52-7.
- Caparrós Sanz MR, Campo Cascón J. Efectividad de los cuidados de la unidad de estomaterapia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Nursing (Ed. española) 2007;25(10):64-6.
- Caparrós Sanz MR, Lancharro Bermúdez M. Factores de riesgo de complicaciones de los estomas en patología colorrectal. Análisis prospectivo de 937 pacientes en un periodo de 12 años. Nursing (Ed. española) 2011;29(6):56-60.
- Corella Calatayud JM, Mas Vila T, Tarragón Sayas MA, Corella Mas JM. Enfermería y estomaterapia. Enferm Integral 2001; 59: XXV-XXIX. Disponible en: http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev59/artic06.htm
- De Miguel Velasco M, Jiménez Escovar F, Parajó Calvo A. Estado actual de la prevención y tratamiento de las complicaciones de los estomas. Revisión de conjunto. Cirugía Española 2014;92(3):149-56. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009739X13003667
- De Oca J, Rodríguez-Moranta F, de Lama E, Guardiola J. Manejo perioperatorio de la enfermedad inflamatoria intestinal. En: Enfermedad Inflamatoria Intestinal al Día, Volume 14, Issue 3.; 2015. p. 87-93. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.eii.2015.08.003.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1696780115000767)
- Frutos Muñoz R, Solís Muñoz M, Hernando López A, Béjar Martínez P, Navarro Antón C, Mayo N. Calidad de vida de los pacientes con colostomía e ileostomía a corto y medio plazo. Metas de enfermería 2011;14(2):24-31.
- Gomollón F, García-López S, Sicilia B, Gisbert JP, Hinojosa J; en representación del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) Guía clínica GETECCU del tratamiento de la colitis ulcerosa elaborada con la metodología GRADE. Gastroenterol Hepatol 2013;36(8):e1-e47.
- http://dle.rae.es/
- http://www.educainflamatoria.com
- Huércanos Esparza I. Experiencia clínica parte I. Una aproximación a un caso práctico de comunicación terapéutica. Cultura de los cuidados [Internet] 2011;29:16-24. Disponible en: http://www.index-f.com/cultura/29/sumario.php
- Liao C, Qin Y. Factors associated with stoma quality of life among stoma patients. International Journal of Nursing Sciences 2014;1849:405-9.
- Martín Muñoz B, Panduro Jiménez RM, Crespillo Díaz Y, Rojas Suárez L, González Navarro S. El proceso de afrontamiento en personas recientemente ostomizadas. Index Enferm [Internet] 2010;19(2-3):115-9. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962010000200009.

- Millan M, Tegido M, Biondo S, García Granero E. Preoperative stoma siting and education by stomatherapists of colorectal cancer patients: A descriptive study in twelve Spanish colorectal surgical units. Colorectal Disease 2010;12:e88-e92.
- Millán Scheiding M, Rodríguez Moranta F, Kreisler Moreno E, Golda T, Fraccalvieri D, Biondo S. Estado actual del tratamiento quirúrgico electivo de la colitis ulcerosa. Revisión sistemática. Cir esp 2012;90(9):548-57.
- Ortiz Rivas MK, Moreno Pérez NE, Vega Macías HD, Jiménez González MJ, Navarro Elías MG. Nivel de adaptación de la autoimagen y mecanismos de defensa en ancianos con estoma complicado. Enfermería Clínica 2014;24(6):339-44.
- Person B, Ifargan R, Lachter J, Duek SD, Kluger Y, Assalia A. The impact of preoperative stoma site marking on the incidence of complications, quality of life, and patient's independence. Diseases of the colon & rectum 2012;55(7):783-7.
- Salido Moreno MP, Rodríguez Úbeda MR. Consideraciones prácticas para el cuidado de un estoma digestivo de eliminación. Inquietudes 2014;48:12-9.
- Salvadalena G, Hendren S, McKenna L, Muldoon R, Netsch D, Paquette I, et al. WOCN Society and ASCRS Position Statement on Preoperative Stoma Site Marking for Patients Undergoing Colostomy or Ileostomy Surgery J Wound Ostomy Continence Nurs 2015;42(3):249-52. Disponible en: http://c.ymcdn.com/sites/www.wocn.org/resource/resmgr/Publications/ASCRS_Stoma_Site_Marking_PS_.pdf
- Salvadalena G, Hendren S, McKenna L, Muldoon R, Netsch D, Paquette I, et al. Position statement on preoperative stoma site marking for patients undergoing colostomy or ileostomy. Surgery. Wound, ostomy and continence nurses society. WOCN Society and ASCRS. Mt. Laurel: NJ. 2014. Disponible en: http://c.ymcdn.com/sites/www.wocn.org/resource/resmgr/Publications/ASCRS_Stoma_Site_Marking_PS_.pdf
- Sicilia B. Epidemiología, diagnóstico, complicaciones y cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterología y Hepatología 2012;35(Supplement 1):51-6.
- Thorpe G, McArthur M, Richardson B. Healthcare experiences of patients following faecal output stoma-forming surgery: A qualitative exploration. International Journal of Nursing Studies. 2014;51(3):379-89.

3.4.3. LA TRANSICIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A LA EDAD ADULTA

COORDINADORES:
César Sánchez Sánchez, Ignacio Marín Jiménez y Ana María López Calleja

AUTORES:
César Sánchez Sánchez[1], Guillermo Álvarez Calatayud[1], Mar Tolín Hernani[1], José Luis Morales Pérez[1], Ignacio Marín Jiménez[2], Luis Alberto Menchén Viso[2], Inmaculada Martínez Álvarez[3], Belén González García[3] y Ana María López Calleja[4]

[1]Médicos de Pediatría. Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. [2]Médicos Gastroenterólogos de la Unidad de EII. Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. [3]Enfermera de Pediatría. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, [4]Enfermera Coordinadora de la Unidad de EII. Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) pediátrica tiene características propias y se considera una patología diferente a la del adulto.

La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) en la infancia son más extensas en el debut y su evolución es más severa. A diferencia del adulto, los pacientes pediátricos precisan precozmente tratamiento inmunomodulador y terapia biológica condicionados, probablemente, por causas genéticas.

La sintomatología intestinal es más insidiosa en la EC pediátrica. Los síntomas intestinales en la CU son más parecidos a los del adulto.

Los síntomas extraintestinales constituyen la gran diferencia entre la EII infantil y la del adulto. El retraso ponderoestatural y puberal pueden ser la única manifestación clínica durante muchos años, lo que puede suponer un retraso en su diagnóstico si no se sospecha la misma.

Un punto importante a tener en cuenta son los problemas psicosociales derivados de padecer una enfermedad crónica en un paciente que aún precisa conformar su desarrollo integral como individuo (Tablas I y II).

Tabla I

DIFERENCIAS EN LA EC Y CU

DIFERENCIAS EN LA EC		
	Pediátrica	Adultos
Extensión al debut	Afectación colónica. Tracto gastrointestinal superior	Íleon
Historia natural	Progresión más lenta. Tiempo largo hasta la primera intervención quirúrgica	Progresión más rápida. Necesidad de intervención quirúrgica precoz
DIFERENCIAS EN LA CU		
	Pediátrica	Adultos
Extensión al debut	Pancolitis	Colitis izquierda
Historia natural	Colectomía precoz	Colectomía tardía

Tabla II
SÍNTOMAS

PEDIÁTRICA	ADULTOS
1. Síntomas más inespecíficos enmascaran el diagnóstico 2. Predominio de síntomas extraintestinales 3. Presencia de síntomas propios de la infancia: - Estancamiento pondero-estatural - Retraso puberal 4. Cambios psicosociales	1. Síntomas específicos, triada clásica: dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso 2. Predominio de síntomas intestinales 3. Síntomas clásicos intestinales y generales (más frecuente en la EC)

Se han publicado numerosas definiciones del proceso de transición de cuidados, pero quizás una de las más acertadas es la de Blue y cols.:

> *«Es el movimiento intencional planificado de los adolescentes y jóvenes adultos con enfermedades crónicas desde los cuidados infantiles al sistema de cuidados propios del adulto.»* (Figura 1)

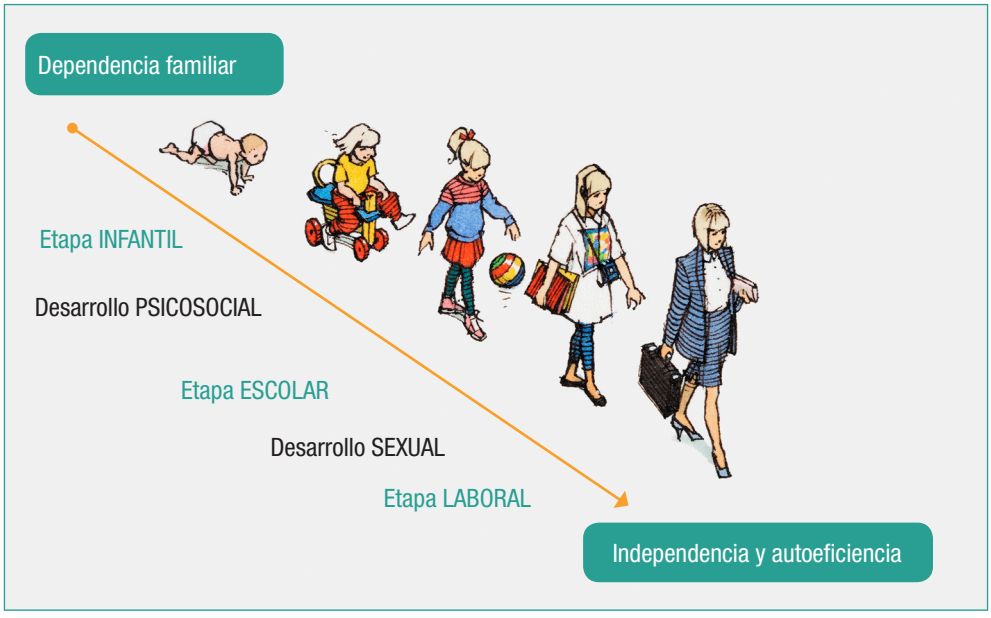


Figura 1. Definición de transición.

En realidad, se trata de una enfermedad caracterizada por una baja mortalidad, pero una elevada morbilidad. Eso, unido a las características propias de la enfermedad en niños (la aplicación de diferentes criterios diagnósticos [criterios Oporto], índices de actividad adaptados, así como la importancia de la interacción familiar), ocasiona que el protocolo de transición sea un paso fundamental en el cuidado de estos pacientes, con intención de adecuar los cuidados a los cambios que se producen en esa edad.

OBJETIVOS

Objetivo general: asegurar para cada uno de los niños, de forma individualizada, una continuidad de los cuidados que incluyan la normalización social, el desarrollo emocional y la adquisición de habilidades que fomenten la independencia de cuidados.

Objetivos específicos:

- Establecer la transición como un protocolo esencial, con anticipación y adecuada planificación, con el desarrollo de un programa específico consensuado entre el personal implicado, un equipo multidisciplinar especialmente formado y entrenado en los cuidados de adolescentes.
- Facilitar al paciente y su familia un cronograma que aclare el protocolo de transición donde el sujeto puede acceder a la información necesaria y suficiente.
- Fomentar la autonomía del paciente en el protocolo, asegurando la adecuada adherencia terapéutica y de seguimiento.
- Evitar la sobreutilización de recursos.

INTRODUCCIÓN

La incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en la población infantil de nuestro país se ha triplicado en los últimos 14 años. El resultado es que cada año, 250 niños españoles –o lo que es lo mismo, 3 de cada 100.000 menores de edad– son diagnosticados de la enfermedad. Así lo concluyen los datos del registro «Spirit», presentados por la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) y el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

Entre otros resultados, el registro desvela que la edad promedio de diagnóstico de la EII se establece en los 12 años y, asimismo, que la frecuencia de la enfermedad de Crohn, con un 55 % de los casos, es superior a la de la colitis ulcerosa (37 %).

Finalmente, y por lo que respecta a las distintas comunidades autónomas, cabe resaltar que el mayor incremento de la frecuencia se ha registrado en Cataluña, Navarra y Asturias.

Debe incidirse en la importancia de la detección temprana de la enfermedad, pues «cuanto antes se inicie el tratamiento adecuado, menos sufrirá el niño y sus familiares y, probablemente, se logrará una mejor evolución clínica de la enfermedad a largo plazo». En la actualidad, se disponen de más posibilidades terapéuticas que hacen posible que se pueda controlar de manera eficaz durante periodos prolongados.

El paso de la adolescencia a la edad adulta es un tiempo de intensos cambios personales desde el punto de vista físico, psicológico y social. Muchos de esos cambios conllevan a

situaciones de frustración en relación con la edad presente, y en otras muchas ocasiones ansiedad ante el incierto futuro, incluso en niños sanos.
Más aún en adolescentes con enfermedades crónicas donde esa transición conlleva un estrés adicional, no sólo para el paciente, sino también para la familia y el equipo multidisciplinar que participa en ese proceso.
Los principales cambios que se producen en este periodo son:

1. Físicos:

- Influencia de los cambios corporales, secundarios a la propia evolución de la enfermedad o a los tratamientos médicos y/o quirúrgicos administrados.
- Numerosos problemas de crecimiento.

2. Psicológicos:

- Sentimientos de inseguridad ocasionados por la propia percepción de la enfermedad crónica.
- Incertidumbre de la evolución en forma de brotes, con disminución del control por la elevada morbilidad.
- Miedo y tristeza.

3. Sociales:

- Absentismo escolar.
- Aislamiento social debido a las numerosas consultas o a las reagudizaciones que obligan al ingreso, fomentando el aislamiento de los pacientes.

Todo esto complica en cierta medida la transición de estos jóvenes a la edad adulta, favoreciendo el abandono de tratamiento (hasta en un 20 % de los adolescentes) y la discontinuidad del seguimiento, así como requiriendo de nuestra colaboración para facilitar ese paso natural y seguro.
En la adolescencia la enfermedad evoluciona, por lo que las necesidades de dichos pacientes requieren diferentes respuestas por parte del sistema de salud. Cuando van convirtiéndose en adultos van evolucionando hacia una independencia de los cuidados, pasando de los cuidados familiares a los propios y adquiriendo la madurez suficiente para ir asumiendo la naturaleza de su patología.
El protocolo de transición de cuidados pediátricos de niños con enfermedades crónicas a la atención integral del adulto supone en ese marco un reto importante dentro de la asistencia de estos pacientes. Hasta ahora, muchos de los programas desarrollados se basan en la experiencia personal de diferentes grupos de trabajo con niños diagnosticados de diferentes enfermedades crónicas como fibrosis quística, cardiopatías congénitas intervenidas, pacientes trasplantados y diabetes juvenil. A partir de la experiencia publicada, se han desarrollado recomendaciones específicas dentro de la actividad de los equipos multidisciplinares (gastroenterólogos infantiles y de adultos y enfermería infantil y de la unidad de EII) que intentan protocolizar dicho proceso para niños con enfermedad intestinal inflamatoria.
Engström realizó un estudio comparando cuatro grupos de niños de 9 a 18 años: un grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), otro de diabéticos, otro de niños con cefalea tensional crónica y otro grupo control sano. En dicho estudio evaluó el ajuste emocional, el bienestar, la depresión, la ansiedad, la autoestima y la inteligencia con diversas medidas estandarizadas aplicadas a los niños y a sus madres, y una entrevista con diagnósticos de acuerdo con la clasificación DSM-III-R. Los niños con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) presentaban las mayores puntuaciones en la escala de problemas en el comportamiento, con diferencias significativas en comparación con el grupo sano.
Las relaciones sociales y los estudios pueden verse afectados por el curso de la enfermedad.

Las bajas hacen que pueda retrasarse en el colegio, las actividades sociales, como campamentos y excursiones, se hacen a veces imposibles de realizar a causa de las diarreas, el dolor y el cansancio, por lo que pueden sentirse excluidos y, además, es frecuente un retraso en la pubertad, etc. Todo ello puede producir problemas de autoestima en los niños/as.
Otro problema añadido, sobre todo en las niñas y adolescentes, es su imagen corporal: la cara de luna llena como consecuencia de los corticoides, el acné, las cicatrices de operaciones, el estoma en los casos en los que exista o la delgadez tienen una gran influencia en su autoestima, pudiendo aparecer depresión o actitud de rebeldía, con la negación de la enfermedad, la negativa a tomar el tratamiento y un comportamiento irritable.
El papel de los padres y de la familia es fundamental para establecer un contexto adecuado que facilite una buena calidad de vida al paciente. Además, diversos estudios han demostrado la importancia del apoyo familiar a la adherencia al tratamiento (DiMatteo y Robin, 2004). Por todo ello se debe:

1. Aceptar la existencia de la enfermedad y dar respuesta a las preguntas de los niños, adaptando la información a su madurez y edad. Se puede apoyar la información con esquemas y dibujos.
2. Permitir el desarrollo y autonomía del paciente.
3. Evitar la actitud sobreprotectora.
4. Practicar algún deporte para mantener un buen estado físico.
5. Adoptar hábitos saludables: pueden presentar hipercoagulabilidad, por lo que tienen más riesgo de trombosis y embolias. Educar en la importancia de no fumar.
6. Conocer cuándo un niño entra en brote: lo más llamativo suele ser el cansancio. Un niño que no juega, que pierde el apetito y está cansado suele ser previo al resto de síntomas específicos.
7. Personalizar la dieta: no existe una dieta igual para todos los pacientes.
8. No ser estricto con el horario de comidas: a veces es conveniente que el niño coma varias veces al día menos cantidades.
9. Detectar las señales de alarma de necesidad de ayuda psicológica: aislamiento social y depresión, aburrimiento e intranquilidad, comportamiento infantil no acorde a su edad, etc.

En la escuela, la colaboración de profesores y cuidadores es esencial para garantizar un estado óptimo de salud del paciente.
La enfermería juega un papel fundamental en la atención, puesto que proporciona una atención más cercana a las necesidades, tanto del paciente como de su familia: nos podemos sentar con ellos, dedicarles más tiempo, hablarles en su mismo nivel de comprensión, explicándoles términos médicos de una manera que ellos puedan entender, hacerles partícipes de los logros en su estado de salud y demás situaciones en las que favorezca la mejora de su calidad de vida. Somos el enlace entre el paciente, la familia y los distintos miembros del equipo multidisciplinar, laboratorios, asociaciones de enfermos *(ACCU: www.accuesp.com)*, estancias tuteladas con otras compañeras, y todos los servicios necesarios que el paciente precise de ello.

EL PROTOCOLO DE TRANSICIÓN

El momento preciso

Considerar la edad cronológica como el factor fundamental para iniciar la transición es un error: el protocolo debe ser flexible. Aunque los sistemas sanitarios establecen un corte

rígido para acceder a las carteras de servicios de adultos a los 15 años, debemos tener en cuenta los siguientes factores primordiales:

- *Grado de madurez emocional:* existen diferentes escalas de medición.
- *Estado médico en el momento de la transición:* se recomienda que la transición no se realice durante un brote o recaída. Se debe evitar con cambios en el tipo de medicación o en periodos de intensificación de los mismos.
- *Habilidades sociales y emocionales:* es un punto difícil de comprobar sin la preparación psicológica adecuada, pero se pueden determinar conflictos relacionales.
- *La escolarización:* el absentismo escolar es debido a las recaídas, ingresos y revisiones periódicas. No debe coincidir con momentos de especial estrés escolar, como cambio de centro, exámenes, selectividad etc.
- *Nivel cultural y formativo:* valorar y adaptar el protocolo al nivel cultural o formativo de los pacientes y sus familias.
- *Cambios vitales:* debe adaptarse de forma individualizada a las condiciones vitales del paciente, evitando situaciones que dificulten su cumplimiento como cambios de domicilio, cambios profesionales, situaciones especiales como embarazo, rupturas de parejas, divorcio de los padres, etc. Se debe pensar en retrasar la transición hasta evaluar una cierta estabilidad del paciente.

Cronograma por edades como guía a seguir:

1. *De 11 a 13 años:*
   - Aprendizaje sobre temas básicos de la enfermedad.
   - Introducción a futuras visitas independientes.
2. *De 14 a 16 años:*
   - Nos dirigimos al paciente.
   - Valoramos los temores de los padres.
   - Instruimos al paciente en habilidades (citas, medicación, dosis, etc.).
3. De 16 a 19 años:
   - Contacto con la unidad de EII de adultos.
   - Fomentar la toma de decisiones.
4. De 20 a 23 años:
   - Capaz de pedir cita.
   - Mantener una conversación telefónica sobre su estado de salud.

Circunstancias especiales

- *Embarazo:* requiere lo antes posible la transición planificada al equipo de adulto.
- *Universidad:* requiere que tenga un referente médico temporal en la ciudad en la que reside o, si se ha realizado lo antes posible la transición, tendrá a su alcance la unidad de EII de adultos con atención integral, tanto presencial como no presencial, con las nuevas tecnologías.
- *Viajes prolongados.*
- *Pacientes con otra enfermedad crónica:* conexión con profesionales de otras especialidades.
- *Pacientes con retraso puberal.*

Todas estas situaciones se afrontan mejor con la existencia de la unidad de EII porque pone a su alcance todos los recursos centralizados.

Pasos a seguir en el protocolo (Figura 2)

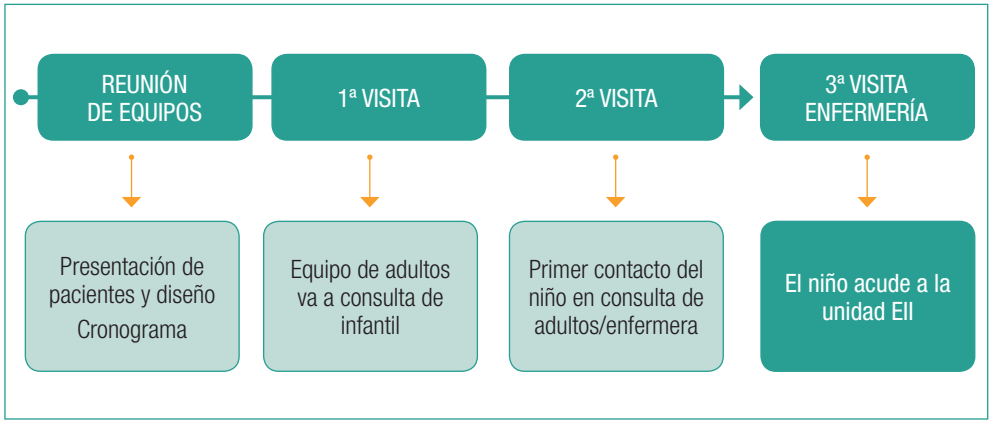


Figura 2. Protocolo de transición.

Se realizarán reuniones entre los servicios implicados, sección de gastroenterología pediátrica y servicio de gastroenterología de adultos, donde se expondrán los datos clínicos, psicológicos y sociales referentes a cada uno de los pacientes incorporados al protocolo.
En esa misma reunión se establecerá un cronograma a seguir, teniendo en cuenta la situación de cada paciente, con flexibilidad para su seguimiento.
Se determinará la vía de comunicación entre los miembros del equipo, el paciente y su familia.
Se nos dará un informe del paciente de alta de Pediatría previo al paso con: edad al diagnóstico, tipo, localización y severidad de la enfermedad, complicaciones, fecha de brotes y tratamiento recibidos, reacciones adversas, inmunizaciones y enfermedades previas, estado actual de la enfermedad, centro y médico de referencia.

- *Primera visita:* se realizará en el área pediátrica, acudiendo siempre que sea posible el gastroenterólogo de adultos a la consulta de Gastroenterología Pediátrica. En dicha consulta se presentará al paciente y se expondrán los pasos que seguirá el protocolo de transición. Además, se encargará de presentar a los otros miembros del equipo implicados (enfermería, nutricionistas, cirujanos, etc.).
- *Segunda visita:* ésta se va a producir en consultas de Gastroenterología de adultos o en el hospital de día de Pediatría. Llevaremos el informe definitivo con la información consensuada previamente entre los equipos participantes. En esta visita nos desplazaremos tanto el gastroenterólogo de adultos como la enfermera/o de EII. En ella nos presentaremos, explicaremos el funcionamiento de la unidad y facilitaremos las siguientes citas: consulta médica, consulta de enfermería y consulta en el hospital de día de terapias biológicas para el tratamiento ya en adultos, si éste fuera necesario.
- *Tercera visita:* contacto con la enfermera/o de la unidad de EII a cuyos pacientes se han derivado de la consulta médica para valoración seguimiento y control de su enfermedad. Ésta será la 1.ª primera consulta de enfermería, donde se llevarán a cabo las siguientes actividades:
  1. Presentación de la unidad y su funcionamiento: actividad presencial y no presencial, con herramientas telemáticas como teléfono y correo electrónico.

2. Información de recursos.
3. Recogida de datos de la historia clínica:
   - Diagnóstico.
   - Tratamiento.
   - Antecedentes personales.
   - Alergias.
   - Peso actual.
4. Plan de cuidados según necesidades.
5. Educación sanitaria y apoyo emocional.
6. Diagnósticos de enfermería.
7. Intervenciones de enfermería.
8. Sesión clínica con su médico de referencia.

El tiempo estimado de esta consulta es de 40 minutos.

Puntos fuertes del protocolo

1. La concienciación, por parte del personal implicado, de la importancia de la consulta de transición sobre la evolución de la enfermedad, así como en la calidad de vida del paciente.
2. Todos los participantes hemos intervenido activamente y con entusiasmo en el desarrollo del protocolo ante la novedad del mismo y sus beneficios, siendo fundamental la comunicación entre los equipos, permitiendo las variaciones en el protocolo sin detrimento del mismo.
3. La flexibilidad del cronograma marcado es lo que permite individualizar en cada caso los plazos de tiempo establecidos, haciendo que posibles interferencias que pueden acontecer en la vida del sujeto no conduzcan al fracaso de un protocolo de transición.
4. Con el paso del tiempo, los equipos participantes vamos adquiriendo cada vez más experiencia en el difícil terreno de la evaluación de la autonomía de los pacientes, así como en la ardua tarea de fomentar la independencia del mismo.

Limitaciones y obstáculos del protocolo

1. La obligatoriedad de la asistencia en las unidades de urgencias de adultos de todos los pacientes por encima de los 16 años, teniendo que informar a los pacientes en transición de que, en caso de evento urgente, deberán acudir a una urgencia y médicos con los que no están familiarizados, supone un estrés adicional al paciente.
2. Dificultades para fijar fechas adecuadas para las visitas comunes dentro de las agendas de cada una de las secciones participantes, lo que obliga a aumentar la disponibilidad del personal implicado en el protocolo. Probablemente, estas limitaciones se superarían si lográramos que las instituciones se hicieran conscientes de la importancia del protocolo como proceso, pasando a colaborar y facilitar la asistencia no sólo según la edad, sino en función de la situación del adolescente de forma individualizada.
3. La falta de espacios comunes entre las secciones, no sólo físicos sino en agenda, dificultan notablemente el desarrollo de las visitas comunes, tan importantes en el protocolo.
4. Falta de tiempo.
5. Las primeras valoraciones de enfermería no son completas ni veraces porque los adolescentes omiten datos como:

- Hábitos: fumar, beber u otras drogas.
- Sentimientos de miedo, tristeza, aislamiento social.
- Relaciones sexuales.

Las valoraciones sucesivas son más completas y detalladas.

6. Para el futuro funcionamiento del protocolo, se deberá formar específicamente sobre el mismo cada vez que un nuevo profesional se incorpore.

CONCLUSIONES

– El protocolo de transición es un **paso útil programado y planeado.**
– Es un proceso **largo y complejo**.
– El elemento más importante **es la anticipación.**
– Debe ser **gradual y escalonado.**
– Mejora **la adherencia terapéutica.**
– Facilita **el seguimiento del paciente.**

«*La existencia de un protocolo consensuado de transición permite dar a los niños una continuidad asistencial, creando un entorno agradable y seguro, donde se facilita un clima de confianza que le ayude al manejo de su enfermedad, fomente el auto-cuidado y facilite el acceso a los recursos.*»

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

– Baldassano R, Ferry G, Griffiths A, Mack D, Markowitz J, Winter H. Transition of the patients with inflammatory Bowel disease from pediatric to adult care: Recommendations of The North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34:245-8.
– Blue RW, Farell D, Hodgman Ch, Jorissen TW, Okinow NA, Orr Dp, et al. Transition from child-centered to adult health care systems for adolescent with chronic conditions. A position paper of Society for Adolescent Medicine. J Adolesc Health 1993;14:570-6.
– Brumfield K. Experiences of adolescent with cystic fibrosis during their transition fron pediatric to adult health are: A qualitaitve study of young australian adults. Disabil Rehábil 2004;26:223-4.
– Haggood JS, Thrasher S. A course on the transition to adult care of patients with childhood onset chronic illnesses. Acad Med 2005;80:352-5.
– Martín de Carpi J, Rodríguez A, Ramos E, Jiménez D, Martínez Gómez MJ, Medina E, on behalf of the SPIRIT-IBD Working Group of SEGHNP. Increasing incidence of pediatric inflammatory bowel disease in Spain (1996-2009): The SPIRIT registry. Inflamm Bowel Dis 2013;19(1):73-80. doi: 10.1002/ibd.22980.
– McGill M. How do we organiza smoth, effective transfer from pediatric to adult diabetes care? Horm Res 2002;57:66-8.
– Reid GJ, Irvine MJ, Mc Crindle BW, Sananes R, Ritvo PG, Siu SC, et al. Prevalence and correlates of successful transfer from pediatric to adult health care among a cohort of young adults with complex congenital heart defects. Pediatrics 2004;113:e197-205.
– Rosen D. Between two worlds: Bridging the culture of child health and adult medicine. J Adolesc Health 1995;17:10-6.
– Sawyer SM, Blair S, Bowes G. Chronic illness in adolescent. J Pediatr Child Health 1997;33:889.

3.4.4. NUTRICIÓN Y RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

M.ª Mercedes Cañas Gil
Enfermera de la Unidad de EII. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) afecta al tubo digestivo y, por tanto, estos pacientes pueden padecer carencias nutricionales. Estas carencias pueden surgir en todas las fases de la enfermedad: debut, brote, remisión, periodos prequirúrgicos y postquirúrgicos y embarazo. La malnutrición es una característica frecuente en la EII y contribuye al incremento de la morbilidad.

Las consecuencias son: adelgazamiento, anemia, enfermedad del metabolismo óseo, aumento del riesgo quirúrgico, retraso en el crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes.

La prevalencia de la desnutrición calórico-proteica en pacientes con EII oscila entre un 20 y un 85 %; es por eso que nutrición y dieta son motivo de preocupación constante para los pacientes y familias con EII.

OBJETIVOS

Objetivo general: proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para que el personal de enfermería sea capaz de transmitir al paciente la importancia de un adecuado cumplimiento dietético.

Objetivos específicos: facilitar al personal de enfermería una herramienta que sirva para instrucción sanitaria en materia de nutrición y dieta, en las distintas fases de la enfermedad.

MECANISMOS QUE PROVOCAN LA DESNUTRICIÓN

- **Disminución de la ingesta:** ocasionada por anorexia, restricción alimentaria autoimpuesta, ayuno terapéutico, dietas restrictivas, dispepsia y disgeusia inducida por fármacos.
- **Problemas de absorción:** disminución del tejido de absorción por la inflamación, cirugías, fístulas u ostomías. Aumento del tránsito intestinal, sobrecrecimiento bacteriano. La enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa (CU) tienen diferentes patrones de distribución y, por tanto, la carencia nutricional dependerá de la zona afectada.
- **Pérdida de nutrientes:** la inflamación y las úlceras en el intestino delgado y colon provocan que se pierdan en las heces proteínas, hierro y sales minerales. Los corticoides aumentan las pérdidas de proteínas y calcio (Ca++).
- **Aumento del metabolismo:** la inflamación es un proceso que consume gran cantidad de energía, así como la fiebre y las complicaciones sépticas. Los corticoides aumentan las necesidades de sodio (Na+) y Ca++, y las mesalazinas de folatos.

OBJETIVOS DE LA DIETA EN LA EII

- Prevenir deficiencias nutricionales y corregir las ya existentes.

– Que sea libre y variada (dieta mediterránea).
– Adecuarla a necesidades específicas como edad, actividad física, intolerancias y creencias.
– Conseguir una ingesta adecuada de proteínas, calcio y hierro.
– Inducir remisión del brote de actividad inflamatoria, en casos seleccionados, usando para ello nutrición enteral específica (NE).

VALORACIÓN NUTRICIONAL

La valoración se realizará conjuntamente con el facultativo. Se deben tener en cuenta la determinación de la talla y el peso. También hay que valorar los síntomas digestivos del paciente, así como la localización de la enfermedad y la existencia de estenosis intestinales. Es importante la valoración de analítica de sangre con la determinación de proteínas y vitaminas.
Hay que tener presente también que la afectación del intestino delgado se asocia a un mayor riesgo de desnutrición y de diarrea por malabsorción de sales biliares, que la afectación sólo del colon. La desnutrición es más frecuente en EC que en CU por la distribución de las lesiones.
Esta valoración está indicada en todo tipo de pacientes y situaciones, pero sobre todo en aquellos con brotes moderados o graves, mantenidos en el tiempo, en tratamiento con corticoides, en prequirúrgicos, etc. (Figura 1).

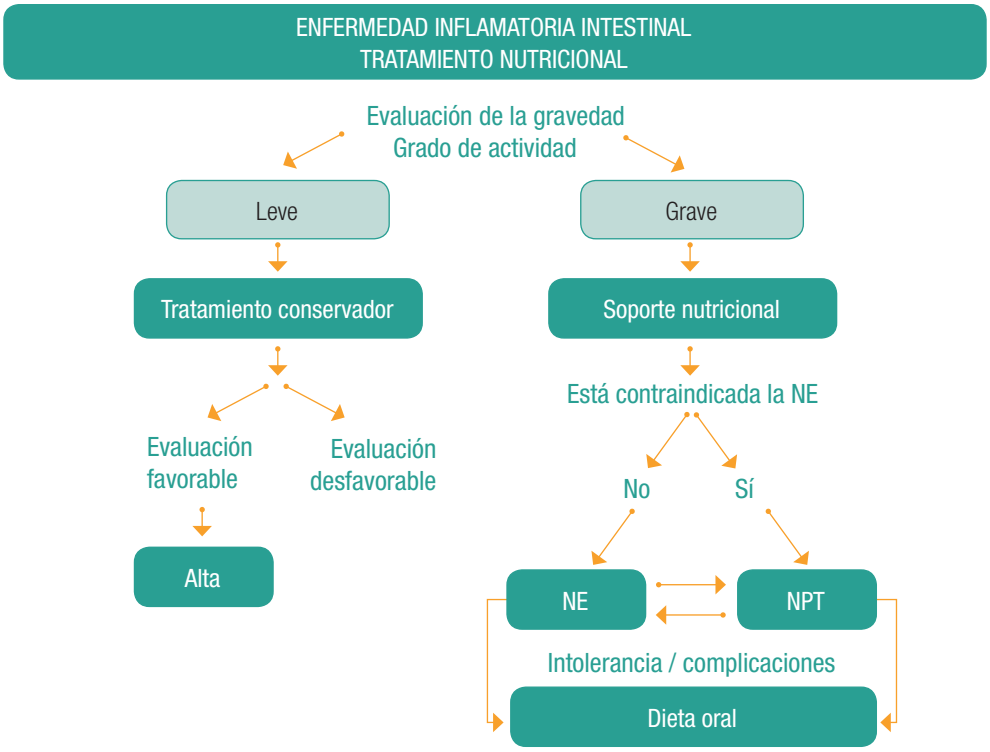


Figura 1. Endocrinol Nutr 2005;52(Supl 2):92.

RECOMENDACIONES GENERALES

No hay alimentos prohibidos para los pacientes que padecen EII, pero sí es cierto que una dieta equilibrada y variada favorece el bienestar. La dieta mediterránea es la idónea para este tipo de patología.
Se aconseja realizar 5 comidas al día sin ingerir grandes cantidades, ya que ocasionaría una sobrecarga en el intestino.
Se restringirán, en la medida de lo posible, las bebidas carbonatadas (con excitantes y/o estimulantes), por favorecer la aparición de flatulencias, y picantes, por su poder irritante.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN PERIODO DE BROTE (Figura 2)

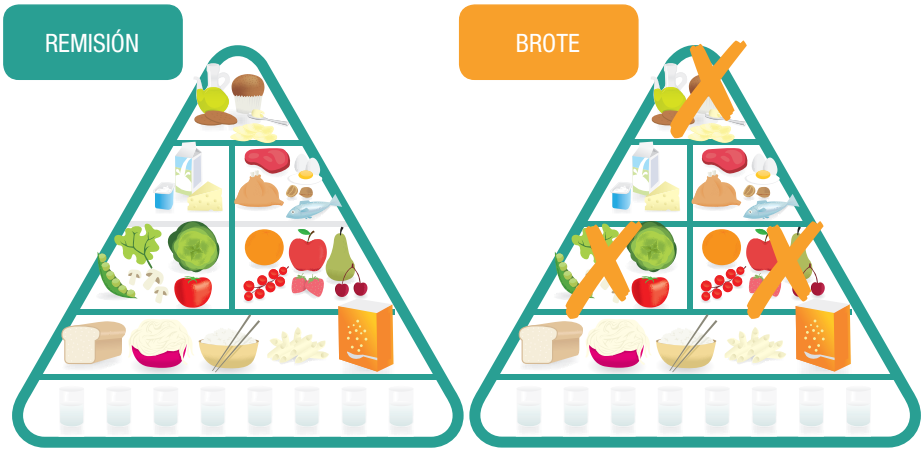


Figura 2.

– No se recomienda, en principio, dieta absoluta.
– Evitar sólo aquellos alimentos que, de forma reiterada y sistemática, aumenten los síntomas.
– Dieta a base de alimentos de fácil digestión y absorción.
– Moderar consumo de grasas, tanto en la composición como en la preparación.
– Moderar consumo de azúcares, ya que pueden potenciar distensión abdominal y la diarrea por malabsorción.
– Limitación del consumo de leche durante los brotes si ésta, de manera clara y reiterada, aumenta la diarrea. Pueden tolerarse yogures, quesos y lácteos sin lactosa.
– Es aconsejable hacer una dieta pobre en fibra insoluble en las formas estenosantes de EC, o en brotes de CU grave o extensa.
– Pasar a dieta progresiva hacia alimentos ricos en proteínas y con suficiente energía.
– Hacer varias comidas al día y en poca cantidad.
– Cantidad necesaria de líquidos: nunca menos de 2 litros al día.

RECOMENDACIONES EN PACIENTES OSTOMIZADOS

Tendremos en cuenta que, en esta situación, las heces son más líquidas, sobre todo en las primeras semanas. La ingesta de alimentos será de 6 comidas al día y poco abundantes. La ingesta hídrica será de, al menos, 2 litros de agua, preferentemente fuera de las comidas, evitando café, zumos y bebidas con gas o con excitantes y/o estimulantes.
Las frutas y las verduras se toleran mejor cocinadas y trituradas o tamizadas.
Se debe adaptar la dieta a cada paciente, que irá progresivamente probando los alimentos que tolere mejor, y con un periodo de adaptación podrá ingerir una dieta variada, equilibrada y satisfactoria.

FIBRA

En periodos de remisión, como hemos comentado, deben ingerir una dieta variada y equilibrada que incluya fibra, es decir, consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales.
Durante el brote, el paciente debe realizar una dieta pobre en residuos. Hay que distinguir entre los dos tipos de fibra:
– *Fibra insoluble (alto contenido en residuo):* la contienen vegetales leñosos, cereales integrales y algunas frutas y verduras, como la piña, la naranja, los espárragos o las alcachofas. Debe eliminarse en estenosis y en el brote moderado-grave de CU y EC que cursen con diarrea predominante.
– *Fibra soluble (alta fermentabilidad):* la contienen frutas, verduras y legumbres. Fermentan en el colon y pueden producir gases.

LÁCTEOS

No hay ningún componente de la leche que favorezca la inflamación. Se recomienda su ingesta, ya que es un aporte esencial de calcio.
Si el paciente tiene síndrome de malabsorción a la lactosa, eliminará la leche de su dieta, pero puede intentar tomar yogures o queso, que se toleran mejor por estar la lactosa parcialmente digerida, o consumir lácteos sin lactosa. La intolerancia a la lactosa es independiente de padecer EII.

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS

Ante la presencia de déficit vitamínico y de nutrientes, se recomiendan complejos vitamínicos, así como instruir sobre el aporte de esos nutrientes en la dieta. Los alimentos ricos en estos nutrientes son:
– *Hierro:* moluscos, carne roja y vísceras, cereales, legumbres y verduras verdes de hoja ancha.
– *Vitamina D:* alimentos fortificados con vitamina D y pescados.
– *Vitamina B_{12}:* carne y vísceras, huevos, leche, derivados lácteos y pescado.
– *Ácido fólico:* carne y vísceras, verduras, frutas, legumbres y cereales.

GRASAS

Las dietas pobres en grasas se asocian a una respuesta favorable, con tasas de remisión entre el 60 y el 100 %.
Es muy importante la adecuada relación entre ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 6 en la dieta, por eso la composición en grasas de las fórmulas enterales juega un papel importante, tanto en la cantidad como en el tipo de grasas.

NUTRIENTES CON POTENCIAL TERAPÉUTICO

Son los alimentos funcionales. Con este término se designa a los alimentos que, además de sus cualidades nutricionales, aportan beneficios adicionales para la salud.

Prebióticos y probióticos

Los prebióticos son ingredientes no digeribles que tienen la propiedad potencial de mejorar la salud debido a que favorecen el crecimiento selectivo de bacterias intestinales beneficiosas.
Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos cuyo consumo tiene efectos positivos para la salud por su acción sobre la flora intestinal, pues promueven el desarrollo de bacterias beneficiosas.
Los beneficios de los prebióticos en la EII son:
– Aportan y favorecen el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias endógenas.
– Previenen la adherencia de bacterias patógenas.
– Disminuyen el pH intraluminal.
– Producción de ácidos grasos de cadena corta (BUTIRATO):
  • Nutrientes preferenciales del enterocito.
  • Disminución de inflamación:
    - Disminución de producción de TNF-α.
    - Disminución de óxido nítrico.
    - Inhibición de la activación del factor nuclear kappa B (NFkB).
  • Absorción de agua y minerales.
– Producción de lactasa y vitaminas.

Ácidos grasos

Las grasas de la dieta pueden tener efecto antiinflamatorio (omega 3) y efecto proinflamatorio (omega 6).
Los beneficios de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 en la EII son:
– Reducción de la recurrencia postquirúrgica de la EC.
– Reduce la inflamación de la mucosa (omega 3).
– Retrasa el crecimiento del *Helicobacter pylori,* bacteria relacionada con la EC.
– La grasa como farmaconutriente disminuye la inflamación. Hay diversos estudios que demuestran que el omega 3 EPA disminuye la inflamación.
– El omega 3 actúa en la reducción de las concentraciones de citoquinas proinflamatorias.

NUTRICIÓN ARTIFICIAL

Está indicada cuando la alimentación convencional es insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales. También está indicada como soporte nutricional en el perioperatorio, en la EII pediátrica y como coadyuvante en el tratamiento con corticoides (Tabla I).
Hay dos tipos de nutrición artificial: la nutrición parenteral total (NPT) y la nutrición entera (NE).

Tabla I
MANEJO NUTRICIONAL DE LA EII. GUÍAS ASPEN 2002

Los pacientes con EII tienen un riesgo nutricional y deben someterse a *screening* para identificar los que necesitan seguimiento y tratamiento nutricional
Debe usarse NE en pacientes con EC que precisen soporte nutricional
La NP debe reservarse para aquellos pacientes con EII que no toleren NE
En casos de fístula asociada a EII y SIC (síndrome de intestino corto), puede utilizarse NP
Está indicado soporte nutricional perioperatorio en pacientes con EII severamente malnutridos y postponer intervención quirúrgica
No debe usarse como primera medida el «descanso intestinal» (NP)

Nutrición parenteral total

Se utiliza solamente cuando existan contraindicaciones absolutas para el uso de la nutrición enteral (NE).

Nutrición enteral

La nutrición enteral es de primera elección. Puede ser:
– **NE parcial:** a base de suplementos nutricionales que completarán las necesidades nutricionales del paciente.
– **NE total:** se administrará a través de sonda o vía oral.

Tipos de nutrición enteral

– **Poliméricas:** contienen proteínas completas. Son ricas en omega 3 y DHA. Contienen fibra. Se usan en periodos de remisión.
– **Oligoméricas:** contienen proteínas hidrolizadas y alto contenido en MCT (ácidos grasos de cadena corta), ambos de fácil digestión y absorción. No contienen fibra. Se emplean tanto en periodos de brote como de remisión.

Recomendaciones para la administración de las fórmulas enterales

– Debemos asegurarnos de que el paciente comprenda que la nutrición enteral forma parte de su tratamiento, y será fundamental para el completo restablecimiento de su estado nutricional y, por ende, de su situación clínica.
– Hay que instruir al paciente sobre las dosis e intervalos de las tomas para favorecer una adecuada adherencia.
– Se recomienda tomarlo a pequeños sorbos a través de la pajita que viene incorporada; de lo contrario podría aparecer diarrea.
– Las fórmulas deben tomarse entre las comidas, evitando sustituciones en la ingesta habitual.
– Son susceptibles de añadir aditivos, como café y cacao solubles, canela, etc., con el fin de hacerlas más atractivas y así asegurar el cumplimiento.
– La temperatura del producto puede ajustarse al gusto del paciente, siempre que si se calienta, no hierva.
– El suplemento, una vez abierto, se puede mantener en la nevera durante 24 horas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

– Ballesteros Pomar MD, Vidal Casariego A, Calleja Fernández A, López Gómez JJ, Urioste Fondo A, Cano Rodríguez I. Impacto de la nutrición en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Nutr Hosp 2010;25(2):181-92.
– Cabré Gelada E. ¿Dieta alta o baja en fibra en la enfermedad inflamatoria intestinal? Recomendaciones para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Información conjunta GETECCU/ACCU. Número 11. Año 2005. http://www.accuesp.com/mm/file/ consejosapacientes/consejos11.pdf
– Cabré Gelada E. Nutrición, dieta y EII. Recomendaciones para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Información conjunta GETECCU / ACCU. Número 1. Año 2008. http://www.accuesp.com/mm/file/consejosapacientes/boletin1_2008.pdf
– Costas Armada P, García-Mayor RV, Larrañaga A, Seguín P, Pérez Méndez LF. Tasa de desnutrición y respuesta al tratamiento nutricional específico en la enfermedad de Crohn. Nutr Hosp 2009;24(2):161-6.
– Gómez Candela C, Cos Blanco A, García Luna PP, Pérez de la Cruz A, Luengo Pérez LM, Iglesias Rosado C, et al. Complicaciones de la nutrición enteral domiciliaria: resultados de un estudio multicéntrico. Nutr Hosp 2003;18(3):167-73.
– Grau Carmona T, Bonet Saris A, Fernández Ortega F. Nutrición artificial en la insuficiencia intestinal: síndrome de intestino corto: Enfermedad inflamatoria intestinal. Nutr Hosp 2005;20(suppl.2):31-3.
– Pérez Tárrago C, Puebla Maestu A, Miján de la Torre A. Tratamiento nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nutr Hosp 2008;23(5):418-28.
– Valenzuela RB, Tapia OG, González EM, Valenzuela BA. OMEGA-3 ácidos grasos (EPA y DHA) y su aplicación en situaciones clínicas diversas. Rev chil Nutr 2011;38(3):356-67.

CAP. 3.4.5. BENEFICIOS DEL EJERCICIO

Noelia Cano Sanz
Enfermera Colaboradora de la Unidad de EII.
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

Una de las preguntas habituales que surgen durante la educación sanitaria de nuestros pacientes en la consulta es si van a poder tener una vida normal y, por lo tanto, poder continuar con sus actividades diarias como la práctica de ejercicio físico. La práctica de deporte no es la misma en un niño o adolescente enfermo que en un adulto. En los primeros años de vida, los deportes forman parte de los juegos y actividades vitales, mientras que en los adultos constituye una actividad complementaria. Es importante conocer los beneficios que la práctica de actividad física regular tiene sobre el curso clínico y la sintomatología psicológica asociada a la EII, así como saber que contribuye a combatir complicaciones derivadas de la propia enfermedad y del tratamiento. Por ello, los profesionales de la unidad de EII debemos estar informados para poder asesorar sobre las mejores prácticas de actividad física adaptadas a la edad, situación clínica y condición física de cada paciente.

OBJETIVOS

Objetivo general: describir los beneficios del ejercicio físico sobre la actividad inflamatoria de la EII y, en consecuencia, su repercusión sobre el curso clínico de la enfermedad.

Objetivos específicos:

- Identificar los factores más importantes en la limitación para la práctica del ejercicio físico que sufren los pacientes con EII.
- Aportar recomendaciones para la adaptación del ejercicio físico a condiciones particulares de cada paciente.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

El beneficio de la actividad física sobre la actividad inflamatoria de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) no está bien definido. Además, no existen recomendaciones claras sobre la práctica de actividad física para pacientes con EII. No obstante, desde el punto de vista molecular, Bliski y cols.[1] han descrito una estrecha interrelación a modo de «comunicación cruzada» por medio de citoquinas, de tal forma que las mioquinas segregadas por el músculo esquelético (especialmente durante la práctica de actividad física) pueden tener un efecto depresor de la producción de factores proinflamatorios por parte del tejido adiposo. Melinder y cols.[2], en un estudio epidemiológico con más de 240.000 hombres del Servicio Militar Nacional sueco seguidos durante más de 30 años, demostraron una incidencia aumentada de EII en pacientes con pobre condición física. Aunque la repercusión clínica de estos hallazgos no ha sido comprobada, son múltiples los estudios que apoyan el beneficio

de la actividad física sobre el desarrollo y control de la actividad de la EII. Así, Klare y cols.[3] randomizaron 30 pacientes con actividad de la enfermedad ligera-moderada a la realización de un programa de *running* de intensidad moderada 2 veces por semana durante 10 semanas. Los pacientes que realizaron actividad física regular demostraron un mejor control de la sintomatología que llegó a no ser limitante para la práctica de ejercicio, así como mayor grado de bienestar físico, social, desarrollo personal y calidad de vida.

Otros beneficios de la actividad física sobre los pacientes con EII recalan en un mejor control de la sintomatología psicológica asociada a la enfermedad crónica. Aunque la relación entre el estado psicológico y la actividad inflamatoria de la EII no están claramente establecidos, existen múltiples teorías en el campo de la psicoinmunoneurología que apoyan dicha relación. Independientemente de la posible repercusión sobre el curso clínico de la enfermedad, el adecuado control de los síntomas psicológicos resulta fundamental para la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Dos revisiones de la literatura[4,5] confirman, con notable coherencia entre los múltiples estudios incluidos, el carácter beneficioso de la práctica de actividad física regular en pacientes afectados de EII para la reducción del nivel de estrés y mejora de la calidad de vida. Asimismo, la práctica de actividad física permitió la prevención de complicaciones relacionadas con la enfermedad y su tratamiento, como la desmineralización ósea, el control del peso y los trastornos de la imagen corporal.

A pesar de los anteriores beneficios, los pacientes con EII presentan diversas limitaciones para la realización de actividad física regular derivadas de la enfermedad y su tratamiento. DeFilippis y cols.[6] describieron en 227 pacientes sometidos a una encuesta sobre sus hábitos de ejercicio la presencia de dichos factores limitantes. La fatiga fue referida como el síntoma más limitante, seguida del dolor articular, la vergüenza en relación con trastornos de la imagen corporal (ostomías, cicatrices por laparotomía, hábito cushingnoide por el consumo de corticoides, etc.) y la debilidad. Peluso y cols.[7] estudiaron el papel limitante de la artropatía en el papel limitante del ejercicio físico, apoyando la necesidad de asociar ejercicios de rehabilitación al tratamiento médico con anti-TNF. Vogelaar y cols.[8] describieron menor capacidad física en pacientes con EII afectados de fatiga crónica en comparación con aquellos que no la presentaban mediante test de ejercicios con cicloergómetro y ejercicios isométricos de piernas. Reconocieron, por tanto, al subgrupo de pacientes con fatiga crónica como especialmente vulnerables, requiriendo la adaptación de los programas de actividad física a su situación clínica.

A la hora de dar unas pautas a nuestros pacientes para la realización de actividad física, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones:

1. Las características del ejercicio físico no pueden ser estandarizadas sino individualizadas para cada paciente en particular, adaptándolas a su edad, condición física y situación clínica; preferiblemente guiada por profesionales con formación específica.
2. La intensidad de la actividad física debe ser en grado ligero-moderado, predominando el ejercicio aeróbico e isotónico (caminar, senderismo, marcha nórdica, natación, aquagym, baile, aerobic, Zumba®, etc.). Puede ser recomendable el uso de pulsómetros o sistemas de registro para limitar el exceso de esfuerzo. El ejercicio de alta intensidad, muy prolongado o isométrico (que implica frecuentes maniobras de Valsalva) no es recomendable en nuestros pacientes y puede incluso comportar consecuencias perjudiciales.
3. La actividad física debe realizarse de forma progresiva a lo largo del tiempo, debe ser regular (aproximadamente 3 veces por semana) y cada una de las sesiones debe constar de las correspondientes fases de calentamiento (especialmente importante en pacientes con artropatía), ejercicio y vuelta a la calma.

4. La actividad física no debe ser de tipo competitivo ni, en ningún caso, suponer un estrés adicional para el paciente. El único objetivo es el bienestar.
5. Son también recomendables aquellas actividades pseudodeportivas que favorecen las técnicas de respiración abdominal y la relajación, como el yoga, tai-chi, etc. Asimismo, la realización de ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico puede ser adecuada en pacientes con problemas de incontinencia fecal que no presenten hipertonía anal.
6. En el caso de los pacientes ostomizados, es útil el uso de fajas de contención para proporcionar una mayor seguridad en la realización del ejercicio.
7. La planificación de la actividad física puede ser útil, particularmente en el sentido de localizar recursos disponibles como la localización de los aseos públicos más cercanos o la posibilidad de interrumpirla cuando se desee. Estos factores añaden tranquilidad y confort a su práctica.
8. La adecuada hidratación antes y después del ejercicio, no durante, (particularmente en los pacientes ostomizados) es fundamental para evitar posibles cuadros de hipotensión, ya que las pérdidas de líquidos y electrolitos se ven aumentadas respecto de su situación basal.
9. En los pacientes con tratamiento con corticoides resulta especialmente importante limitar los ejercicios de carga e impacto sobre las articulaciones para evitar fracturas (son recomendables la natación, la bicicleta estática, el aqua-gym, el tai-chi, etc.).
10. Son aconsejables las actividades grupales, siempre que el paciente lo desee, y de tipo lúdico, ya que favorecen la integración social en niños y adolescentes.

En resumen, en general el ejercicio físico y los deportes son recomendables y pueden ser practicados por los enfermos a cualquier edad, siempre que la actividad de la enfermedad, con algunas de sus múltiples manifestaciones clínicas, no los limite o impida. Como profesionales, debemos asesorar a nuestros pacientes a realizar actividad física según edad, situación clínica y condición física.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bilski J, Brzozowski B, Mazur-Bialy A, Sliwowski Z, Brzozowski T. The role of physical exercise in inflammatory bowel disease. Biomed Res Int 2014;2014:429031.
2. Melinder C, Hiyoshi A, Hussein O, Halfvarson J, Ekbom A, Montgomery S. Physical fitness in adolescence and subsequent inflammatory bowel disease risk. Clin Transl Gastroenterol 2015;6:e121.
3. Klare P, Nigg J, Nold J, Haller B, Krug AB, Mair S, et al. The impact of a ten-week physical exercise program on health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease: A prospective randomized controlled trial. Digestion 2015;91(3):239-47.
4. Nathan I, Norton C, Czuber-Dochan W, Forbes A. Exercise in individuals with inflammatory bowel disease. Gastroenterol Nurs 2013;36(6):437-42.
5. Blagden S, Kingstone T, Soundy A, Lee R, Singh S, Roberts L. A comparative study of quality of life in people with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. Gastroenterol Nurs 2015;38(4):268-78.
6. DeFilippis EM, Tabani S, Warren RU, Christos PJ, Bosworth BP, Scherl EJ. Exercise and self-reported limitations in patients with inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 2015;9.
7. Peluso R, Manguso F, Vitiello M, Iervolino S, Di Minno MN. Management of arthorpathy in inflammatory bowel diseases. Ther Adv Chronic Dis 2015;6(2):65-77.
8. Vogelaar L, van den Berg-Emons R, Bussmann H, Rozenberg R, Timman R, van der Woude CJ. Physical fitness and physical activity in fatigued and non-fatigued inflammatory bowel disease patients. Scand J Gastroenterol 2015;50(11):1357-67.

CAP. 3.4.6. ASPECTOS PSICOSOCIALES

Noelia Cano Sanz[1] y Diana Muñoz Gómez[2]
Colaboración de Montserrat González López[3]

[1]Enfermera Colaboradora de la Unidad de EII. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)
[2]Enfermera de la Unidad de EII. Hospital La Fe. Valencia
[3]Psicóloga. Terapeuta EMDR. León

Uno de los objetivos principales de la atención que se ofrece desde la consulta especializada en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es conseguir la máxima normalidad en la vida de nuestros pacientes, lo que equivale no sólo al adecuado control de la enfermedad sino a la normalización de su desarrollo psicosocial para obtener la mejor calidad de vida posible.

La mente y el cuerpo están conectados, de forma que los aspectos psicológicos influyen en la salud a través de las emociones. Las emociones son procesos adaptativos, tienden a reestablecer el equilibrio cuando el organismo percibe peligro, amenaza o desequilibrio. No obstante, la función adaptativa de las emociones va a depender de la evaluación que la persona haga del estímulo, del significado que le dé y de la respuesta de afrontamiento que genere. Las emociones perturbadoras, negativas, tales como la ira, la ansiedad, la depresión o el estrés, influyen negativamente en la salud y modifican el funcionamiento del sistema inmune (psiconeuroinmunología). Bajo el prisma de las teorías psicológicas del procesamiento de la información, aquellas experiencias traumáticas que nuestro cerebro no ha procesado de forma adaptativa podrían incidir en la salud emocional del sujeto, y esto se evidencia en el cuerpo. Así, cuando nuestra mente no da salida a las emociones perturbadoras, el cuerpo les da salida. De esta forma, se debe considerar casi de forma imprescindible en pacientes con EII que durante la evaluación psicológica sean también explorados los apegos y acontecimientos vitales no resueltos (traumas)[1].

Desde las unidades de EII, y especialmente desde la consulta de enfermería, se debe, además de tratar la enfermedad desde el punto de vista biológico, tener en cuenta sus factores psicológicos para intervenir en sus emociones con el objetivo de mejorar su salud.

Es muy importante remarcar que los factores psicosociales no son causa directa de enfermedad, pero sí desempeñan un rol esencial en la alteración de la susceptibilidad del paciente a la enfermedad o aparición de brotes de la misma. Por lo tanto, es necesario atender las necesidades psicológicas de los pacientes al mismo tiempo que las médicas.

OBJETIVOS

Objetivo general: identificar y describir los factores relacionados con la EII que condicionan un impacto psicológico en el paciente.

Objetivos específicos:

- Conocer las necesidades de nuestros pacientes para poder llevar a cabo un normal desarrollo de su actividad sociolaboral y de la vida cotidiana.
- Describir las técnicas de psicoterapia más útiles en el control de la sintomatología psicológica.

ASPECTOS PSICOSOCIALES

A pesar de tratarse de una patología con una prevalencia inferior a la de otras enfermedades más comunes en España, como el cáncer o la diabetes, la EII tiene un elevado impacto tanto social como psicológico para el paciente, así como económico para el sistema sanitario. A esto se le suma el alto grado de desconocimiento por gran parte de la sociedad. Por lo general, la población está poco familiarizada con las implicaciones físicas y emocionales, por lo que se tienden a ignorar las necesidades de los pacientes. Por ello, la concienciación social sigue siendo uno de los retos más importantes de la enfermedad y un factor clave para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Se estima que un 75 % de los pacientes se han sentido deprimidos en algún momento durante el transcurso de la enfermedad[2]. Esto se debe, en parte, a diversos factores como el sentimiento de incomprensión, la imprevisibilidad de los brotes, la necesidad de tener un baño cerca, el miedo a las hospitalizaciones y cirugías, el riesgo de complicaciones y el pudor asociado a esta enfermedad. Estos factores impactan negativamente en la calidad de vida del paciente y generan repercusiones, tanto en lo personal como en lo laboral.

Los expertos consideran que el apoyo y comprensión por parte de familiares y amigos es fundamental. Sin embargo, el 27 % de los pacientes declaran que, en repetidas ocasiones, han sido objeto de burla debido a su frecuente necesidad de ir al baño[3].

Las actividades diarias más comunes también pueden verse afectadas y limitadas. La EII en pacientes jóvenes y niños provoca ausencias en los centros educativos y dificultad para el estudio. Por otro lado, los jóvenes recién diagnosticados se encuentran en una edad en la que deben tomar decisiones importantes acerca de su futura formación y podrían adoptar una actitud negativa o de baja autoestima. La mayoría de los pacientes en edad adulta habitualmente encuentran importantes dificultades para poder desarrollar su vida laboral con normalidad. En un estudio reciente en España, se estima que más de un 40 % de los trabajadores activos con EII se han ausentado de su trabajo en los últimos 3 meses debido a su enfermedad. El absentismo laboral es más elevado en nuestros pacientes en comparación con la población general debido a la sensación de cansancio y fatiga permanente, frecuencia de consultas médicas, dolor abdominal u hospitalizaciones. Sin embargo, y a pesar de tratarse de motivos justificados, uno de cada cinco pacientes declara haber recibido quejas por parte de sus superiores. Además, el 10 % de los pacientes dispuestos a tener un trabajo a tiempo completo se encuentran empleados de forma involuntaria a tiempo parcial a causa de padecer esta enfermedad[4].

Existen diferentes asociaciones de pacientes a nivel internacional que desarrollan una actividad fundamental para la concienciación social y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. En España, la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU) y sus delegaciones territoriales desarrollan acciones clave en este ámbito y prestan asesoramiento a pacientes y familiares.

El conocimiento de los aspectos diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad ayuda a nuestros pacientes a conseguir casi todos sus objetivos personales. En las formas graves, cuya evolución cursa con recaídas, el día a día y las relaciones sociales pueden alterarse. Es de suma importancia en niños y adolescentes que tanto los padres como los hijos acepten la existencia de la enfermedad y la naturaleza crónica de la misma. Con frecuencia, adoptan una actitud sobreprotectora nada recomendable porque impide el desarrollo de la autonomía de sus hijos.

En la escuela, los niños y adolescentes tienen que afrontar la relación con sus maestros y compañeros de clase. Los maestros deben ser informados sobre esta enfermedad, y los pa-

dres deben ser los encargados de facilitar esta información, convenientemente asesorados por los profesionales de la unidad de EII y las asociaciones de pacientes. La información deberá ser concreta pero suficiente para que el maestro participe de forma positiva y favorable en el proceso de adaptación del niño o adolescente a su vida escolar y le ayude a resolver algunos problemas que puedan surgirle, como la libertad absoluta para ir al baño sin pedir permiso. También deben ser tolerantes con las ausencias a clase debidas a controles o brotes de la enfermedad. Los compañeros y amigos pueden ser informados por el propio niño de forma natural y sencilla.

En la universidad y escuelas profesionales, la enfermedad no limita la realización ni práctica de ningún estudio o profesión. Es una etapa de la vida en la que aumenta su independencia y autonomía de la familia. Debe actuar solo, con mayor autocontrol y responsabilidad para tomar la medicación, informar de sus molestias y acudir a sus controles programados. Debe aprender a tomar decisiones personales supervisadas por los profesionales. Con este aprendizaje, incrementan su nivel de autoconfianza y su satisfacción personal.

Respecto al trabajo, en una sociedad competitiva se busca rentabilidad, por lo que la EII puede comportar un obstáculo a la hora de obtener un contrato. Asimismo, existen incentivos en las empresas para la contratación de pacientes con minusvalías. Una situación diferente es la del trabajador ya contratado que ha desarrollado la enfermedad. En el apartado de aspectos sociolaborales se desarrollan ampliamente los supuestos de incapacidad y minusvalía, así como los trámites requeridos para su solicitud. No obstante, la EII no es una enfermedad que excluya al candidato para cualquier puesto de trabajo. Aunque son enfermedades crónicas, suelen presentar largos periodos prolongados de inactividad que permiten desarrollar un rendimiento laboral normal.

Desde el punto de vista de la posibilidad de intervención sobre las alteraciones psicológicas asociadas a la EII, múltiples estudios en el campo de la psiconeuroinmunología[5] han relacionado la actividad de estresores, tanto artificiales como ambientales, con la capacidad de alterar múltiples aspectos del sistema inmune, tanto deprimiéndolo y predisponiendo al enfermo a la infección, como potenciando su respuesta en patologías de base autoinmune como la EII. Dicho nexo de unión entre la psique y la respuesta inmune vendría dado por, entre otros mediadores, los niveles de cortisolemia, regulados por los mediadores hipotalámo-hipofisarios, que actuarían como intermediarios[6,7]. Asimismo, además de la asociación con el estrés crónico y otras psicopatías, la EII ha sido relacionada con otras patologías crónicas propias de la población joven (enfermedad celiaca[8], psoriasis[9]) y trastornos digestivos funcionales (síndrome de intestino irritable[10,11]), presentados previa o durante el curso clínico de la EII, todos ellos, asimismo, asociados a grados variables de estrés crónico.

Desde este planteamiento, y como coadyuvancia al tratamiento médico convencional, múltiples intervenciones psicoterápicas han sido propuestas para el control de la respuesta emocional basal a la enfermedad y a los estresores ambientales. Destacando un papel primordial en la tolerancia al curso clínico crónico de pacientes con trastornos psicológicos de base (alexitimia[12,13], trastornos del estado de ánimo[12,14], personalidad perfeccionista[15]), estas intervenciones pueden, asimismo, ofrecer beneficio en la población general de enfermos afectados por EII en la mejoría de su calidad de vida, así como prevenir el desarrollo de procesos neuróticos comúnmente asociados, como el estrés y los trastornos de ansiedad y depresión[14]. Diferentes actuaciones han sido propuestas, con/sin la adyuvancia de tratamiento farmacológico, fundamentalmente orientadas hacia el refuerzo de la red de apoyos, la educación en el manejo de la enfermedad y las estrategias de afrontamiento para la prevención de brotes ante estresores externos o síntomas relacionados con el curso clínico.

Terapia de control del estrés y relajación

Los resultados obtenidos en los trabajos experimentales[16-19] concluyeron en un beneficio en la reducción del nivel de estrés de los grupos de pacientes sometidos a intervención superior al de los controles con, asimismo, mayor reducción de otro tipo de sintomatología asociada y de parámetros de percepción de calidad de vida. Sin embargo, las conclusiones del análisis realizado por los artículos de revisión condujeron a una falta de consenso entre los estudios incluidos, al presentar limitaciones metodológicas y no poder concluir un efecto beneficioso de las estrategias de control del estrés en la actividad y curso de la EII. Así, el cuándo y cómo las intervenciones orientadas al control del estrés psicológico y los trastornos del humor deben ser ofrecidas no queda completamente definido y, probablemente, dependa de una selección individualizada de candidatos en los que puedan demostrar beneficio, más allá de su aplicación sistemática.

Terapia educacional

La aplicación de la terapia educacional puede ser llevada a cabo en todos los casos de forma integrada en el proceso asistencial, principalmente en base a esquemas ambulatorios, individualmente o en grupos, con participación protagonista del personal de enfermería entrenado. Algunas de estas terapias pueden ser aplicadas de forma concomitante a otros abordajes psicoterápicos, como el control de estrés (mediante el entrenamiento de técnicas de relajación). La mayoría de la literatura[20-23] demuestra un efecto beneficioso en relación con una mejoría del conocimiento de los pacientes de la enfermedad, su sintomatología y manejo de los eventos clínicos presentados en su curso. No obstante, el impacto sobre factores como el estrés, la calidad de vida o el estado de ánimo es más controvertido y limitado.

Terapia comportamental y estrategias de afrontamiento

Son estrategias especialmente utilizadas en pacientes en edad pediátrica y adolescentes, con herramientas de afrontamiento y personalidad todavía no completamente definidas y, por consiguiente, con mayor plasticidad. En la mayoría de estudios[24-28] pudo apreciarse un beneficio en la reducción de las manifestaciones psicológicas, particularmente las depresivas; además sugieren un mejor control del curso clínico de la EII. No ha sido hallada asociación entre el nivel de estrés y la estrategia de afrontamiento desarrollada, aunque la más frecuentemente aplicada es la de afrontamiento emocional, generalmente más relacionada con niveles de ansiedad aumentados. Las estrategias de afrontamiento basadas en el escape-evitación suelen asociarse con niveles de depresión superiores.

Apoyo social

Esta terapia debe estar siempre presente durante cualquier interacción con el paciente, sea de intervención de psicoterapia o en la visita a la consulta de la unidad de EII, a fin de paliar deficiencias de soporte familiar/social o reforzarlas. La empatía y el respaldo recibido mejora, así como la relación del paciente con el personal sanitario, reduce el rechazo y puede

mejorar la adherencia terapéutica. Ha sido descrita[29,30] una asociación de los pacientes enfermos con mejor apoyo social con grados menores de variabilidad de la frecuencia cardiaca, respuesta fisiológica relacionada con una menor activación del sistema vegetativo simpático.

Tratamiento psicofarmacológico

La aplicación de psicofármacos de forma adyuvante al tratamiento de base para el control de la respuesta inflamatoria es un hecho común en los pacientes afectados por EII, dada la elevada prevalencia de trastornos psicológicos.
Puede indicarse la prescripción de psicofármacos en contextos de ansiedad, depresión, insomnio refractario junto con otras medidas que pudiesen ayudar como co-tratamientos en la EII; no obstante, deben ser siempre evaluados por un profesional especializado y considerar individualmente cada paciente. Actuando sobre aspectos como control de la ansiedad y/o depresión, han sido descritos beneficios como reducción del dolor, del insomnio, de la irritabilidad y de la urgencia defecatoria. Sin embargo, existen contradicciones sobre la eficacia del uso de antidepresivos y describen la necesidad de realizar nuevos estudios y protocolos consensuados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Servan-Schreiber D. Curación emocional: acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión sin fármacos ni psicoanálisis. Madrid: Debolsillo; 2010.
2. El estudio de las emociones en las personas afectadas por la Enfermedad de Crohn. GETECU y ACCU; 2010.
3. Wilson BS, Lönnfors S. The true impact of IBD: A European Crohn's and Ulcerative Colitis Patient Life. EFCCA; 2010.
4. Langbrandtner J, Raspe H, Hüppe A. Employees with chronic diseases - additional results of randomized controlled trial among adult members of a German statutory health insurance with inflammatory bowel diseases. Z Gastroenterol 2016;54(2):139-45.
5. Kemeny ME, Gruenewald TL. Psychoneuroimmunology update. Semin Gastrointest Dis 1999;10(1):20-9.
6. Hisamatsu T, Inoue N, Yajima T, Izumiya M, Ichikawa H, Hibi T. Psychological aspects of inflammatory bowel disease. J Gastroenterology 2007;42(supplement 17):34-40.
7. Kiank C, Taché Y, Larauche M. Stress-related modulation of inflammation in experimental models of bowel disease and post-infectious irritable bowel syndrome: Role of corticotropin-releasing factor receptors. Brain, behavior, and immunity. 2010;24(1):41-8.
8. Oxford EC, Nguyen DD, Sauk J, Korzenik JR, Yajnik V, Friedman S, et al. Impact of coexistent celiac disease on phenotype and natural history of inflammatory bowel diseases. Am J Gastroenterol 2013;108(7):1123-9.
9. Hsu LN, Armstrong AW. Psoriasis and autoimmune disorders: A review of the literature. J Am Acad Dermatol 2012;67(5):1076-9.
10. Quigley EM, Bernstein CN. «Irritable bowel symptoms» in inflammatory bowel disease: Diagnostic uncertainty meets pathological reality. Am J Gastroenterol 2012;107(10):1474-82.
11. Halpin SJ, Ford AC. Prevalence of symptoms meeting criteria for irritable bowel syndrome in inflammatory bowel disease: Systematic review and meta-analysis. 2012;107(10):1474-82.
12. Moreno-Jiménez B, Blanco BL, Rodríguez-Muñoz A, Hernández EG. The influence of personality factors on health-related quality of life of patients with inflammatory bowel disease. J Psychosom Res 2007;62(1):39-46.
13. Boye B, Lundin KEA, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, et al. The INSPIRE study: Do personality traits predict general quality of life (short form-36) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease? Scand J Gastroenterol 2008;43(12):1505-13.

14. Prasko J, Jelenova D, Mihal V. Psychological aspects and psychotherapy of inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome in children. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia. 2010;154(4):307-14.
15. Flett GL, Baricza C, Gupta A, Hewitt PL, Endler NS. Perfectionism, psychosocial impact and coping with irritable bowel disease: A study of patients with Crohn's disease and ulcerative colitis. J Health Psychol 2011;16(4):561-71.
16. Mizrahi MC, Reicher-Atir R, Levy S, Haramati S, Wengrower D, Israeli E, Goldin E. Effects of guided imagery with relaxation training on anxiety and quality of life among patients with inflammatory bowel disease. Psychol Health 2012;27(12):1463-79.
17. Milne B, Joachim G, Niedhardt J. A stress management programme for inflammatory bowel disease patients. J Adv Nurs 2009;11(5):561-7.
18. Cámara RJ, Begré S, von Känel R. The effect of stress-relieving interventions on inflammatory bowel disease: Quality assessment of 10 therapeutic studies 2010;56(2):116-35.
19. Keefer L, Keshavarzian A, Mutlu E. Reconsiderin the methodology of «stress» research in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2008;2(3):193-201.
20. Belling R, McLaren S, Woods L. Specialist nursing interventions for inflammatory bowel disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006597.
21. Boye B, Lundin KE, Jantschek G, Leganger S, Mokleby K, Tangen T, et al. INSPIRE study: does stress management improve the course of inflammatory bowel diseaseand disease-specific quality of life in distressed patients with ulcerative colitis or Crohn'sdisease? A randomized controlled trial. Inflamm Bowel Dis 2011;17(9):1863-73.
22. Goodhand J, Hedin CR, Croft NM, Lindsay JO. Adolescents with IBD: The importance of structured transition care. Journal of Crohn's and Colitis 2011;5(6):509-19.
23. Lange A, Haslbeck E, Andus T, Bregenzer N, Gross V, Schölmerich J, et al. Ambulatory education of patient with Crohn disease/ulcerative colitis. Z Gastroenterol 2011;34(7):411-5.
24. Reed-Knight B, McCormick M, Lewis JD, Blount RLJ. Participation and attrition in a coping skills intervention for adolescent girls with inflammatory bowel disease. Clin Psychol Med Settings 2012;19(2):188-96.
25. Keefer L, Kiebles JL, Martinovich Z, Cohen E, Van Denburg A, Barrett TA. Behavioral interventions may prolong remission in patients with inflammatory bowel disease. Behav Res Ther 2011;49(3):145-50.
26. Thompson RD, Craig A, Crawford EA, Fairclough D, Gonzalez-Heydrich J, Bousvaros A, et al. Longitudinal results of cognitive behavioral treatment for youths with inflammatory bowel disease and depressive symptoms. J Clin Psychol Med Settings 2012;19(3):329-37.
27. Mackner LM, Crandall WV, Szigethy EM. Psychosocial functioning in pediatric inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006;12(3):239-44.
28. Iglesias-Rey M, Barreiro-de Acosta M, Caamaño-Isorna F, Rodríguez IV, González AL, Lindkvist B, et al. How do psychological variables influence coping strategies in inflammatory bowel disease? 2013;7(6):e219-26.
29. Maunder RG, Nolan RP, Hunter JJ, Lancee WJ, Steinhart AH, Greenberg GR. Relationship between social support and autonomic function during a stress protocol in ulcerative colitis patients in remission 2012;18(4):737-42.
30. Cámara RJ, Lukas PS, Begré S, Pittet V, von Känel R. Effects of social support on the clinical course of Crohn's disease 2011;17(6):1277-86. doi: 10.1002/ibd.21481.

CAP. 3.4.7. VACUNAS

M.ª del Carmen Morete Pérez
Enfermera de Unidad de EII. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. A Coruña

Las vacunas son productos biológicos responsables de estimular la producción de anticuerpos y generar inmunidad, pero sin capacidad para provocar la enfermedad. Atendiendo al microorganismo que la compone y a su método de obtención, distinguimos entre vacunas de microorganismos vivos atenuados (preparaciones que activan el sistema inmune provocando una respuesta similar a la infección natural sin llegar a causar la enfermedad), y vacunas de microorganismos muertos o inactivados (mantienen la capacidad de activar el sistema inmune pero no la capacidad de provocar la enfermedad).

Implementar programas de vacunación adaptados y actualizados a las diferentes situaciones epidemiológicas y zonas geográficas desempeña un importante papel en la política sanitaria mundial. La erradicación o reducción de enfermedades prevenibles mediante las vacunas disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas y aumenta la esperanza de vida.

En España, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) propone el Calendario Común de Vacunas, en el que se basan los elaborados por las comunidades autónomas con algunas variaciones (Tabla I). Las recomendaciones se evalúan y actualizan periódicamente.

La actuación de los profesionales de enfermería es relevante para complementar los programas de vacunación implicados en los procedimientos de información y administración de las vacunas.

Legalmente en España, las vacunas tienen consideración de medicamentos sujetos a prescripción médica, estando vigente en la actualidad el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que regula la prescripción y administración de medicamentos por el colectivo de enfermería.

OBJETIVOS

Objetivo general: destacar la importancia de alcanzar la inmunización para enfermedades prevenibles en los pacientes de EII desde el momento del diagnóstico, mediante pautas de vacunación adecuadas.

Objetivos específicos:

- Elaborar tablas como herramientas de apoyo para facilitar la realización del procedimiento por el profesional de enfermería en las unidades de EII, sintetizando los conceptos y principios básicos para la administración de vacunas.
- Realizar un resumido protocolo de actuación adaptable a las características y práctica asistencial de cada unidad.
- Con el objeto de simplificar el acceso a consultas e información actualizada, se incluye una relación de páginas de referencia avaladas y revisadas periódicamente.

Tabla I
CALENDARIO DE VACUNAS ESTÁNDAR 2016[a]

EDAD	VACUNAS
Embarazo	Difteria/tétanos, tosferina (entre semanas 28-36 de embarazo), gripe (estacional)
Recién nacido	Hepatitis B (madres portadoras)
2 meses	Hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzaae b, polio parenteral, hepatitis B) + neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzaae b, polio parenteral) + neumococo conjugado + meningitis meningocócica C
6 meses	Hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzaae b, polio parenteral, hepatitis B)
12 meses	Triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis) + neumococo conjugado + meningitis meningocócica C
15 meses	Varicela
18 meses	Pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzaae b, polio parenteral)
3-4 años	Triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis)
6 años	Difteria, tétanos, tosferina
12 años	Meningitis meningocócica C Varicela (a los NO inmunizados administrar 2 dosis separadas 4-8 semanas) Virus papiloma humano (2 dosis 0-6 meses, sólo niñas)
14 años	Difteria, tétanos
Adultos	Difteria, tétanos (hasta 5 dosis en total si no hay constancia de vacunaciones previas)
Adultos > 60 años	Neumococo (VNP 23) (1 dosis) Gripe (anual)

[a]Este calendario vacunal es un compendio de los datos recogidos en las citas bibliográficas 1 y 2.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII), INMUNOCOMPROMISO Y ENFERMEDADES PREVENIBLES

El grado de inmunocompetencia de una persona con EII se verá modificado a lo largo de su vida, aumentando la posibilidad de padecer una infección oportunista o desarrollar un cuadro de mayor gravedad.

Los tratamientos inmunosupresores, las terapias biológicas y la malnutrición (presente en la EII por numerosos factores) están asociados al riesgo de desarrollar una infección oportunista (Tabla II). El hipoesplenismo funcional en la colitis ulcerosa, la comorbilidad, los antecedentes de infecciones graves y la edad son factores independientes, pero a considerar, ante la posibilidad de contraer una enfermedad infecciosa.

La Declaración del Segundo Consenso Europeo sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas en la EII (2014) de la Organización Europea de Crohn y Colitis (ECCO) recomienda determinar el nivel de seroprotección en los pacientes al diagnosticar una EII y verificar la detección del riesgo de infecciones oportunistas adaptado a las condiciones locales. También aconseja la administración de las vacunas necesarias para completar la inmunización precoz mediante estrategias de vacunación, con el objetivo de prevenir que desarrollen una infección inmunoprevenible; es una medida efectiva y segura que reportará mayor beneficio a los pacientes con EII que a la población en general.

En la práctica clínica, alrededor del 50 % de los pacientes con EII se mantienen sin inmunizar adecuadamente. Esto evidencia una falta de percepción del riesgo real de infección, cuando sabemos que estos enfermos recibirán a lo largo de su vida tratamientos con corticoides (80 %), tiopurinas, metotrexato y/o inhibidores de la calcineurina (40 %) y terapias biológicas (20 %), cuyos mecanismos de acción comprometen la respuesta inmune, acción que se potencia al combinar más de un fármaco.

Tabla II
FACTORES ASOCIADOS A INMUNOCOMPROMISO EN LA EII

Pacientes que reciben dosis de: ≥ 20 mg/día de corticoides durante ≥ 2 semanas, azatioprina, mercaptopurina, metotrexato, tacrólimus, ciclosporina, tratamientos biológicos
Pacientes con malnutrición severa
Situaciones de inmunocompromiso adquirido o congénito

INDICACIONES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS EN PACIENTES CON EII

– Una vez diagnosticada la EII, hay que documentar el estado de inmunización del paciente y, siempre que no exista contraindicación, completar el calendario de vacunación actualizado ante la probabilidad de introducir en un futuro terapias que alteren la respuesta inmune. En el supuesto de estar iniciado un tratamiento inmunomodulador o en situación de inmunosupresión, se debe retrasar la vacunación. Hay que valorar, una vez suspendido, el momento idóneo para administrar las vacunas y obtener una respuesta óptima (Tabla III).

Tabla III

RECOMENDACIÓN DE VACUNAS EN PERSONAS CON EII (2014)[a]

VACUNA	PACIENTE EII SIN INMUNOCOMPROMISO	PAUTA ADMINISTRACIÓN	PACIENTE EII CON INMUNOCOMPROMISO	PAUTA ADMINISTRACIÓN
Difteria/Tétanos/ Tosferina (toxoide)	NO vacunados Vacunados	Primovacunación 3 dosis iniciales (0, 1-2, 7-14 meses) 1 dosis c/10 años hasta completar 5 dosis	No vacunados/seronegativos	Primovacunación 3 dosis iniciales (0, 1-2, 7-14 meses) 1dosis c/10 años hasta completar 5 dosis
Hepatitis A (virus inactivado)	Preadolescentes no vacunados y grupos de riesgo profesional/ estilo de vida	2 dosis (0,6 meses)	Seronegativos	2 dosis (0, 6 meses)
Hepatitis B	No vacunados/no inmunizados (anti-HBs y anti-HBc negativos)	3 dosis (0, 1, 6 meses)*	Seronegativos	4 dosis a doble concentración (0, 1, 2 y 6-12 meses)*
Gripe (virus inactivados)	Según edad/comorbilidad o grupos de riesgo profesional	1 dosis anual	No vacunados ese año	1 dosis anual
Neumococo (VNP23 y VNC13)	No vacunados Vacunados con VNP23 A partir de 65 años	1 dosis inicial VNP23 en < 49 años VNC13 en > 50 años 1 dosis VCN13 a partir de 50 años 1 dosis VNP23	No vacunados Vacunados A partir de 65 años	1 dosis inicial VNP23, revacunación a los 5 años Revacunar con VNP23 a los 5 años de 1ª dosis y con VNC13 > 50 años 1 dosis única VNP23
Sarampión/rubeola/ parotiditis (virus vivos atenuados)	No inmunizados	1 o 2 dosis con intervalo ≥ de 28 días	No inmunizados	Contraindicada**
Varicela (virus vivo atenuado)	No inmunizados	2 dosis (0, 1-2 meses)	No inmunizados	Contraindicada**
VPH virus papiloma humano (prt. rec. tetravalente: tp (6, 11, 16, 18)	Mujeres entre 11-14 años (valorar hasta los 26 años)	administrar 3 dosis (0, 2, 6 meses)***	Mujeres antes de iniciar relaciones sexuales/valorar hasta los 26 años	Administrar 3 dosis (0, 2, 6 meses)***
Meningococo Grupo C		No recomendada	No vacunados	1 dosis única
Haemophilius influenziae tipo B		No recomendada	No vacunados	1 dosis única

**Evaluar respuesta serológica a 1-2 meses de administrada la última dosis, recomendación de revacunar con igual pauta y dosis con valores HBs ≤ 10 UI/ml. Indicación de utilizar una pauta acelerada a dosis doble en pacientes inmunodeprimidos, y pauta rápida si interesa una inmunización precoz. **Considerar riesgo potencial/beneficio en pacientes no inmunizados y alta exposición a la infección de vacunar previa retirada del tratamiento inmunosupresor durante un periodo mínimo entre 3-6 meses. Siempre aconsejar vacunar dos semanas antes de iniciar tratamiento inmunosupresor. ***La ECCO recomienda vacunar a hombres y mujeres de acuerdo a las directrices nacionales.*

[a] Estas recomendaciones son un compendio de los datos obtenidos de las citas bibliográficas 3-5.

– Las vacunas de microorganismos vivos atenuados, en general, están contraindicadas en pacientes con inmunocompromiso (Tabla III). Para administrar vacunas atenuadas con seguridad se requiere que hayan transcurrido tres meses desde que finalizó el tratamiento inmunosupresor. En el caso de corticoterapia, se considera como seguro el intervalo de un mes.
  En el supuesto de haber administrado las vacunas y precisar iniciar un tratamiento inmunosupresor, se recomienda respetar el intervalo de un mes desde la administración de la vacuna antes de introducirlo.
– Las vacunas de microorganismos inactivados, las polisacáridas y los toxoides pueden administrarse con seguridad en pacientes inmunocomprometidos (Tabla III). Conociendo que la respuesta inmune puede ser menor que la alcanzada por la población sana, es preferible administrarlas con anterioridad, mínimo 15 días antes de iniciar terapias inmunosupresoras, para lograr una óptima respuesta inmune.
– Son necesarios más estudios sobre la respuesta y pautas de vacunación adecuadas en los pacientes con EII. En comparación con la población general, se ha observado menor nivel en la respuesta inmune de los pacientes con EII a la vacuna de la hepatitis B (recomendación de monitorizar la respuesta serológica transcurridos 1-3 meses desde la última dosis), anti-gripal y vacuna neumocócica. La respuesta en la vacuna contra el virus del papiloma humano parece similar a la observada en la población sana. Los datos sobre inmunogenicidad de la vacuna contra el tétanos son contradictorios, y los estudios que evalúan la respuesta a las vacunas contra el sarampión, paperas, rubeola, varicela y herpes zóster (autorizada en EE. UU.) son escasos en pacientes con EII.

VACUNAS EN MUJERES EMBARAZADAS CON EII

Una paciente diagnosticada de EII en edad fértil habitualmente planifica un embarazo en la situación idónea durante un periodo inactivo de la enfermedad y el calendario de vacunas actualizado.
En circunstancia distinta, hay que valorar la administración de vacunas cuando exista un riesgo elevado de contraer la infección y que ésta suponga peligro para la madre o el feto. Se considera el interés del beneficio materno y la ventaja de proteger al feto o recién nacido por la transferencia, a través de la placenta, de anticuerpos o patógenos inducidos por las vacunas maternas.
Se recomienda evitar administrar vacunas en el primer trimestre de embarazo. Las vacunas con microorganismos vivos atenuados están contraindicadas durante toda la gestación.
Las vacunas recomendadas durante el embarazo son la antigripal (administrada durante la temporada estacional), tétanos/difteria y tosferina en el tercer trimestre (Tabla I).

VACUNAS EN EDAD PEDIÁTRICA Y ADOLESCENCIA CON EII

Al diagnosticar una EII en edad pediátrica y adolescencia, es obligado revisar el historial de vacunas administradas (Tabla I) y el adecuado nivel de inmunización del paciente.
– La recomendación en niños con EII es administrar las vacunas actualizadas estándar según corresponda a su edad (Tabla II). El especialista puede valorar administrar una pauta acelerada o de rescate.

– En pacientes inmunodeprimidos, como norma general, están contraindicadas las vacunas con microorganismos vivos desde un mes antes del inicio del tratamiento inmunosupresor, hasta tres-seis meses después de finalizado. Las vacunas inactivadas pueden administrarse con seguridad.
– El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomienda especialmente administrar las vacunas contra el neumococo, la antigripal (dosis anual a partir de los seis meses), contra la hepatitis A (2 dosis con intervalo de 6 meses a partir de un año de edad) y contra la hepatitis B (3 dosis) en niños/adolescentes no vacunados. Hay que realizar el control serológico de anticuerpos y valorar la necesidad de administrar dosis de refuerzo, revacunar a dosis doble si no posee títulos adecuados de inmunización, y la posibilidad de administrar la vacuna combinada VHA y VHB. La vacuna del meningococo C debe administrarse a los niños y adolescentes no vacunados a cualquier edad (2 dosis). Se recomienda la vacuna del meningococo B, considerada con perfil de vacuna sistemática (no financiada), a grupos con riesgo de sufrir infección meningocócica (administrar a partir de los dos meses de edad).
– En los recién nacidos cuyas madres fueron tratadas con fármacos anti-TNF durante el embarazo, se debe evitar administrar vacunas con virus vivos atenuados hasta que el recién nacido cumpla 6 meses de edad o haya transcurrido este periodo desde la última dosis recibida por la madre gestante.

VACUNAS DE CONVIVIENTES CON PACIENTES EII

Con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de infecciones prevenibles, está indicada la protección indirecta mediante la vacunación de los convivientes de pacientes con EII (contactos domiciliarios y profesionales sanitarios). La recomendación es tener actualizado su calendario de vacunaciones, en especial la triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis), la varicela, hepatitis A y la gripe (anual).

VACUNAS, VIAJES Y EII

Las personas con EII que planifican un viaje internacional, especialmente a zonas económicamente deprimidas, con enfermedades endémicas y convivencia con la población local, precisan contactar con su equipo asistencial para programar con antelación suficiente (2-4 meses) la administración de vacunas y recibir las indicaciones sobre medidas profilácticas y de prevención. La finalidad es asegurar una correcta protección antes de la fecha de salida contra las enfermedades prevenibles (Tabla IV).
– Los pacientes de EII que no reciben tratamiento inmunomodulador deben recibir las vacunas recomendadas y obligatorias indicadas según destino y riesgo individual (edad, profesión, etc.) o ambiental (brotes epidémicos, contacto con animales, catástrofes, etc.) de contraer una enfermedad.
– Los pacientes de EII con inmunocompromiso (más vulnerables a las enfermedades infecciosas y probabilidad de desarrollar cuadros más graves) tienen recomendación de administrar las vacunas inactivadas y confirmar serológicamente los niveles de protección. Como norma general, las vacunas de microorganismos vivos están contraindicadas hasta 3-6 meses de finalizada la terapia inmunosupresora. Se recomienda consultar con la unidad de medicina preventiva y Centro de Vacunación Internacional.

Tabla IV
RECOMENDACIÓN DE VACUNAS EN VIAJES INTERNACIONALES[a]

VACUNA	INDICACIÓN / CONTRAINDICACIÓN	ADMINISTRACIÓN
Difteria/Tétanos	Todo viajero no inmunizado	Parenteral (toxina bacteriana atenuada)
Hepatitis A	Viajero no inmunizado con destino a zona moderada/alta endemia	Parenteral (virus inactivado)
Hepatitis B	Todo viajero no inmunizado	Parenteral (antígenos)
Gripe	Grupos de riesgo que viajan a zonas con brotes	Parenteral (virus inactivados)
Sarampión/Rubeola/Parotiditis	Todo viajero no inmunizado Contraindicada en personas con inmunocompromiso y embarazo	Parenteral (virus vivos atenuados)
Meningococo	Todo viajero con destino a zonas con brotes de meningitis meningocócica	Parenteral (moléculas inactivadas que forman parte de la bacteria)
Cólera	Todo viajero con destino a zonas de alta endemia	Oral (bacterias o toxinas inactivadas)
Fiebre tifoidea	Todo viajero con destino a zonas de alto riesgo de enfermedad. Viajeros expuestos a malas condiciones higiénicas. No indicada en pacientes colectomizados. Contraindicada en personas con inmunocompromiso y embarazo	Parenteral (moléculas inactivadas que forman parte de la bacteria) Oral (cepa atenuada)
Poliomielitis	Todo viajero con destino a zonas endémicas y epidémicas	Parenteral (virus inactivados)
Encefalitis japonesa	Todo viajero con destino a zonas endémicas o epidémicas durante la estación de transmisión	Parenteral (virus inactivados)
Encefalitis por garrapata	Todo viajero con destino a zonas endémicas o epidémicas durante la temporada (mayo y octubre). Viajero con riesgo profesional	Parenteral (virus inactivados)
Rabia	Viajero con destino a zonas rurales donde sea la rabia endémica	Parenteral (virus inactivados)
Fiebre amarilla	Todo viajero con destino a zonas endémicas o epidémicas. Contraindicada en personas con inmunocompromiso y embarazo	Parenteral (virus vivos atenuados)

[a] Estas recomendaciones son un compendio de los datos obtenidos de las citas bibliográficas 1-6.

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS EN PACIENTES CON EII (FIGURA 1)

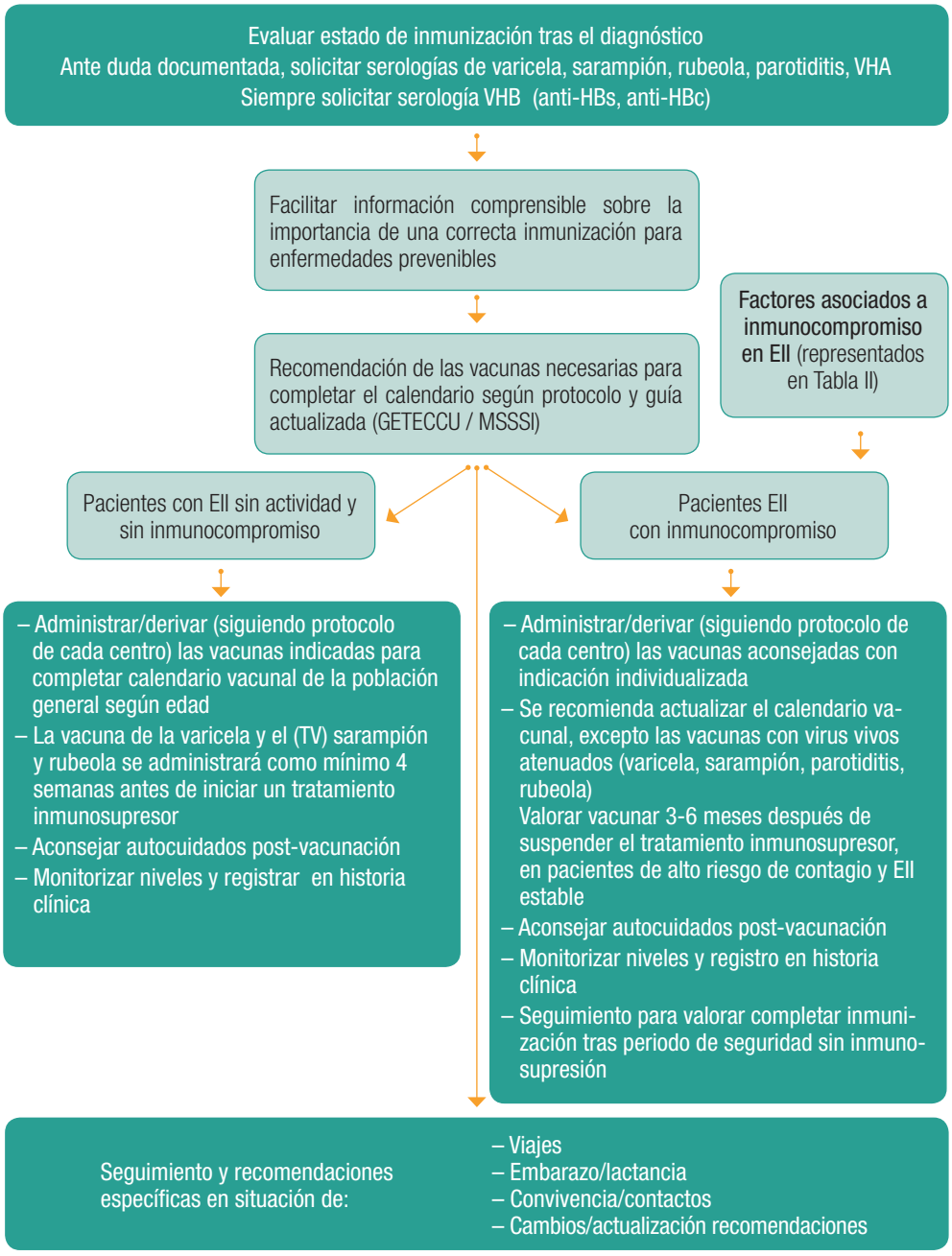


Figura 1. Algoritmo de actuación de enfermería para la inmunización de personas con EII.

Diagnosticada una persona de EII, se aconseja en la primera consulta de enfermería iniciar el procedimiento para valorar el riesgo de contraer infecciones oportunistas prevenibles y orientar al paciente de las vacunas y recomendaciones indicadas por las guías de consenso.

– Recogida de datos documentados de las vacunas administradas al paciente (historia clínica y calendario de vacunación) y estado de inmunización realizando las determinaciones serológicas necesarias. Reflejar edad, historia de enfermedades infecciosas, antecedentes de contraindicaciones, reacciones adversas, antecedentes de anafilaxia, situación clínica actual y estancias en zonas con enfermedades endémicas.
  Hay que sensibilizar al paciente sobre la importancia de cumplir la totalidad de las dosis del calendario de vacunación y la trascendencia de estar correctamente inmunizado, ante la probable introducción de terapias inmunosupresoras en un futuro por exacerbación de la enfermedad.
– Completada la valoración del estado de inmunización del paciente, se recomendará la administración de las vacunas o dosis incompletas conforme al Calendario de Vacunaciones y Guías de Consenso.
– Facilitar información completa oral y en formato asequible para el paciente, sobre los beneficios y riesgos de las vacunas recomendadas, así como los riesgos de la decisión de no vacunarse.
  Hacer hincapié en la indicación de respetar los periodos de seguridad para administrar vacunas atenuadas, recibiendo terapias inmunosupresoras. Advertir de la posible disminución en la respuesta de inmunización y necesidad de realizar una comprobación serológica.
– Resolver las dudas e inquietudes planteadas por el paciente y/o familia, previo al consentimiento verbal para la administración de las vacunas. Confirmar que ha comprendido la importancia que representa evitar el riesgo de desarrollar infecciones prevenibles en el futuro.
– Facilitar la información, el acceso y los trámites burocráticos para la administración de las vacunas recomendadas. El circuito variará en función de las características de cada centro. En el abordaje multidisciplinar, se realiza hoja de interconsulta al servicio de medicina preventiva para la administración de las vacunas recomendadas según protocolos consensuados con la unidad EII. En otros casos, es el personal de enfermería de la unidad EII o de atención primaria el responsable de administrarlas.
– Fomentar el autocuidado frente a posibles reacciones adversas leves (fiebre, eritema e inflamación en la zona de punción, episodio vaso vagal) con medidas tópicas y paracetamol/metamizol si la fiebre es inferior a 38 °C. Ante la persistencia de fiebre o efectos adversos de mayor intensidad, se recomienda acudir al centro asistencial de referencia para valoración.
– Registrar en la historia clínica dosis, fechas de administración y efectos adversos de cada vacuna administrada. Hay que tener en cuenta si existe indicación de monitorizar el nivel de seroconversión, solicitar la determinación y registrar resultados.
– Valorar si los niveles de protección alcanzados son óptimos o precisa dosis de refuerzo o revacunación.
– Prestar especial atención al colectivo de inmigrantes y personas que viajan frecuentemente o residen largas temporadas en comunidades socio-económicas deprimidas. El riesgo eventual de mayor exposición, origen en zonas con enfermedades con alta endemia y la probabilidad de estar incorrectamente vacunados, les convierte en potenciales agentes transmisores e importadores de enfermedades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad. La salud también viaja [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
2. Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad. Programa de vacunación [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/home.htm
3. García Sánchez V, Esteve Comas M. Manejo de las infecciones asociadas a tratamiento inmunomodulador. Vacunas. En: Hinojosa J, Nos P. Conductas de actuación en la Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal. Manual Práctico 6ª ed. GETECCU; 2014. p. 269-82.
4. Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa. Guías, Recomendaciones y Consensos [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://geteccu.org/formacion/guias-y-documentos-de-consenso
5. Rahier JF, Magro F, Abreu C, Armuzzi A, Ben-Horin S, Chowers Y, et al. Second European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2014;8:443-68.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Vaccines: HOME page for Vaccines and Immunizations site [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.cdc.gov/vaccines/

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y WEBS DE CONSULTA

– Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios. Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS. CIMA: Buscador principal [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
– Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://vacunasaep.org/profesionales
– Asociación Española de Vacunología [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.vacunas.org/
– Campins M, Martínez X, Cossio Y. Protocolo de vacunación de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene; 2012 [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2012/Protocolo_vacunacion_Inflamatoria_Intestinal.pdf
– Carrera E, Manzano R, Garrido E. La eficacia de la vacunación en la enfermedad inflamatoria intestinal J Gastroenterol Mundial 2013;19(9):1349-53.
– Comité Asesor de Vacunas. Internet y vacunas. En: Manual de vacunas en línea de la AEP. Asociación Española de Pediatría; 2015 [citado el 22 de abril 2016]. Recuperado a partir de: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-45
– Comité Asesor de Vacunas. Vacunación en niños inmunodeprimidos o con tratamiento inmunosupresor. En: Manual de vacunas en línea de la AEP. Asociación Española de Pediatría; 2015 [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-14
– EII Ferrol. Educainflamatoria. Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2013 [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.educainflamatoria.com/
– Marin AC, Gispert JP, Chaparro M. Inmunogenicidad y mecanismos que menoscaban la respuesta a las vacunas en la enfermedad inflamatoria intestinal. J Gastroenterol Mundial 2015;21(40):11273-81.
– The College of Physicians of Philadelphia. History of Vaccines [citado el 22 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.historyofvaccines.org/

3.4.8. VIAJES Y EII

M.ª del Carmen Morete Pérez
Enfermera de Unidad de EII. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. A Coruña

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), como toda enfermedad crónica, repercute en el estilo y calidad de vida del paciente. Tomar conciencia de la enfermedad y ser proactivo en el control de la propia salud conlleva disfrutar una vida plena readaptada a la nueva situación. Programar un viaje con EII requiere una planificación con antelación suficiente de los aspectos sanitarios, acorde a las características del desplazamiento. El objetivo es minimizar la exposición del paciente a potenciales riesgos de:

- Desarrollar un brote o una complicación de la EII desencadenadas posteriormente a padecer infecciones gastrointestinales adquiridas durante el viaje, cambios de hábitos alimenticios, condiciones higiénico-sanitarias, ambientales o privación de medicamentos.
- Adquirir una enfermedad infecciosa, especialmente al viajar a zonas en vías de desarrollo y con enfermedades endémicas a las que potencialmente pueden ser más vulnerables los pacientes con EII, especialmente si reciben tratamiento inmunosupresor.

OBJETIVOS

Objetivo general: desarrollar un protocolo, esquemático y manejable, que sirva de guía al personal de enfermería a la hora de informar y elaborar un plan de viaje, con las recomendaciones generales y las adicionales específicas para personas con una EII.

Objetivos específicos:

- Destacar la importancia que representa realizar previamente un análisis del estado de salud individualizado y de los potenciales riesgos del destino, así como de las actividades programadas durante la estancia.
- Elaborar los consejos y recomendaciones sanitarias dirigidas a realizar medidas de prevención antes y durante el viaje.
- Planificar el seguimiento durante el periodo del desplazamiento, si precisa, y en el momento del retorno. Las condiciones sanitarias se pueden modificar con rapidez, principalmente en zonas económicas deprimidas o por causas medio-ambientales, lo que obliga a adaptar las recomendaciones del viaje al momento y destino de manera urgente.
- El profesional sanitario precisa acceder a la información de interés actualizada, por lo que se incluye una relación de páginas web avaladas y revisadas.

CONSULTA PREVIA AL VIAJE

Se aconseja consultar con el equipo asistencial 2-4 meses antes de la fecha del viaje, con el fin de evaluar el estado clínico y tratamiento, las vacunas administradas y el nivel de inmunización del paciente. Los profesionales de enfermería facilitan la elaboración del plan de viaje aportando recomendaciones sobre las vacunas indicadas, medidas profilácticas, certificados, auto-cuidados, medicación y controles apropiados en función del medio de transporte, destino y tipo de estancia.

– **Vacunas:** al elaborar un plan de viaje, es buena ocasión para plantear administrar las vacunas sistémicas incompletas (ver Tabla III del apartado «Vacunas»), al tiempo que se indican las vacunas obligatorias o recomendadas según el destino y situación individual (ver Tabla IV del apartado «Vacunas»).

  La inmunización previa en los pacientes con EII sin inmunocompromiso debe seguir las pautas estándar para la población general, según destino.

  Si hay indicación de administrar vacunas de virus atenuados a pacientes con tratamiento inmunosupresor, valorar interrumpir el tratamiento durante 3-6 meses como periodo de seguridad previo a la administración.

  Completar las dosis de vacunas con tiempo suficiente para conseguir una protección adecuada antes del viaje. En pacientes con tratamiento inmunosupresor, hay que comprobar la respuesta mediante control serológico según el protocolo de vacunación.

– **Profilaxis:** evaluar, atendiendo a la zona de destino y exposición, el riesgo potencial de contraer enfermedades prevenibles. Revisar las medidas profilácticas y de protección actualizadas por los centros de vacunación y organismos de salud internacionales. Considerar especialmente las medidas orientadas a prevenir enfermedades transmitidas por insectos, virus influenza y enfermedades de transmisión sexual, además de:
  - Malaria: indicar iniciar antes del viaje quimioprofilaxis apropiada y mantenerla de una a cuatro semanas, según la zona de destino, después de abandonar la zona palúdica. Hay que recomendar evitar la exposición a picaduras de mosquitos (especialmente entre el anochecer y el amanecer). Consultar ante cuadro de fiebre, sudoración, escalofríos, cefalea, dolores musculares o vómitos.
  - Tuberculosis (TB): si el destino es zona de moderada o alta endemia de TB, se recomienda realizar cribado al regreso. Con resultado negativo, repetir a las 8-10 semanas después del regreso en: a) pacientes con EII y duración del viaje superior a un mes, b) pacientes EII inmunosuprimidos con independencia de la duración del viaje, y c) pacientes expuestos al contacto con TB activa.
  - Diarrea del viajero: extremar las precauciones respecto a la ingesta de alimentos y agua. No se tiene evidencia de mayor susceptibilidad en personas con EII sobre los viajeros sanos. En pacientes inmunodeprimidos recomendar iniciar tratamiento precoz con quinolonas ante un cuadro de diarrea.

  Hay que remarcar que la protección no es total al 100 % y que no disponemos de vacunas para todas las enfermedades, por tanto hay que aconsejar cumplir las medidas dirigidas a prevenir la exposición y el contagio, y consultar ante la duda durante el desplazamiento.

– **Medicación:** elaborar un listado contemplando las necesidades de:
  - Tratamiento habitual: hay que asegurar la disponibilidad de las dosis de medicación necesarias durante la estancia y un stock de reserva ante posibles eventualidades. Es importante elaborar una lista con nombre comercial, principio activo, dosis, indicación y

conservación. Se debe revisar la caducidad, medidas de conservación y seguridad en el transporte y posibles limitaciones de entrada al país de destino. Hay que resaltar la importancia de la adhesión al tratamiento.

- Medicación indicada en previsión de brote y síntomas generales: se debe recomendar llevar, durante el desplazamiento, una bolsa de mano con un kit de emergencias, incluyendo antipirético, analgésico, antidiarreico, quinolona/azitromicina, sales de rehidratación oral, suero fisiológico, toallitas sanitarias, solución antibacteriana, protector solar y antimosquitos, según requiera el destino.

  Es recomendable transportar la medicación como equipaje de mano y siempre en envases originales y una copia del informe médico acreditativo.

– **Documentación:** informar sobre la documentación requerida y facilitar la solicitud de:
  - Informe clínico: toda persona con EII debe llevar, cuando se desplaza, un informe médico donde conste filiación, resumen de la historia clínica, alergias, intervenciones quirúrgicas y tratamiento actual. Según el medio de transporte y duración del viaje, hay que indicar la dosis y vía de administración del tratamiento y recomendaciones específicas. Es aconsejable incluir un contacto del equipo asistencial habitual. En viajes internacionales se debe recomendar traducirlo al inglés o al idioma del país receptor.
  - Certificado o cartilla de vacunación correctamente cumplimentada con las vacunas administradas recomendadas y obligatorias según el destino. Excepcionalmente, el paciente en estado de inmunosupresión con un desplazamiento ineludible y que no tenga las vacunas obligatorias administradas, precisa aportar certificado de exención, y ser consciente del riesgo adicional que representa.
  - Certificado específico para portadores de estomas. Incluir una lista del material necesario para recambios de bolsa/irrigación y cuidado del estoma (especificando que es material sanitario seguro, nombre comercial, código, marca, proveedor y contacto).
  - Cobertura sanitaria: para viajar a los 28 estados de la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, se debe obtener la Tarjeta Sanitaria Europea. Toda la información y la solicitud de documentación puede realizarse por vía telemática o presencial en las oficinas del Instituto de la Seguridad Social y en el Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad.

  Para destinos fuera de Comunidad Europea, es preciso recabar información sobre la infraestructura sanitaria del país de destino, convenios y cobertura de los seguros médicos. Es aconsejable contratar un seguro de viaje con cobertura sanitaria, especificando estar diagnosticado de EII, que cubra las posibles contingencias relacionadas con la enfermedad, incluida la posibilidad de repatriación por vía aérea.

– **Medidas de protección y plan de autocuidados:** realizar las recomendaciones adaptadas al riesgo de exposición individual del paciente. Hay que recordar que debe mantener durante toda la estancia las medidas de prevención con especial cuidado sobre:
  - Alimentación: procurar mantener una dieta similar a la habitual. No consumir alimentos crudos, recalentados, evitar los puestos callejeros y de dudosa higiene. Utilizar agua embotellada para beber y para la higiene bucal, y rehusar los cubitos de hielo. Se recomienda llevar escrito en el idioma local e inglés los alimentos con intolerancia o restringidos.
  - Minimizar los potenciales efectos perjudiciales provocados por los cambios bruscos ambientales de temperatura, humedad y altitud. Es importante reforzar las medidas de protección solar en actividades y zonas con mayor exposición.
  - Evitar el contacto con animales vagabundos y salvajes (riesgo de arañazos, mordeduras), picaduras de insectos y zonas de aguas estancadas.

- Prevención ante un posible cuadro de diarrea. Se debe recomendar elegir ubicación en el medio de transporte y alojamiento con fácil acceso a los servicios. Igualmente facilita, siempre que estén actualizadas, llevar descargadas aplicaciones de localizador de baños. Si aparece un cuadro con diarrea, recomendar medidas dirigidas a evitar la deshidratación, pérdida de electrolitos y déficit nutricional.
- Es necesario elaborar una estrategia de abordaje personalizado ante un posible brote o aparición de síntomas con plan de autocuidados. Recabar información previa del servicio de gastroenterología y formas de contacto en zona de destino en previsión de una situación de urgencia.

– **Recomendaciones en condiciones especiales de viaje:**

- Cirugía reciente: valorar por el cirujano la conveniencia de viajar. Si el desplazamiento es en avión, recomendar medidas preventivas de síntomas funcionales intestinales y riesgo de trombosis venosa profunda.
- Paciente portador de estoma: elaborar una lista del material suficiente (tener presentes las condiciones ambientales, ejercicio físico y actividades para aprovisionar los tipos y cantidad de dispositivos) para realizar los recambios de bolsa/irrigación y el cuidado e higiene del estoma durante el desplazamiento. Distribuir el material para utilizar durante los traslados, acompañado del certificado específico en una bolsa de mano. Facturar el material restante, incluyendo copia del certificado.
  Es aconsejable, para viajes en avión, utilizar bolsas con filtro y consumir alimentos que no aumenten la producción de gases, malos olores y deposiciones. Es importante prevenir la deshidratación. Hay que lavar el estoma con agua embotellada o previamente hervida.
- Aconsejar realizar un cambio/vaciado de la bolsa antes de pasar los controles de seguridad.
- Viajes en edad pediátrica: especial atención en niños de edad inferior a 5 años con EII, y niños con situación de inmunosupresión. Hay que extremar el seguimiento si es una estancia prolongada en zona deprimida, visitas a familiares o de cooperación con integración en la población autóctona.
- En caso de precisar alimentación artificial (enteral o parenteral), averiguar las condiciones y requisitos para el transporte. Obtener informe específico y la provisión de material y dosis suficientes para la estancia, más un stock extra en previsión de emergencias.

CONTROLES Y SEGUIMIENTO

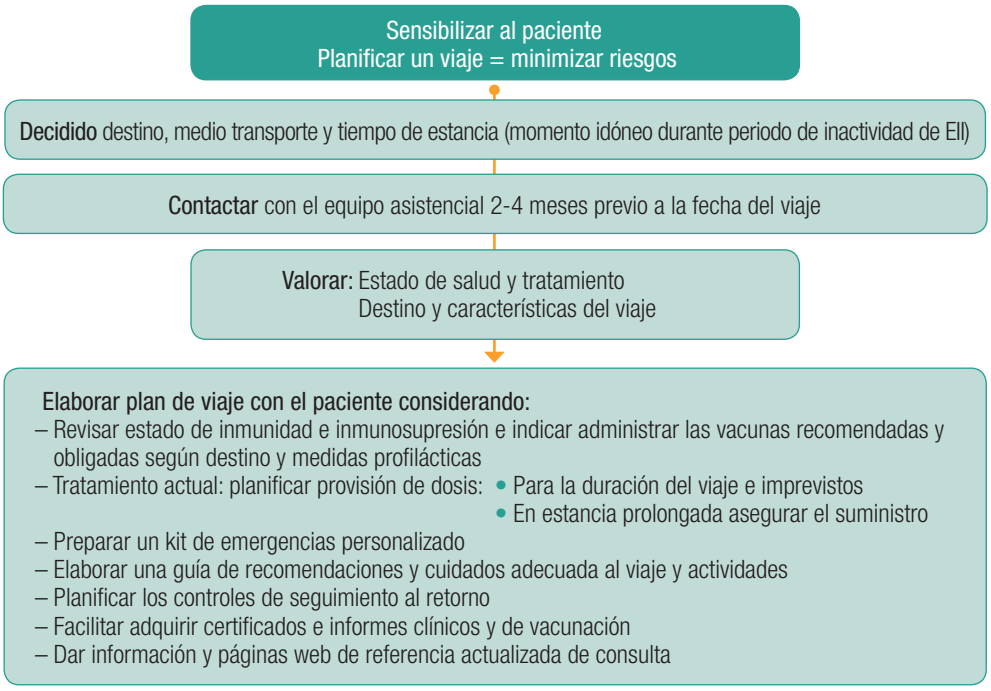
En estancias prolongadas (trabajo, estudios, cooperación, etc.) es recomendable planificar las visitas programadas de control y suministro de tratamiento/material por el equipo habitual, si las condiciones lo permiten.

Hay que facilitar, si es posible, los datos de contacto del equipo/unidad EII del destino. Es recomendable solicitar una cita a la mayor brevedad, con el fin de conocer y planificar los controles y asistencia durante la estancia.

Al regreso, está indicado planificar un control de seguimiento, especialmente para estancias en destinos con bajo nivel de condiciones sanitarias y/o exposiciones de riesgo.

Indicación de evaluación al regreso ante un cuadro de diarrea y realizar coprocultivo y determinación de huevos, quistes, parásitos (incluidos *Giardia lambia, C. parvum, Entamoeba histolytica*) y un hemograma para identificar eosinofilia, asociada a diarrea no inflamatoria. Contemplar la posibilidad de contagio por *S. stercolaris* por su capacidad de autoinfección y desarrollar clínica después de años, especialmente cuando se deteriora la inmunidad del huésped.

VIAJAR CON EII. GUÍA DE RECOMENDACIONES POR ENFERMERÍA



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y WEBS DE CONSULTA

- Aeropuertos-Aena [citado el 29 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.aena.es/csee/Satellite/aeropuertos/es
- Centers for Disease Control and Prevention, Travelers´Health. HOME.Vaccines.Advice [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: www.nc.cdc.gov/travel/destinations/list/
- Comisión Europea. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
- EII Ferrol. Educainflamatoria. Enfermedad Inflamatoria Intestinal; 2013 [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.educainflamatoria.com
- Grupoostomias [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: https://sites.google.com/site/grupoostomia/home
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Si viajas al extranjero [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-Asistencia Sanitaria Transfronteriza en la UE; 2013 [citado el 29 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.msssi.gob.es/pnc/home.htm
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La salud también viaja; 2013 [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
- Organización Mundial de la Salud [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: www.who.int/ith/
- Rahier JF, Magro F, Abreu C, Armuzzi A, Ben-Horin S, Chowers Y, et al. Second European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn´s and Colitis 2014;8(6):443-68.
- The Great British Public Toilet Map [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: https://sites.google.com/site/grupoostomia/home. Toilet Finder.[APP][citado el 28 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bto.toilet

3.4.9. SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN LA EII

Ana M.ª López Calleja
Enfermera Coordinadora de la Unidad de EII. Servicio de Gastroenterología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

La edad media de diagnóstico se sitúa entre los 15 y los 40 años, aunque cada vez es más habitual su aparición en edades más tempranas. Entre los factores desencadenantes de dicha enfermedad se barajan genéticos, ambientales y autoinmunes.

Al tratarse de una enfermedad crónica, puede llegar a afectar en gran medida a la calidad de vida del paciente, repercutiendo tanto en las dimensiones físicas como en las psicológicas, familiares y sociales. En cuanto al estrés, existen pocas dudas acerca de la influencia que tiene éste sobre la respuesta inmune de la mucosa intestinal, por lo que jugaría un papel muy importante como desencadenante y/o agravante de la sintomatología de estas enfermedades. Por tanto, aprender a manejar el estrés será uno de los aspectos más importantes a considerar para aumentar la calidad de vida del paciente.

Al pensar en hechos estresantes, siempre acuden a la mente sucesos negativos sin tener en cuenta que un hecho positivo puede ser igualmente estresante, como por ejemplo cambiar de casa, enamorarse, vacaciones, ascenso laboral o UN EMBARAZO.

El embarazo no aumenta el riesgo de un nuevo brote de la enfermedad si ésta se encuentra inactiva en el momento de la concepción.

Según diversos estudios, el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal no afecta de forma adversa a la evolución de la gestación o postparto inmediato, aunque algunos afirman que aumenta el riesgo de parto prematuro (Stephansson, 2010).

La decisión de no tener descendencia (el término utilizado en la literatura anglosajona es *«voluntary childlessness»*) se ha descrito hasta en un 30 % de las mujeres con diagnóstico de EII frente a un 7 % en la población general, y se ha relacionado fundamentalmente con el miedo a transmitir la enfermedad a la descendencia, a las complicaciones de la misma y a los efectos secundarios del tratamiento.

Se trata de una enfermedad que afecta a pacientes en plena edad reproductiva y cuya incidencia ha aumentado de forma progresiva en los últimos años. Por ello, la necesidad de atender a mujeres con EII que planean tener un embarazo es cada vez más frecuente.

Los profesionales que atendemos a estos pacientes, debemos informar *sobre el impacto de la enfermedad en la sexualidad, fertilidad, evolución del embarazo, lactancia, aspectos genéticos y de transmisión a la descendencia.*

OBJETIVOS

Objetivo general: informar adecuadamente a nuestras pacientes, incluso antes de la concepción, de todos los aspectos que pueden influir en un manejo adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en la sexualidad y durante el embarazo.

Objetivos específicos:

- Escuchar y dar apoyo al paciente en las relaciones personales y sexuales.

- Apoyar a planificar el embarazo en un momento de inactividad de la enfermedad, de tal manera que su curso durante la gestación sea el mejor posible.
- La medicación para la EII (excepto metotrexato, que no se recomienda su uso) debe valorarse su continuidad durante el embarazo. En la mayoría de los casos los beneficios superan los riesgos de la medicación. Se debe valorar tanto la medicación como el estadio de gestación para balancear el riesgo/beneficio.
- Reflexionar que para el feto es peor mantener activa la enfermedad que la propia medicación; por eso, es importante mantener la remisión y tratar de forma precoz la aparición de brotes con los fármacos oportunos.
- Conocer los riesgos y las ventajas de las exploraciones complementarias.
- Informar sobre los fármacos que pueden pasar a la leche materna.
- Comunicar que se debe evitar la administración de vacunas de virus vivos durante los 6 primeros meses en niños expuestos a anti-TNF intraútero.

LA SEXUALIDAD

Es natural preocuparse por el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en las relaciones personales y sexuales. La intimidad es una preocupación importante para muchas personas.
En una encuesta dirigida a pacientes, más del 50 % reconocía que la EII afectaba negativamente a sus relaciones, que había provocado un empeoramiento de su imagen corporal, una disminución de la libido y/o un descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales desde el diagnóstico. El impacto negativo era más importante entre las mujeres que entre los varones.
En otro estudio no se encontraron diferencias en la satisfacción sexual ni en la función eréctil entre los hombres en fase de remisión, pero sí un empeoramiento durante los brotes de actividad. Entre las mujeres, se observó un descenso de la satisfacción sexual respecto a los controles (personas sin EII) y más del 50 % refirieron que sus problemas de salud tenían un impacto negativo en su vida sexual. La depresión se identificó como el factor de mayor riesgo para disminuir la función sexual en los pacientes con EII.
En un estudio español se evaluó el impacto sobre la vida sexual en los pacientes con EII, antes y después del diagnóstico. Aproximadamente el 30 % de los hombres y el 47 % de las mujeres presentaron un empeoramiento del deseo sexual y de la satisfacción después del diagnóstico.
Sin embargo, las disfunciones sexuales no son exclusivas de la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que todas las enfermedades crónicas pueden provocar alteraciones de la esfera sexual.

¿Qué factores pueden alterar el funcionamiento sexual?

Generalmente, la alteración de la función sexual puede ser provocada por muchos motivos: por factores físicos derivados de la propia enfermedad, como el cansancio, la diarrea o el dolor abdominal, y por factores psicológicos, como problemas de autoestima, ansiedad o depresión.

Los factores físicos derivados de la propia enfermedad, como la presencia de un brote, provocan un impacto negativo sobre la percepción de salud, la calidad de vida y todos los aspectos de la sexualidad, especialmente el deseo. Síntomas como la fatiga, el dolor abdominal o la diarrea provocan un empeoramiento de la vida sexual. Además, la afectación perianal por la enfermedad de Crohn en forma de fisuras y fístulas puede cursar con dolor anal y supuración e interferir en las relaciones. Las fístulas con la vagina (rectovaginales), aunque poco frecuentes, pueden provocar dolor durante el coito (dispareunia) e infecciones genitourinarias.
Por otra parte, los factores psicológicos juegan un papel fundamental como causa y/o agravante en las disfunciones sexuales de los pacientes con EII. Las alteraciones del ánimo, especialmente la depresión, son el factor de riesgo más importante relacionado con el descenso de la función sexual. Además, la baja autoestima, el miedo al rechazo o la vergüenza a presentar síntomas como la incontinencia durante el acto sexual pueden interferir, evitando los contactos sexuales.

¿Pueden interferir los fármacos en la función sexual?

Los corticoides pueden provocar cambios de humor y efectos secundarios estéticos, como el aumento de peso, el acné o la aparición de vello, que pueden tener un impacto en la imagen corporal y la confianza en uno mismo, lo que puede influir negativamente sobre la sexualidad.
La sulfasalazina se asocia a una reducción del número de espermatozoides que puede provocar infertilidad (reversible al suspender el fármaco), pero no una alteración de la función sexual. No se han descrito disfunciones sexuales con el resto de los fármacos utilizados en la EII y la mejoría clínica debida al tratamiento contribuye a una mejora de la imagen corporal y de la energía que puede mejorar la función sexual.
Sin embargo, el 10 % de los pacientes de un estudio habían dejado de tomar la medicación por percibir efectos negativos en la libido o la actividad sexual.

¿Puede la cirugía afectar a mi vida sexual?

Muchos pacientes están preocupados por cómo la cirugía afectará a su sexualidad. Aunque puede afectar a la imagen corporal y a la autoestima sobre el atractivo sexual, la mayoría de los pacientes mantienen el deseo sexual y reanudan la actividad sexual después de la cirugía. Varios estudios muestran que la satisfacción global sexual suele mejorar tras la cirugía.
La cirugía con extirpación del recto puede lesionar los nervios pélvicos y ocasionar disfunción eréctil en el varón, alteraciones en la lubricación y dispareunia en la mujer. Aunque son complicaciones muy poco frecuentes, se debe informar a los pacientes de esta posibilidad antes de la intervención.

¿Se pueden tener relaciones sexuales siendo portador de una ostomía?

El hecho físico de portar un estoma no tiene por qué conllevar una disfunción sexual. A menudo, la realización de una ostomía va asociada a una mejoría de la salud y a un incremento de la energía que animan a retomar las relaciones.
Sin embargo, muchos de los pacientes pueden presentar trastornos de autoestima y de ánimo, o miedo a los accidentes con la bolsa de ostomía, como fugas de material fecal o

roturas, especialmente durante las relaciones sexuales. Es importante hablarlo con la pareja para restablecer la confianza. Se aconseja vaciar la bolsa antes de realizar el acto sexual, y hay pacientes que prefieren camuflar el estoma con ropa interior.

¿Puedo tomar anticonceptivos orales?

Con la evidencia disponible no se puede ser absolutamente concluyente acerca del efecto de los anticonceptivos orales (AO) en la EII. Globalmente, aunque hay datos contradictorios, los preparados que se emplean actualmente parecen seguros.
Sin embargo, en periodos de diarrea severa o vómitos de más de 24 horas, se debería actuar siguiendo las instrucciones del fármaco, como si se tratase de no haber tomado dicha medicación.
La indicación de la anticoncepción debe ser individualizada.
Su uso en estas pacientes es esencialmente el mismo que en mujeres sanas, con algunas consideraciones/limitaciones. Nos referimos a aquellas mujeres en las que su toma haya precipitado un brote previamente, algo siempre dudoso.
Su utilización está plenamente justificada en pacientes con problemas ginecológicos en los que así lo aconseje el ginecólogo, como pueden ser problemas funcionales que provoquen hipermenorrea, anemia o dolor abdominal.
Su eficacia como método anticonceptivo es la misma que en mujeres sin EII.

Contraindicaciones

– Pacientes con antecedentes de trombosis previas.
– Pacientes con antecedentes de cáncer ginecológico.
– Hipertensas.
– Diabéticas.
– Muy obesas.
– Tabaco.
El resto de los anticonceptivos también pueden recomendarse, excepto quizá el DIU porque no deja de ser un posible foco irritativo intra-abdominal y una causa potencial de enfermedad inflamatoria pélvica.

¿Cómo manejar los problemas de la esfera sexual?

Si bien es normal tener una disminución del deseo sexual durante un brote, la mayoría de pacientes no tiene ningún impedimento a causa de la enfermedad en fases de remisión, por lo que un factor fundamental para una vida sexual normal es el correcto control de la enfermedad.
Cuando las causas son físicas pueden ser debidas a la actividad de la enfermedad (incluidas las fístulas perianales), en cuyo caso el tratamiento con éxito de la enfermedad normalizará la función sexual. Sin embargo, en otros casos, como en los problemas de erección tras cirugía rectal o dispareunia, precisarán un tratamiento especializado de dicho trastorno.
No obstante, la mayoría de alteraciones son de causa psicológica por problemas de imagen corporal y autoestima, o por síntomas depresivos asociados a la enfermedad que, en algunos casos, pueden precisar de ayuda especializada.

Cuando la enfermedad aparece en un paciente con pareja que ha vivido el proceso de la enfermedad, probablemente es más fácil de asimilar. Sin embargo, hay que recordar que, además de los propios miedos, las parejas también tienen sus dudas y desconfianzas.
Algunos pacientes pueden tener miedo a iniciar una relación por la vergüenza que les provocan sus síntomas y la imposibilidad de hablar sobre su enfermedad. Es normal que revelar a una posible pareja que se padece una enfermedad crónica puede ser difícil y provoca inseguridad, sobre todo a una posible reacción negativa. Se debe decidir en qué momento de una relación es aceptable y necesario dar a conocer la enfermedad, y el intercambio de información puede aliviar una gran cantidad de estrés y ansiedad y reforzará la relación.

¿A quién puedo consultar?

Aunque las alteraciones sexuales asociadas a las enfermedades crónicas son frecuentes, es raro que los pacientes las planteen abiertamente como un problema. Mucha gente cree que las disfunciones sexuales no son un problema médico o que la mayoría se pueden resolver sin un tratamiento específico. Además, el sexo continúa siendo un tema cargado de prejuicios y desinformación, por lo que es frecuente que no tratemos los problemas sexuales con naturalidad. Es importante plantear los problemas para establecer el tratamiento individualizado más correcto.
A menudo, el tratamiento de la actividad de la enfermedad o de la desadaptación psicológica, especialmente la depresión, es suficiente y más eficaz que los tratamientos sexuales específicos.
Si el paciente no se encuentra cómodo discutiendo estos temas con el especialista de digestivo, es posible que le sea más fácil hacerlo con el personal de enfermería especializada, pero es importante identificar el problema y, en caso de necesidad, remitir a un especialista (psicología, sexología, urología, etc.).
En la mayoría de los pacientes, el control de la enfermedad y de los factores psicológicos permitirá una vida sexual normal.
«La clave para una buena relación es la comunicación y la confianza.»

ASPECTOS PREVIOS AL EMBARAZO

Consejo genético: ¿puede tener mi hijo una EII?

La EII presenta una etiopatogenia multifactorial y, aunque no puede considerarse una enfermedad hereditaria, existen factores genéticos que influyen en su desarrollo y que se deben mencionar durante el consejo pre-concepcional.
La pareja debe saber que existe un mayor riesgo en familias con personas afectas, y que este riesgo es mayor en la enfermedad de Crohn (EC) que en la colitis ulcerosa (CU).
Un complejo patrón de herencia poligénica no mendeliana es probablemente la responsable, en gran medida, del desarrollo de la EII.
Estudios epidemiológicos ponen de manifiesto que el factor de riesgo más importante, especialmente en el caso de la EC, es la historia familiar.

Los estudios en gemelos también lo confirman: en el caso de la EC la tasa de concordancia en gemelos monocigotos es casi del 50 %.
Si sólo uno de los dos progenitores la padece, el futuro hijo presenta un riesgo de desarrollar la enfermedad aproximadamente del 3,6 % (10 veces superior al de la población general).
Si ambos progenitores la padecen, el riesgo es mayor, aproximadamente del 20 %[1].
– Riesgo de un padre: • CU/CI: 1,6 %.
• EC: 5,2 %.
– Riesgo de ambos padres: • CU/EC: 36 %.
Se hereda la susceptibilidad a tener la enfermedad.

Fertilidad: ¿podremos tener un hijo?

Se denomina *fertilidad* a la capacidad potencial de generar descendencia.
El término *infertilidad* tiene, en general, un significado práctico y se define habitualmente como la disminución parcial o completa en la capacidad de concebir y tener descendencia tras un periodo de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin utilización de métodos anticonceptivos.
El término *fecundidad* se define como la capacidad real de concebir; se estima, por lo general, por periodos de tiempo y se expresa como *fecundabilidad*, que es la probabilidad de embarazo por ciclo menstrual al mantener relaciones sexuales sin protección.
Aunque es cierto que la información disponible no es demasiado amplia, *de forma general se considera que tanto varones como mujeres con una EII tienen la misma fertilidad que la población general.*

Ocasiones concretas en las que puede estar disminuida

– *Enfermedad activa o desnutrición:* por disminución de la libido y por decisión del paciente. Incluso parece que el semen del varón presenta ciertas alteraciones que se han relacionado con déficit de zinc.
– *Mujeres con EC, especialmente ileal/ileocólica:* en las que el proceso inflamatorio afecte al aparato reproductor.
– *Varones en tratamiento con sulfasalazina:* este fármaco produce alteración en el semen (oligoespermia, astenospermia, además de cambios morfológicos de los espermatozoides) en el 60-80 % de los pacientes que lo toman. Su efecto es reversible y desaparece tras unos 2 meses de la retirada del fármaco. Actualmente se utiliza la mesalazina que carece de estos efectos.
– *Infertilidad tras la cirugía previa, como colectomía total e ileostomía:* afecta especialmente a las mujeres, pero también puede afectar en el varón.

Consideraciones del tratamiento de la EII previo al embarazo

Es importante que el embarazo en una mujer con EII sea, en lo máximo posible, «PROGRAMADO», teniendo lugar en un momento idóneo con la enfermedad inactiva.
Con la paciente en remisión, una vez que la pareja decide tener hijos, es imprescindible retirar aquellos fármacos con potencial teratógeno.

Se retirarán 6 meses antes los siguientes fármacos:
– *Metotrexato:* según ficha técnica:
  • Causa embriotoxicidad, abortos y anomalías fetales en los seres humanos.
  • Está contraindicado durante el embarazo. Se requiere emplear métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento y, al menos, durante 6 meses después de la finalización del tratamiento.
  • Se aconseja que los hombres interrumpan el tratamiento al menos 3 meses antes de intentar la concepción, si bien estudios realizados no confirman un aumento del riesgo de los efectos adversos en el embarazo tras una terapia a dosis bajas con metotrexato en el padre.
– *Talidomida:* según la ficha técnica tiene las siguientes *contraindicaciones.*
  • Hipersensibilidad a talidomida o a alguno de los excipientes.
  • Mujeres embarazadas.
  • Mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene.
  • Pacientes que no puedan seguir o cumplir las medidas anticonceptivas necesarias.
– *Metronidazol y ciprofloxacino:* con menor riesgo.

Todas las modificaciones del tratamiento de la EII que se aconsejen durante este periodo previo a la concepción deben ser muy meditadas y sus porqués deben ser explicados a la paciente de forma comprensible, ya que muchas de ellas no quieren tomar ningún medicamento en esos momentos.
También recomendamos siempre suplementos de ácido fólico en este periodo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DURANTE EL EMBARAZO

Influencia de la EII sobre el embarazo y el feto: ¿tendré un bebé sano y normal?

En general, podemos considerar que *si la mujer se encuentra en remisión de su enfermedad en el momento de la concepción, es más probable que la gestación transcurra sin complicaciones.*
Si la enfermedad se encuentra en fase de actividad en el momento de la concepción, se ha comprobado que existe:
– Un aumento del riesgo de abortos espontáneos (tasas de hasta el 35 %, especialmente en la EC).
– Nacimientos prematuros: el parto pretérmino (< semana 37). No hay diferencias entre pacientes con CU y EC.
– Recién nacidos de bajo peso y talla baja para la edad gestacional.
– Malformaciones congénitas.

Con respecto al riesgo de *anomalías congénitas,* los resultados son discrepantes: mientras que tanto en el metanálisis publicado en 2007 por Cornish y cols., como en estudios posteriores, sí se halló un aumento significativo de anomalías congénitas en pacientes con CU (en la EC el riesgo no alcanzó significación estadística en otros estudios), el riesgo no ha sido demostrado o se ha observado un aumento del mismo relativo para ciertas anomalías

(malformaciones de miembros, malformaciones obstructivas urinarias y anomalías congénitas múltiples), pero no del riesgo global.
Es importante advertir a la paciente que debe quedarse embarazada en un momento de inactividad de la enfermedad, así como recordar la importancia de tratar rápida y adecuadamente los brotes que puedan surgir durante la gestación. La actividad de la EII influye más negativamente sobre el desarrollo del feto que el empleo de la mayor parte de los tratamientos médicos empleados para su control.

Influencia del embarazo sobre la EII: ¿puede recidivar o empeorar mi enfermedad durante el embarazo?

La evolución de la EII durante la gestación parece similar a la que presentaría la paciente si no estuviera embarazada. En general, alrededor de una tercera parte de las pacientes sufren una exacerbación durante el embarazo.
Si la enfermedad está en remisión en el momento de la concepción, es más probable que se mantenga así durante todo el embarazo.
Por el contrario, si la *concepción tiene lugar durante un brote,* su control puede ser difícil y la enfermedad puede mantenerse activa durante toda la gestación o incluso puede empeorar, sobre todo en el primer trimestre.
Habitualmente se recomienda un periodo de inactividad de, al menos, tres meses antes de intentar la concepción.
También es importante resaltar que la evolución de la enfermedad durante una gestación no predice el curso en embarazos posteriores.
El curso de la enfermedad en el posparto no se diferencia de otros periodos, y el embarazo no parece suponer un cambio importante en el curso posterior de la EII.

Pruebas diagnósticas durante el embarazo

Ecografía y resonancia magnética

La ecografía y la resonancia magnética son inocuas y pueden realizarse en cualquier momento de la gestación.
La resonancia magnética es la técnica de imagen de elección en los tres trimestres.
No obstante, el medio de contraste utilizado en estos casos, el gadolinio, ha resultado ser teratógeno en estudios en animales, por lo tanto debería evitarse durante el primer trimestre.

Rectosigmoidoscopia y colonoscopia completa

La rectosigmoidoscopia es relativamente segura y puede recomendarse si es necesaria.
La colonoscopia completa, aunque probablemente segura, debe evitarse al menos hasta el segundo trimestre de embarazo.
Estas pruebas estarán contraindicadas ante situaciones de placenta previa, rotura de membranas, parto en curso y eclampsia.

Estudios radiológicos con radiaciones ionizantes

Los estudios radiológicos con radiaciones ionizantes (radiografía simple, baritada y tomografía computarizada) están inicialmente contraindicados, salvo si se trata de una situación urgente, de riesgo para la madre y el feto, en la que sea preciso tomar una decisión terapéutica por la sospecha de una complicación, como el megacolon tóxico o la perforación.
El riesgo de irradiación fetal es bajo en general, salvo en el primer trimestre.
El periodo de mayor riesgo es aquel en el que se está desarrollando el sistema nervioso central, entre las 10-17 semanas.

Tratamiento durante el embarazo

El objetivo fundamental del tratamiento de la EII es *mantener la enfermedad en remisión* durante la gestación utilizando los fármacos que han obtenido *mayor seguridad en esta situación.*
La rápida actuación es vital para el control adecuado de los brotes, que es esencial para el buen curso del embarazo.
Debemos saber que la mayoría de los estudios que han evaluado la seguridad de los fármacos durante el embarazo son retrospectivos, y que no existen estudios prospectivos controlados.
Este hecho se debe a que la situación de embarazo se considera, en la mayoría de los estudios, un criterio de exclusión.

La seguridad durante la gestación de los diferentes fármacos

En la Tabla I[2] se muestran la seguridad de los diferentes fármacos más habituales en la EII durante el embarazo, basada en las recomendaciones de la ECCO.

Nutrición

Debemos controlar y cuidar de forma especial el estado nutricional para indicar suplementos de forma precoz cuando sea necesario: calcio, ácido fólico, vitaminas (excepto la vitamina A, que a dosis elevadas es teratógena), hierro y fibra.
Tanto la nutrición enteral como la parenteral total son seguras.
El empleo de probióticos es seguro.

Tratamiento quirúrgico

Durante la gestación, cualquier intervención quirúrgica puede suponer riesgo para el feto y riesgo incrementado de aborto.
La cirugía se planteará en situaciones urgentes secundarias a una complicación:
– Perforación.
– Hemorragia grave.
– Obstrucción.

Tabla I
RESUMEN DE LA ECCO SOBRE EL RIESGO FARMACOLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

FÁRMACO	DURANTE EL EMBARAZO	DURANTE LA LACTANCIA
Mesalazina	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Sulfasalazina	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Corticosteroides	Riesgo bajo	Riesgo bajo; se aconseja esperar 4 h antes de dar el pecho
Tiopurinas	Riesgo bajo; datos limitados de 6-TG	Riesgo bajo
Agentes anti-TNF	Riesgo bajo; considerar su detención alrededor de la semana 24 en los pacientes con remisión sostenida Véase el texto	Riesgo probablemente bajo; datos limitados
Metotrexato	Contraindicado	Contraindicado
Talidomida	Contraindicada	Contraindicada
Metronidazol	Evitar en primer trimestre	Evitar
Ciprofloxacino	Evitar en primer trimestre	Evitar

6-TG: 6-tioguanina.

La decisión es más difícil cuando la indicación quirúrgica se relaciona con la falta de respuesta completa al tratamiento médico. En estos casos tenemos que sopesar el riesgo que supone mantener un cierto grado de actividad de la enfermedad para la madre y para el feto y el riesgo que implica una intervención quirúrgica en las condiciones de un embarazo también para ambos.
La colectomía y la cirugía de intestino delgado son seguras durante el segundo y tercer trimestre, pero habría que intentar ser lo menos invasivo posible. Es importante en estos casos dejar una ileostomía provisional tras la resección, ya que la anastomosis primaria tiene mayor riesgo de complicaciones. Por otra parte, si el feto es suficientemente maduro, debe contemplarse la posibilidad de realizar una cesárea, coincidiendo con la intervención quirúrgica que se plantee[3].

El parto: ¿puedo tener a mi hijo por cesárea o por vía vaginal?

En la mayor parte puede realizarse de forma vaginal.
La decisión de una cesárea debe tomarse de forma individualizada, excepto en:
1. En reservorio íleo-anal, para evitar daño al esfínter anal y problemas de incontinencia.
2. En la EC perianal activa.
3. Presencia de estomas.

¿Existe riesgo de recaída tras el parto?

No existe aumento del riesgo de recaída tras el parto si hay buena adhesión al tratamiento. Existe un 25 % de recaídas postparto, pero es un porcentaje similar a la población que no está embarazada.

El recién nacido: ¿tendrá algún problema mi bebé por los tratamientos que he recibido durante el embarazo?

Existe el temor de que la salud del recién nacido se pueda ver afectada por los fármacos que la madre haya podido recibir durante la gestación, sobre todo en el caso de los fármacos biológicos u otros inmunomoduladores.
Sin embargo, estudios recientes han comunicado que los recién nacidos de madres que han recibido cualquier tratamiento durante el embarazo no muestran, durante el primer año de vida, un aumento del riesgo de complicaciones.
Otro aspecto importante es el cumplimiento del Calendario Vacunal. En niños expuestos al anti-TNF intraútero se debe evitar la administración de vacunas de virus vivos, como la del rotavirus, durante los 6 primeros meses, por el posible riesgo de desencadenar una infección sistémica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Clowse ME, Wolf DC, Förger F, Cush J, Stach C, Kosutic G, Williams S, et al. Presented at 7th Annual meeting of the American College of rheumatology (ACR) and 48th Annual meeting of the Association of Rheumatology Health Proffesionals (ARHP); October 25-30, 2013. San Diego, USA.
2. Van der Woude CJ, Ardizzone S, Bengtson MB, Fiorino G, Fraser G, Katsanos K, et al. The second European Evidenced-Based Consensus on Reproduction and Pregnancy in Inflammatory Bowel Disease. Journal of Crohn´s and Colitis 2015;9(2):107-24.
3. Mahadevan U, Kane S. American gastroenterological association institute technical review on the use of gastrointestinal medications in pregnancy. Gastroenterology 2006;131(1):283-311.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

– Ben-Neriah Z, Ackerman Z. WAGR syndrome in a baby - the result of 6-MP treatment in a father affected by Crohn's disease? Am J Gastroenterol 2001;96(1):251.
– Bortoli A, Saibeni S, Tatarella M, Prada A, Beretta L, Rivolta R, et al. Pregnancy before and after the diagnosis of inflamatory bowel diseases: Retrospective case-control study; J Gastroenterol Hepatol 2007;22(4):542-9.
– Carrera E, López San Román A, Boixeda D. Impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal sobre la función sexual. Gastroenterol Hepatol 2009;32 (supl 2):50-4.
– Comité Asesor de Vacunas. http://vacunasaep.org.
– Cornish J, Tan E, Teare J, Teoh TG, Rai R, Clark SK, et al. A meta-analysis on the influence of inflomatory bowel disease on pregnancy. Gut 2007;56(6):830-7.
– Cornish JA, Tan E, Teare JP, Teoh TG, Rai R, Darzi AW, et al. The effect of restorative proctocolectomy on sexual function, urinary function, fertility, pregnancy and delivery: A systematic review. Dis Colon Rectum 2007;50:1128-38.

- Crohn's and Colitis foundation of América. The intimate relationship of IBD: http://www.ccfa.org/resources/sex-and-ibd.html?referrer=https://www.google.es/
- Crohn's and Colitis foundation of Canada: www.ccfc.ca/contact (entrar en «CCFC publications» y en «The heart of the matter – sexuality and IBD»).
- Chaparro M. What useful developments for my inflammatory bowel disease practice have come from Digestive Disease Week 2014? Gastroenterol Hepatol 2014;37 Suppl 3:22-30.
- Dotan I, Alper A, Rachmilewitz D, Israeli E, Odes S, Chermesh I, et al. editor. Maternal inflammatory bowel disease has shot and long-term effects on the health of their Offspring: A multicenter estudy in Israel. J Crohns Colitis 2013;7(7):542-50.
- Ficha técnica, Gebro Pharma, www.todosobremtx.com.
- Gomollón F, García-López S, Sicilia B, Gisbert JP, Hinojosa J. Guía clínica GETECCU del tratamiento de la colitis ulcerosa elaborada con la metodología GRADE. Gastroenterología y Hepatología 2013;36(8):e1-e47.
- Gomollón F, Rubio S, Charro M, García-López S, Muñoz F, Gisbert JP, et al. Recomendaciones del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre el uso de metotrexato en la enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterología y Hepatología 2015;38(1):24-30.
- Kane S. Inflammatory bowel disease in pregnancy .Gastroenterology Clin North Am 2003;122(1):323-40.
- Mahadevan U, Kane S. American gastroenterological association institute medical position statement on the use of gastrointestinal medications in pregnancy. Gastroenterology 2006;131(1):278-82.
- Mahadevan U, Sandborn WJ, Li DK, Hakimian S, Kane S, Corley DA. Pregnancy outcomes in women with inflammatory bowel disease: A large community-based estudy from Northen California. Gastroenterology 2007;133(4):1106-12.
- Marri SR, Ahn C, Buchman AL. Voluntary childlessness is increased in women with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2007;13(5):591-9.
- Mateu PN. Actualización en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Gastroenterología y Hepatología 2008;31 (Supplement 4):51-6.
- Molnár T, Farkas K, Nagy F, Lakatos PL, Miheller P, Nyári T, et al. Pregnancy outcome in patients with inflammatory bowel disease according to the activity of the disease and the medical treatment: a case-control study. Scand J Gastroenterol 2010;45(11):1302-6.
- Mortier PE, Gambiez L, Karoui M, Cortot A, Paris JC, Quandalle P, et al. Colectomy with ileorectal anastomosis preserves female fertility in ulcerative colitis. Gastroenterol Clin Biol 2006;30(4):594-7.
- Mountifield R, Bampton P, Prosser R, Muller K, Andrews JM. Fear and fertility in inflammatory disease: A mismatch of perception and reality affects family plannig decisions. Inflamm Bowel Dis 2009;15(5):720-5.
- Ording Olsen K, JuulS, Berndtsson I, Oresland T, Laurberg S. Ulcerative colitis: Female fecundity before diagnosis, during disease, and after sugery compared with a population sample. Gastroenterology 2002;122(1):15-9.
- Orhlom M, Fonager K, Sorensen HT. Risk of ulcerative colitis and Crohn's disease among offspring of patients with chronic inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1999;94(11):3236-8.
- Orholm M, Binder V, Sorensen TI, Rasmussen LP, Kyvik KO. Concordance of inflammatory bowel disease among Danish twins. Results of a nationwide study; Scand J Gastroenterol 2000;35(10):1075-81.
- Palomba S, Sereni G, Falbo A, Beltrami M, Lombardini S, Boni MC, et al. Inflammatory bowel diseases and human reproduction: A comprehensive evidence-based review. World J Gastroenterol 2014;20(23):7123-36.
- Rajapakse RO, Korelizt BI, Zlatanic J, Baiocco PJ, Gleim GW. Outcome of pregnancies when fathers are treated with 6-mercaptopurine for inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000;95(3):684-8.
- Selinger CP, Eaden J, Selby W, Jones DB, Katelaris P, Chapman G, et al. Inflamatory bowel disease and pregnancy: Lack of knowledge is associated with negative views 2013;7(6):e206-13.
- Silverstein MD, Lashner BA, Hanauer SB, Evans A, Kirsners JB. Cigarrette smoking in Crohn's disease. Am J Gastroenterol 1989;84(1);31-3.
- Tíscar González V, Rodríguez Núñez AM, González Lázaro AI, Arbiol Ledesma MJ. Enfermedad de Crohn y embarazo. A propósito de un caso clínico. Portales médicos 2011. Visto en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2714/1/Enfermedad-de-Crohn-y-embarazo-A-proposito-de-un-caso-clinico-.html

– Travernier N, Fumery M, Peyrin-Biroulet L, et al. Systematic review: Fertility in non-surgically treated inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2013;38:847-85.
– Turnbull GB. Guía de intimidad, sexualidad y una ostomía. United Ostomy Associations of America. www.ostomy.org/ostomy_info/pubs/uoa_sexuality_es.pdf
– Wardle RA, Mayberry JF. Patient knowledge in inflammatory bowel disease: The Crohn's and Colitis Knowledge Score. Eur J Gastroenterol Hepatol 2014;26(1):1-5.
– Yarur A, Kane SV. Update on pregnancy and breastfeeding in the era of biologics. Dig Liver Dis 2013;45(10):787-94.

3.4.10. TABACO

Ester Navarro Correal
Enfermera. UACC. Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona

La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica de etiología desconocida que puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal. El desarrollo de la EC parece ser el resultado de una interacción entre una predisposición genética y varios factores ambientales[1]. El consumo de tabaco es el mejor caracterizado de estos factores, aumentando la predisposición e impactando negativamente en la historia natural de la enfermedad[2-8], así como en la calidad de vida de estos pacientes[4]. El efecto del tabaquismo en la evolución de la EC es bien conocido. Se ha demostrado que fumar aumenta la prevalencia de estenosis y fístulas, enfermedad perianal, cirugías y recurrencia postquirúrgica en pacientes con EC. También incrementa la necesidad de esteroides y tratamiento inmunosupresor[1,2,4,9-11]. También se ha encontrado que el fumar disminuye la eficacia del tratamiento biológico anti TNF-α. Dejar de fumar está asociado con una reducción en el riesgo de actividad de la enfermedad en un 65 % en comparación con los pacientes que continúan fumando[6]. Parece ser que los pacientes con EC no son más refractarios a dejar el tabaco que la población general[1] e, incluso, se ha demostrado que los pacientes que conocen la influencia que tiene el tabaco sobre el curso de su enfermedad intentarán dejar de fumar con mayor frecuencia que la población general[12]. Sin embargo, la mayoría de las pacientes desconoce el riesgo de los efectos del tabaco sobre la enfermedad inflamatoria, por lo que es importante realizar protocolos de intervención estandarizados de educación sobre el efecto del tabaco para estos pacientes[1,12].

Dejar de fumar mejora inequívocamente el curso de la enfermedad y debe convertirse en uno de los principales objetivos terapéuticos en el tratamiento de la EC. Actualmente, la proporción de pacientes con EC que dejan de fumar sigue manteniéndose baja, cerca del 10 %, y las recaídas son frecuentes[1].

Sin embargo, los estudios realizados sugieren que el tabaquismo constituye un factor protector ante la aparición de la colitis ulcerosa. Parece que los fumadores tienen un riesgo menor de desarrollar colitis ulcerosa y, sobretodo, el abandonar el hábito tabáquico puede estar relacionado con un aumento de la incidencia de la enfermedad. El mecanismo de acción de la nicotina en la colitis ulcerosa no es bien conocido. Parece que la nicotina puede tener un cierto papel como regulador de la respuesta inmune, sobre todo a nivel de los linfocitos T. Además, la nicotina puede disminuir determinadas sustancias del organismo que pueden participar en estimular la inflamación del intestino. Por último, también parece aumentar un corticoide natural producido por el organismo llamado «cortisol», cuya acción es similar a la prednisona. Aun así, deberíamos también recomendar a los pacientes con colitis ulcerosa el cese del tabaquismo debido a que, actualmente, se le considera el principal problema de salud pública prevenible en países desarrollados. El tabaco es la primera causa de muerte prematura y de enfermedad prevenible en nuestro país[13].

OBJETIVOS

Objetivo general: proporcionar las herramientas necesarias, tanto a nivel de conocimiento como de habilidades, para que los profesionales que están en contacto con pacientes con EII conozcan los diferentes niveles de intervención al tabaquismo.

Objetivos específicos:
- Identificar los efectos del tabaco en la EII.
- Conocer las intervenciones 5 A y 5 R.

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Las guías de práctica clínica recomiendan que el médico o enfermera utilice la intervención «5 A»[14-16] en la atención a los pacientes fumadores. El consejo mínimo tabáquico requiere unos 3 minutos aproximadamente por paciente[16]. Deberíamos realizar esta primera intervención en el primer contacto con el paciente o en nuestra primera visita de educación sanitaria. El éxito del tratamiento de deshabituación depende de la motivación que tenga el paciente para dejar de fumar. Indicar un tratamiento en pacientes que no están motivados para dejar de fumar puede ser prematuro e inefectivo, por lo tanto el primer paso será enseñar a los pacientes a identificar el tabaquismo como un problema[1,15]. Para estos casos se recomienda seguir las «5 R»[14-16] motivacionales. Estas intervenciones requieren pocos minutos de la práctica asistencial y tienen una clara ventaja coste-beneficio[5].
Está demostrado que tanto la farmacoterapia como el consejo de deshabituación son eficaces para dejar de fumar, pero la combinación de ambos aumenta notablemente los índices de cesación tabáquica[13]. Las intervenciones conductuales breves de consejo de deshabituación deberían formar parte de la visita a profesionales de la salud y ser reforzadas con material escrito y llamadas telefónicas[12].
No hay contraindicación descrita en los fármacos más habituales para la deshabituación tabáquica.

Breve descripción de las intervenciones para la deshabituación tabáquica

La intervención breve (las «5 A»)

La intervención breve consta de cinco pasos para un abordaje breve y sistemático para dejar de fumar. La duración es de unos 3-5 minutos:
– *Analizar y anotar:* preguntar sobre el consumo de tabaco y registrar la respuesta a la historia clínica.
– *Aconsejar:* aconsejar a todos los pacientes fumadores que dejen de fumar. El consejo debe ser firme y personalizado.
– *Evaluar:* valorar la disposición de los pacientes para dejar de fumar.
– *Ayudar:* apoyar, ayuda psicológica y farmacológica cuando proceda.
– *Acordar el seguimiento:* establecer un seguimiento para continuar con el proceso de dejar de fumar.

La intervención breve motivacional (las «5 R»)

La intervención breve motivacional se conoce con el acrónimo «5 R» y tiene una duración de unos 5-10 minutos. Se trata de un abordaje basado en los principios de la entrevista motivacional y desarrolla la intervención en cinco pasos breves:
– *Relevancia:* ayudar a los pacientes a identificar por qué razones personales puede ser relevante dejar de fumar.
– *Riesgos:* ayudar a identificar qué consecuencias negativas tiene el consumo de tabaco.
– *Recompensas:* ayudar a identificar potenciales beneficios de dejar de fumar.

– *Resistencias:* ayudar a que los pacientes identifiquen cuáles son las barreras para dejar de fumar, que a menudo pueden incluir el miedo a los síntomas de abstinencia, al fracaso, a ganar peso, a afrontar situaciones sociales, etc.
– *Repetición:* repetir la intervención en caso de no avanzar en el estadio del cambio.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN

– En nuestro primer contacto con los pacientes con EII seguiremos el algoritmo de la Figura 1, aunque debemos tener en cuenta que, en el caso de pacientes afectos de colitis ulcerosa, la recomendación será que deben plantearse dejar el tabaco cuando lleven al menos 1 año en remisión, informándoles de la posibilidad de aparición de brote que podemos cuidar.
– En las visitas sucesivas deberíamos preguntar por el hábito tabáquico y realizar la intervención «5 R».

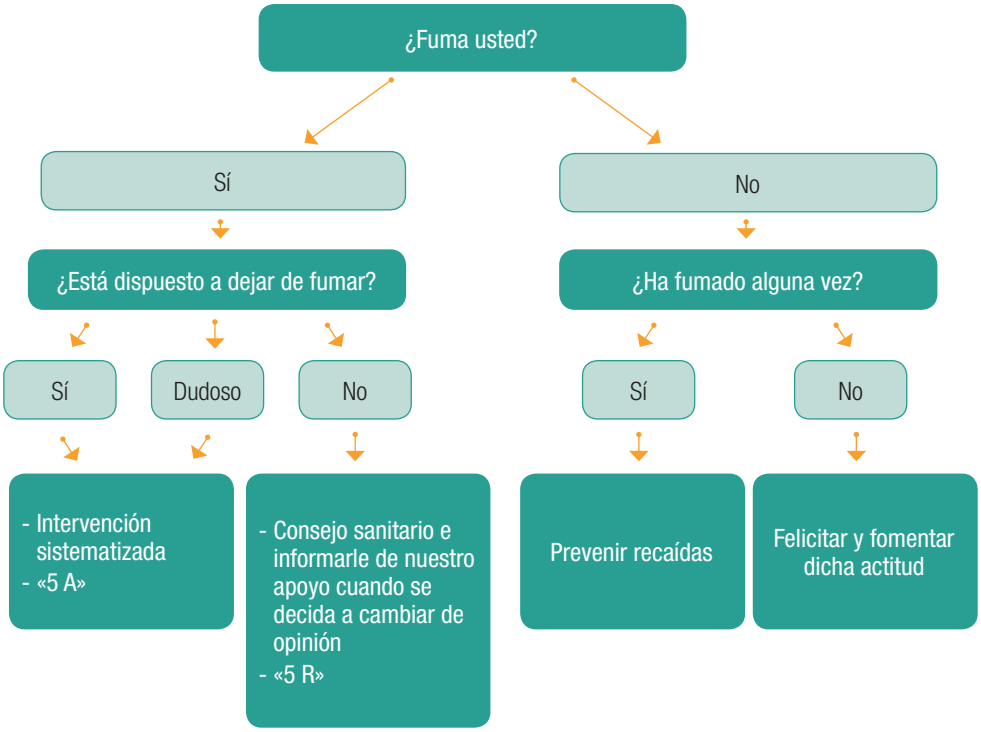


Figura 1. Algoritmo de actuación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cosnes J. Tobacco and IBD: Relevance in the understanding of disease mechanisms and clinical practice. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004;18(3):481-96.
2. Nunes T, Etchevers MJ, Merino O, Gallego S, García-Sánchez V, Marín-Jiménez I, et al. High smoking cessation rate in Crohn's disease patients after physician advice--the TABACROHN Study. J Crohns Colitis 2013;7(3):202-7.
3. Nunes T, Etchevers MJ, Merino O, Gallego S, García-Sánchez V, Marín-Jiménez I, et al. Does smoking influence Crohn's disease in the biologic era? The TABACROHN study. Inflamm Bowel Dis 2013;19(1):23-9.
4. Nos P, Domènech E. Management of Crohn's disease in smokers: Is an alternative approach necessary? World J Gastroenterol 2011;17(31):3567-74.
5. Etchevers MJ, Jiménez IO. Smoking and Crohn's disease: cessation strategies. Gastroenterol Hepatol 2009;32 Suppl 2:37-43.
6. Johnson GJ, Cosnes J, Mansfield JC. Review article: Smoking cessation as primary therapy to modify the course of Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2005;21(8):921-31.
7. Hilsden RJ, Hodgins DC, Timmer A, Sutherland LR. Helping patients with Crohn's disease quit smoking. Am J Gastroenterol 2000;95(2):352-8.
8. Cosnes J, Beaugerie L, Carbonnel F, Gendre JP. Smoking cessation and the course of Crohn's disease: An intervention study. Gastroenterology 2001;120(5):1093-9.
9. Danese S, Fiorino G, Reinisch W. Review article: Causative factors and the clinical management of patients with Crohn's disease who lose response to anti-TNF-α therapy. Aliment Pharmacol Ther 2011;34(1):1-10.
10. Narula N, Fedorak RN. Does smoking reduce infliximab's effectiveness against Crohn's disease? Can J Gastroenterol J Can Gastroenterol 2009;23(2):121-5.
11. Ryan WR, Allan RN, Yamamoto T, Keighley MRB. Crohn's disease patients who quit smoking have a reduced risk of reoperation for recurrence. Am J Surg 2004;187(2):219-25.
12. van der Heide F, Dijkstra A, Albersnagel FA, Kleibeuker JH, Dijkstra G. Active and passive smoking behaviour and cessation plans of patients with Crohn's disease and ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2010;4(2):125-31.
13. Cap00_Prologo - Manual_Tabaquismo_Pfizer_09.pdf [Internet] [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.namfyc.es/cursos/tabaco/Manual_Tabaquismo_Pfizer_09.pdf
14. 142-guia_intervencio_cat.pdf [Internet] [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: http://www.xchsf.cat/docs/142-guia_intervencio_cat.pdf
15. Microsoft Word - GPCtabacTCa.doc - guia_tabac.pdf [Internet] [citado el 24 de abril de 2016]. Recuperado a partir de: https://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/docs/guia_tabac.pdf
16. Panel TU and DG. Treating tobacco use and dependence: 2008 Update. US Department of Health and Human Services; 2008.

3.4.11. ASPECTOS SOCIOLABORALES

Noelia Cano Sanz
Enfermera Colaboradora de la Unidad de EII. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

Como hemos visto a lo largo de los capítulos, la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) son enfermedades inflamatorias intestinales (EII) crónicas que, a menudo, se inician en pacientes jóvenes, afectando a la vida estudiantil y laboral de éstos. La aparición de la sintomatología durante los brotes, así como el impacto sobre las actividades cotidianas y las complicaciones derivadas de la enfermedad y/o de su tratamiento, pueden alterar la vida de nuestros pacientes. Se trata de una patología cuyas manifestaciones clínicas y secuelas pueden ser muy variables. Muchos pacientes realizan vida normal, sin embargo, en determinados casos, la enfermedad puede condicionar grados variables de discapacidad.

Cada vez más, como profesionales sanitarios, le damos más importancia a la repercusión de la EII sobre los aspectos sociolaborales de la vida de los pacientes[1]. La consulta telefónica o vía correo electrónico permiten menor absentismo laboral y estudiantil. Además, son muchos pacientes los que solicitan en la consulta consejos sobre aspectos socio-laborales, así como informes médicos cuando solicitan una invalidez por vía administrativa. Los profesionales implicados dentro de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal no podemos ser ajenos a dicha información y trámites necesarios. De esta forma podremos orientar y asesorar al paciente sobre los recursos que tiene a su disposición.

OBJETIVOS

Objetivo general: identificar y describir los factores relacionados con la EII que impactan sobre los aspectos sociales y laborales/estudiantiles de nuestros pacientes.

Objetivos específicos:

- Conocer los conceptos básicos sobre incapacidad y discapacidad, así como sus diferentes tipos/grados reconocidos por la ley.
- Conocer los trámites administrativos y documentación necesaria para iniciar una solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad.

ASPECTOS SOCIOLABORALES

Son múltiples los factores derivados de la EII los que limitan el desarrollo normal de las actividades cotidianas de la vida. La diferencia entre incapacidad temporal e incapacidad permanente en la EC o la CU es, muchas veces, difícil. Así, el cuadro clínico frecuentemente evoluciona en brotes, lo cual hace que los evaluadores puedan considerar la discapacidad como temporal mientras dura el episodio agudo. Sin embargo, en muchos pacientes persiste la actividad inflamatoria con diferente frecuencia de aparición de los brotes, por lo que la discapacidad debería ser considerada como crónica a la vista del deterioro en el rendimien-

to que sufren. Además, los pacientes con cirugías previas o complicaciones de la enfermedad pueden presentar secuelas físicas y funcionales permanentes. Otros enfermos pueden presentar manifestaciones extraintestinales que, por su evolución crónica y refractariedad, pueden afectar también a su capacidad para llevar una vida social y laboral/estudiantil normal. A todo lo anterior hay que sumar el número de días de trabajo/estudios solicitados para poder acudir a las consultas, pruebas complementarias o administración de tratamientos, en los casos en los que no hayan presentado además ingresos o necesidad de tratamiento quirúrgico. A este efecto, la comprensión ofrecida por parte de los responsables de otorgar los permisos no suele ir pareja con la necesidad real que sufren los pacientes.

La discapacidad y el deterioro de la calidad de vida están claramente relacionados, pero son conceptos totalmente distintos. Discapacidad se define, según la OMS[2], como la pérdida o debilidad de una estructura corporal o la afectación de las funciones de órganos y sistemas que repercuten negativamente en el desarrollo de las tareas propias de la vida diaria y de las profesionales. Es decir, se trata de una disminución de la función. Por el contrario, el concepto de calidad de vida es subjetivo. De este modo, una discapacidad similar puede afectar la calidad de vida de manera totalmente diferente en dos pacientes distintos en función de sus características personales y entorno social.

Por otro lado, el grado de alteración de la capacidad laboral secundaria a una determinada discapacidad no es la misma para todos los pacientes, ya que de ella dependerán circunstancias personales y profesionales. Desde el punto de vista laboral, el tipo de incapacidad estará en estrecha relación con la actividad laboral que ejerza. De esta forma, el reconocimiento del tipo de incapacidad dependerá del grado de limitación que presente para alcanzar un rendimiento normal de las tareas que le sean requeridas:

– Incapacidad temporal (conocida como «baja común»): situación en la que el trabajador está imposibilitado temporalmente para continuar en su trabajo por una causa sobrevenida, cuyo tratamiento exige asistencia sanitaria, con una duración máxima de 12 meses, prorrogables excepcionalmente por 6 meses más cuando se presuma que durante ese plazo el paciente puede ser dado de alta médica por curación (18 como máximo). Durante la situación de incapacidad temporal se debe acudir periódicamente a los diferentes especialistas y solicitar informes médicos a todos y cada uno de ellos, y entregar una copia de los mismos a su médico de Atención Primaria, que será el responsable último de la concesión y renovación de dicha baja[3]. Es conveniente que si se prolonga la incapacidad temporal durante un periodo superior a 6 meses (consecutivos o por suma de periodos de baja sin que entre ellos transcurran 6 meses consecutivos), se busque asesoramiento legal a través de un abogado laboralista o trabajador social para que aconseje sobre los trámites a seguir.
– Incapacidad permanente: si una vez agotado el plazo de 18 meses improrrogables de incapacidad temporal se sigue necesitando asistencia sanitaria al no poder ser concedida el alta médica, y no están definidas las consecuencias incapacitantes de la patología, se iniciará el proceso de tramitación de la incapacidad permanente[4] por un tribunal médico; la situación es revisable en el plazo de 6 meses más. Si después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente[5] el paciente presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral, se tendrán en cuenta, los distintos tipos de incapacidad:
  • Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para su profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

- Incapacidad permanente total para la profesión habitual: inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Se refiere a la situación en la que la discapacidad que presenta el trabajador le impide realizar las tareas fundamentales en su profesión, pero le permite desarrollar una actividad laboral distinta y compatible con la discapacidad que presenta. Se retribuye con un 55 % de la base reguladora. Con este grado de invalidez, el trabajador puede realizar otra actividad laboral, generalmente con menores requerimientos físicos, que sea compatible con la discapacidad que presenta. Si el trabajador no encuentra otro trabajo al cumplir los 55 años, vería aumentada su pensión en un 20 %, al entender el gobierno que, en esta franja de edad, es más difícil que lo contraten[6]. La concesión de este tipo de invalidez implica la gratuidad de los medicamentos a través de receta médica, de igual manera que en los grados superiores de invalidez.
- Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: es la que inhabilita al trabajador para cualquier profesión u oficio. Se retribuye con el 100 % de la base reguladora, cantidad que, además, no se tiene que tener en cuenta para el Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF). Es incompatible con cualquier actividad laboral.
- Gran invalidez: aquella situación de un trabajador afectado de incapacidad permanente que, a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de la vida.

Desde el punto de vista retributivo, puede acceder al cobro de una pensión contributiva el trabajador que lleve más de 180 días de alta en algún régimen de la Seguridad Social, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha que se produzca la baja médica.

La documentación necesaria para la solicitud de prestación económica por incapacidad permanente se presentará ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y consta de:

- Impreso de solicitud de incapacidad.
- Fotocopia del DNI.
- Justificación de la actividad laboral desarrollada por medio de:
  - Certificado de empresa, si se está trabajando.
  - Certificado del Instituto Nacional de Empleo (INEM), si se está en situación de desempleo.
  - Si el enfermo es autónomo, los tres últimos Boletines de Cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  - Si ya se está cobrando (pago directo) del INSS no es necesario dicho certificado.
- Es conveniente, aunque no obligatorio, acompañar también a dicha solicitud de un informe de vida laboral, informe que se emite en la Oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La tramitación de una incapacidad permanente se puede llevar a cabo por 2 vías: el proceso administrativo y, en segundo lugar, a través del proceso judicial en el caso de que la parte demandante (el paciente y su/s representantes) no esté de acuerdo con la decisión o resolución administrativa.

– Fase administrativa: la competencia administrativa para la concesión de una incapacidad permanente depende exclusivamente del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). El proceso se puede tramitar de oficio o por petición de la persona. El proceso se inicia de oficio a instancia de la propia Administración, existiendo varias posibilidades, ya sea en respuesta a una petición de los servicios sanitarios (médico de Atención Primaria) o de los servicios sociales, o bien a propuesta de la inspección o mutua laboral que lo

controle. La gestión y el pago de las incapacidades permanentes es una responsabilidad de la Administración Central a través del INSS. La valoración de las enfermedades y las secuelas que constituyen dichas incapacidades puede corresponder al mismo INSS. Por otro lado, el reconocimiento del grado de discapacidad corresponde habitualmente a las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas.

– Fase judicial: se establece por medio de un juicio oral donde se reunirán las partes: el paciente y su abogado o trabajador social como demandante y como demandados el INSS, la Tesorería de la Seguridad Social y la representación de la empresa en la que realiza su actividad el paciente. En la vista oral se expondrán los informes médicos que constituyen la prueba documental y se aportarán las pruebas periciales. Tras oír a ambas partes, el juez dicta sentencia ejecutiva. La sentencia puede ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, tanto por parte del paciente como por parte del INSS.

De forma paralela pero independiente a la tramitación de la incapacidad laboral, está el reconocimiento del grado de discapacidad, reconocimiento que hay que solicitar de forma autónoma, ya que no por ser reconocida una incapacidad por la Seguridad Social se accede automáticamente al reconocimiento del grado de discapacidad. Por discapacidad entendemos discordancia entre el rendimiento, el estatus bio-psico-físico del individuo y sus propias expectativas o del grupo concreto al que pertenece. La discapacidad representa, pues, la socialización de una deficiencia y, por lo tanto, refleja consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales que para el individuo se derivan de la presencia de su discapacidad. La discapacidad puede ser reconocida en diferentes grados, expresados como porcentaje respecto a una capacidad teórica plena del 100 %, en el denominado certificado de discapacidad, que será otorgado previa evaluación por un tribunal médico solicitada por el paciente en los centros base pertenecientes a la Consejería de Servicios Sociales. El reconocimiento del grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de la solicitud. La condición legal de persona con discapacidad se alcanza con el 33 % o más de un cómputo global de una valoración de la limitación de actividad física, psíquica o sensorial en la persona.

El Real Decreto 1971, del 23 de diciembre de 1999, y la posterior modificación recogida en el Real Decreto 1856/2009, recogen el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

La documentación necesaria para solicitar la valoración del grado de discapacidad es la siguiente:

– Impreso de solicitud del reconocimiento de la condición de persona con discapacidad, debidamente cumplimentado.
– DNI del interesado o, en su defecto, fotocopia del Libro de Familia. En su caso, DNI del representante legal y documento acreditativo de la representación legal.
– Todos los informes médicos y psicológicos que posea y donde consten las secuelas tras la aplicación de medidas terapéuticas. En caso de revisión por agravamiento, informes que acrediten dicho agravamiento.

En aquellos casos en los que el paciente no esté de acuerdo con la resolución, podrá interponer una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, BOE 11/4/95) en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la misma, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Servicios Sociales.

Se puede solicitar una revisión por agravamiento transcurridos 2 años desde la fecha del reconocimiento.

El reconocimiento de la discapacidad puede llevar parejo cierto grado de retribución en forma de pensión no contributiva, la cual podrá ser solicitada por quien tenga reconocido un grado de discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65 % y que no dispongan de rentas o ingresos suficientes.

Una parte importante en la tramitación de la incapacidad laboral y del grado de discapacidad es la redacción del informe médico de la situación clínica del paciente. Dicho informe debe ser lo más detallado posible, dejando claro las características de los síntomas del paciente y si éstos son permanentes o difícilmente reversibles y cuáles pueden llegar a revertir con tratamiento. Existen parámetros que apoyan el hecho de que la discapacidad del paciente con EII es permanente y que a éste y cualquier otro efecto deben detallarse en un informe médico de alta[7]. Entre éstas destacan el número de intervenciones quirúrgicas resectivas, la presencia de una ostomía o un reservorio íleo-anal, la comorbilidad grave o la psicopatología[8]. Además, es importante detallar cómo interfieren los síntomas del paciente con su actividad diaria o en el descanso nocturno. Son especialmente importantes la presencia de dolor abdominal o diarrea. Se recomienda especificar el número de deposiciones, así como la presencia de urgencia defecatoria y, sobre todo, la incontinencia fecal, tan limitante para los pacientes. Otros parámetros a detallar, que ayudan a determinar la gravedad del paciente, son los días de baja laboral/año, el número de días de hospitalización por año, absentismo escolar o la dependencia de los profesionales/cuidadores. Es evidente que un paciente que tiene que acudir al hospital varias veces al mes para controles, tratamientos o por complicaciones de la enfermedad, tendrá grandes dificultades para llevar una vida social y laboral normal.

TABLAS RESUMEN

A continuación, las siguientes tablas resumen algunos de los beneficios que los pacientes con discapacidad reconocida pueden solicitar. Es importante tener en cuenta que estos beneficios, tanto económicos y sociales, pueden variar en función de cada comunidad autónoma.

Tabla I
BENEFICIOS ECONÓMICOS

GRADO DISCAPACIDAD	CONCEPTOS CONTEMPLADOS	ADMINISTRACIÓN TRAMITADORA
65 % o más	Prestación económica por invalidez (incrementada al 50 % si el grado de discapacidad es del 75 % o más)	Gerencias territoriales de servicios sociales
33 y 65 %	Prestación económica por familiar a cargo (incrementada al 50 % si el grado de discapacidad es del 75 % o más)	INSS

Tabla II
BENEFICIOS FISCALES

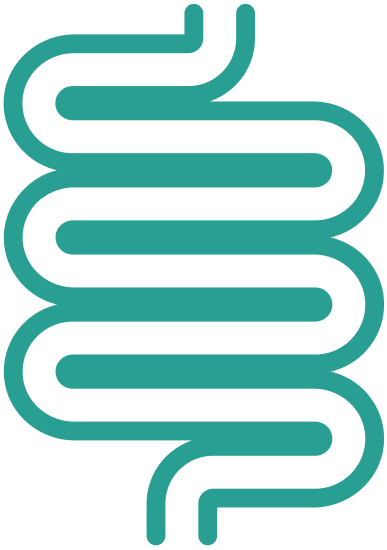
GRADO DISCAPACIDAD	CONCEPTOS CONTEMPLADOS	ADMINISTRACIÓN TRAMITADORA
33 % o más	**IRPF.** Reducción para personas trabajadoras con discapacidad (mínimo de 3.000 €). Deducciones por ascendientes o descendientes (1.200 €)	Agencia Estatal de la Administración Tributaria
	Impuesto sobre sociedades. Deducción de 6.000 € paciente/año de incremento del promedio de la plantilla	
	Impuesto sucesiones/donaciones, transmisiones patrimoniales o impuestos de actos jurídicos documentados	
	IVA. Aplicación de tipos reducidos o superreducidos a personas con movilidad reducida	
	Impuestos y tasas municipales Bonificación IBI Tasa basuras, agua y alcantarillado Reducciones y exenciones en las tasas de licencias de obra que favorezcan accesibilidad Exención en el IVTM	Ayuntamiento

Tabla III
BENEFICIOS SOCIALES

GRADO DISCAPACIDAD	CONCEPTOS CONTEMPLADOS	ADMINISTRACIÓN TRAMITADORA
33 % o más	**Vivienda** Reserva para alquiler y adquisición viviendas protección oficial Ayudas económicas para eliminación de barreras	Servicios Territoriales de Fomento y Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
	Educación Puntuación para acceso a colegios públicos, concertados o escuelas infantiles Becas para Educación Especial Ayuda comedor, libros de texto, transporte, excedencia tasas universitarias, etc.	Direcciones Provinciales de Educación y Secretariados de Asuntos Sociales de las Universidades
	Empleo Ayudas autoempleo, reserva 2 % en empresas con más de 50 trabajadores, reserva cupo oposiciones y empleo público, derecho del familiar a jornada reducida, etc.	Oficinas Territoriales de Empleo
	Vehículo Reducción o exención impuesto matriculación, tarjeta de aparcamiento, reducción del IVA para adquisición o reparación, etc.	Agencia Estatal de la Administración Tributaria
	Beneficios para las empresas por contratación de discapacitados	Tesorería General de la Seguridad Social
	Otros: tarjeta dorada Renfe, exención tasas licencias de caza y pesca, etc.	
65 %	Abono social de telefónica	

BIBLIOGRAFÍA

1. Motos J, Calvet X. Cobertura sociolaboral en enfermedades crónicas: invalidez permanente y minusvalía. Med Clin (Barc) 2007;128:780-5.
2. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Organización Mundial de la Salud. http://www3.who.int/icf/ icftemplate.cfm
3. Tit. Cap. IV del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4. Artículo 128 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
5. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994. Ley General de la Seguridad Social. Disponible en: http://www.segsocial.es/inicio/ ?MIal=c w_usr _view_Folder&LANG =1&ID=2105.
6. Resolución de 22 de mayo de 1986, de la secretaría general para la Seguridad Social, sobre reconocimiento de incremento del 20 por ciento de la base reguladora a los pensionistas de incapacidad permanente total cuando cumplen la edad de cincuenta y cinco años.
7. Artículo 37 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente.
8. Calvet X, Motos J, Montserrat A, Gallardo O, Vergara M. Analysis of court criteria for awarding disability benefits to patients with Crohn's disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1322-7.



3.5

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

3.5.1. ATENCIÓN TELEMÁTICA

Luciano San Román Álvarez
Enfermero de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Área de Gestión Integrada Vigo
Hospital Universitario Álvaro Cunquéiro. Vigo

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una patología crónica de etiología no esclarecida, con unas tasas de incidencia en aumento en las últimas décadas[1-3]. En el estudio epidemiológico Europeo Epicom, en el cual la representación nacional a efectos de incidencia fue el área sanitaria de Vigo, la incidencia de EII en el año 2010 fue de 18,3 casos por 100.000 habitantes, siendo para la enfermedad de Crohn (EC) 10,3 casos por 100.000 habitantes, para la colitis ulcerosa (CU) 8,7 casos por 100.000 habitantes y para la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada 1,2 casos por 100.000 habitantes[4].

Esta patología repercute directamente sobre el sistema sanitario, con un aumento del gasto sanitario (tratamientos, hospitalizaciones, etc.), así como también sobre el paciente de manera directa e indirectamente (bajas laborales, desplazamientos, pérdidas de horas de trabajo, etc.)[5-7].

La impredecibilidad del curso de la enfermedad condiciona que los pacientes sufran brotes recurrentes e inesperados, por lo que esta patología debe ser manejada mediante visitas programadas y mediante atenciones a demanda.

Durante los últimos años, el manejo de esta patología ha sufrido un cambio considerable con la creación de las unidades de atención integral[8,9]. Dichas unidades están formadas por distintos profesionales involucrados en el seguimiento y manejo del paciente (gastroenterólogos, cirujanos, enfermeras, estomatoterapeutas, radiólogos, reumatólogos, oftalmólogos, etc.). Estas unidades se fundamentan en el abordaje del paciente desde un punto de vista integral, situando al paciente en el eje central del sistema, confiriéndole autonomía en la toma de decisiones sobre su enfermedad. De esta manera se consigue una mayor participación por parte del paciente en su proceso, con una expectativa de aumento de la adherencia al tratamiento y una reducción de los gastos.

Una de las partes que más valoran los pacientes de la unidad de atención integral es la disponibilidad de atención telemática a demanda, tanto por vía telefónica como por correo electrónico. Se trata de un recurso que permite un acceso rápido y de calidad, a la vez que reduce el consumo de recursos. En general, la vía telemática consta de un profesional, generalmente personal de enfermería, la cual ejerce el primer filtro de llamada, procediendo bien a la resolución del problema, o bien derivando la demanda a otro profesional para su posterior resolución.

Estudios recientes han reflejado la importancia de la figura de la enfermería en estas unidades, así como el importante ahorro de recursos sanitarios con la puesta en marcha de la atención telemática[10]. En el presente apartado se tratan aspectos sobre la correcta valoración telemática en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal.

Cabe reseñar que la consulta telemática tiene dos vertientes: una tradicional, como es la atención telefónica y el uso del correo electrónico, y otra más reciente e innovadora, como es el uso de aplicaciones móviles utilizadas por los llamados teléfonos móviles inteligentes *«smartphones»*, que permiten el acceso al conocimiento, una mayor facilidad de contacto e, incluso, automanejo de la propia enfermedad. Es posible que esta herramienta, en un futuro, se convierta en el vínculo más rápido y de fácil acceso a la unidad de atención integral.

En este apartado nos vamos a centrar en la vía telemática tradicional, dejando las nuevas tecnologías para otros capítulos de este manual.

Respecto a la vía telemática tradicional abordaremos aquellos conceptos sobre la enfermedad, la valoración y el correcto flujograma de manejo de dicha vía para que, según las características y posibilidades de cada unidad, se pueda implementar o perfeccionar según sea el caso.

OBJETIVOS

Objetivo general: adquirir habilidades y conocimientos para la gestión de las demandas telemáticas realizadas a la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal.

Objetivos específicos:

- Identificar los requerimientos físicos y humanos necesarios para la implementación de una consulta telemática en enfermedad inflamatoria intestinal.
- Identificar los diferentes tipos de demandas telemáticas para su gestión y manejo.
- Conocer y protocolizar la recogida de aquellos datos relevantes para la gestión de la demanda telemática.
- Identificar y dar solución mediante un itinerario adecuado, ajustado al tipo de demanda realizada.

REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y HUMANOS DE LA UNIDAD

La dotación física para implementar una consulta telemática debe cumplir unos mínimos estándares, entre los que se debe incluir:

1. Despacho que cumpla los criterios de ergonomía según la normativa actual (ruido, luminosidad, temperatura), preferiblemente de uso individual.
2. Telefóno móvil/fijo, siendo de utilidad disponer, además, de un contestador automático de llamadas.
3. Ordenador con conexión a internet.
4. Acceso a historia clínica digitalizada. La historia clínica digital, debidamente cumplimentada, es una herramienta prioritaria para poder resolver, con la mayor brevedad posible, una demanda telemática, ya que disponemos del acceso inmediato a todos los datos del paciente, tanto de aquellos relacionados con su EII como los de otras especialidades, incluso información de atención primaria.
5. Acceso a bases de datos de pacientes de la unidad. En algunos casos, no habiendo disponibilidad de acceso a la historia digital, una base de datos nos puede proporcionar una información rápida y valiosa, incluso en caso de poseer historia clínica digitalizada. La base de datos permite realizar un búsqueda avanzada de información mediante los distintos filtros que ahonda en una mayor rapidez, facilitando el trabajo.
6. Agenda de registro de actividad telemática. Cada una de las atenciones debe ser registrada y dotada de una imputación de tiempo sobre la agenda de trabajo diario, puesto que consume al menos el mismo, si no más tiempo, que una atención programada. El correcto registro de la actividad es la única manera de dar visibilidad al trabajo que se realiza.

En cuanto a la dotación humana para realizar una consulta telemática, ésta debe incluir a un profesional con conocimientos de la patología, con habilidades y motivación para la puesta en marcha y desempeño de dicho trabajo. En muchas ocasiones no está tipificado el profesional encargado de ello, y acaba siendo el facultativo que, a mayores de su actividad asistencial programada, realiza esta labor, pero lo más adecuado es que no sea así (debido a la gran carga de trabajo que generan estas atenciones), sino que el profesional que más se ajusta al desempeño de esta actividad debe ser el personal de enfermería de la unidad.

TIPOS DE DEMANDAS TELEMÁTICAS

Las demandas se pueden clasificar según:

1. Profesional que realiza la demanda:
   - Paciente.
   - Familiar.
   - Personal sanitario:
     - De la unidad.
     - Otros profesionales.
2. Recurso utilizado para la demanda:
   - Vía telefónica.
   - Vía correo electrónico.
3. Motivos de la demanda:
   - Aparición de nueva clínica o brote de actividad: se refiere a la aparición de nueva sintomatología relacionada con su EII o manifestaciones extraintestinales de la misma.
   - Seguimiento de clínica o brote de actividad: incluye la evolución clínica y, en caso necesario, ajuste o control farmacológico.
   - Monitorización o dudas sobre tratamientos: en este apartado se incluyen las consultas y preguntas relacionadas con los distintos fármacos, así como monitorización analítica de los mismos.
   - Gestiones o citaciones: engloba la gestión y generación de citas en las distintas especialidades, gestión de estudios y pruebas complementarias, interconsultas, obtención de informes y certificados varios.
4. Ségun el profesional que resuelve la demanda.
   - Enfermería.
   - Enfermería y médico.
5. Modo de resolución:
   - Telemática: se resuelve por la misma vía que ha sido realizada la demanda, es decir, telemáticamente.
   - Derivación a la unidad de EII: el paciente necesita ser valorado presencialmente en la unidad de EII mediante cita precoz.
   - Derivación al servicio de urgencias: el paciente es derivado al servicio de urgencias, previa interlocución entre su facultativo y el médico de urgencias.
   - Interconsultas a otras unidades, o derivación a atención primaria.
   - Ingreso programado: tramitación de ingreso hospitalario desde el servicio de admisión del hospital y posterior contacto con el paciente para que en el momento que exista disponibilidad de cama, el paciente haga efectivo su ingreso.

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS TELEMÁTICOS

Para una correcta valoración telemática es fundamental la recogida exhaustiva y rigurosa de ciertos datos del paciente, tanto datos de filiación como datos de su enfermedad. Para facilitar la recogida deberíamos utilizar como herramienta una gráfica o parrilla estandarizada. Un ejemplo de ella es la que se facilita en el Anexo I.
Podemos dividir la recogida en los siguientes apartados:

1. Datos de filiación:
   – Fecha de la demanda.
   – Nombre y apellidos del paciente.
   – Teléfono/correo electrónico de respuesta.
   – Número de historia clínica/código base de datos.
   – Médico responsable de su atención.
2. Datos de la enfermedad:
   – Tipo de enfermedad y clasificación de Montreal de la misma (Anexo II). Este apartado es básico, ya que nos puede dirigir la entrevista en cuanto a la sintomatología del paciente. De todos es sabido que, dependiendo del fenotipo y la extensión de la enfermedad, la anamnesis difiere considerablemente.
3. Tratamientos que toma en la actualidad el paciente. Recoger vía de administración y dosificación.
4. Fecha de inicio de los síntomas.
5. Sintomatología intestinal del paciente:
   – Dolor:
     • Localización: según cuadrante anatómico.
     • Características: por ejemplo tipo cólico, pulsátil, sordo, referido, etc.
     • Modificación: valorar si el dolor se modifica en relación a algo (comida, defecación, etc.).
   – Deposiciones:
     • Número de deposiciones en la actualidad.
     • Consistencia.
     • Presencia de productos patológicos.
       - Sangrado rectal: matizar si es sangre sola, si el sangrado aparece mezclado con las heces o si simplemente aparece al limpiarse con el papel. Es importante precisar qué porcentaje de deposiciones llevan sangre, si más o menos del 50 % de ellas.
       - Moco: presencia o ausencia.
     • Ritmo deposicional normal que tiene el paciente en fase de remisión.
   – Clínica anal: entrevistar, cuando existe sangrado, si hay picor o dolor con las deposiciones, dato que puede orientar a la presencia de patología anorectal (fisura, hemorroide) más que brote activo de EII.
   – Vómitos: valorar la presencia de los mismos. Dato relevante cuando se trata de un paciente con posibilidad de un cuadro suboclusivo.
   – Fiebre: dato relevante cuando entrevistamos a un paciente con una EC fistulizante o un brote grave de EC o CU.
   – Afectación de algún otro familiar: es importante preguntar si existe algún otro miembro de la familia con la misma clínica, ya que en muchas ocasiones, si existen otros miembros de la familia afectos, podremos realizar un diagnóstico diferencial entre un brote de EII y otro cuadro gastrointestinal.

– Otra clínica: preguntar si existe otra clínica que pueda estar relacionada con afecciones extraintestinales de la EII.
  - Dolores articulares y características de los mismos.
  - Presencia de eritema nodoso o pioderma gangrenoso.
  - Afecciones oculares (conjuntivitis/uveítis).
  - Enfermedad perianal (fístulas, abscesos, colgajos).

6. Cumplimentar un índice de actividad: es conveniente poseer un dato objetivo de la actividad de la enfermedad cumplimentando un índice de actividad clínica de la misma. Creo que por la escasa dificultad y rapidez, los índices más adecuados para la gestión telemática son el índice de Harvey-Bradshaw para la EC y el índice de Mayo clínico para la CU (Anexo III).
7. Apartado para otras anotaciones: Se dejará un apartado en la gráfica/parrilla de recogida para reflejar otras notas e incidencias que puedan ser relevantes durante la anamnesis.

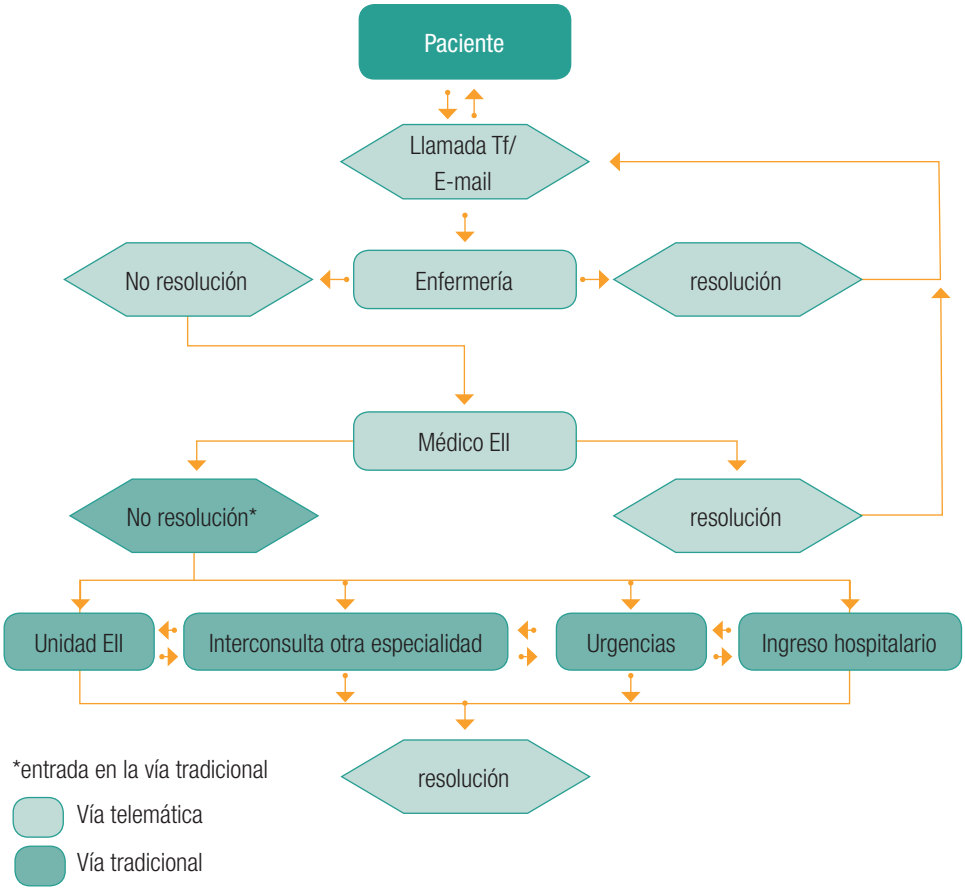


Figura 1. Flujograma de resolución de demandas.

8. Apartado de resolución: en este último apartado, marcar cuál ha sido el itinerario elegido para la resolución de la demanda.
   – Resolución telefónica.
   – Derivación a la consulta de EII.
   – Derivación al servicio de urgencias.
   – Derivación a otras especialidades.
   – Ingreso programado.

ITINERARIOS DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS

La resolución de las demandas por vía telemática tienen una puerta de entrada que sería mediante una llamada telefónica o un correo electrónico, y una puerta de salida que sería o bien la resolución por vía telemática o bien la entrada en la vía de atención tradicional, es decir, una consulta con presencia física. Se encuentra explicado según el flujograma de la Figura 1.

El protocolo de recogida de datos telemáticos va dirigido principalmente a las demandas que se efectúan por aparición o seguimiento de síntomas digestivos en posible relación con la EII. No obstante, la asistencia telemática tiene muchas otras consultas como hemos descrito en los epígrafes anteriores que, debido a una menor complejidad, se resuelven sin necesidad de una recogida tan exhaustiva de información.

BIBLIOGRAFÍA

1. Burish J, Pedersen N, Čuković-Čavka S, Brinar M, Kaimakliotis I, Duricova D, et al. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: The ECCO-EpiCom inception cohort. Gut 2014;63(4):588-97.
2. Saro Gismera C, Sicilia Aladrén B. Inflammatory bowel diseases: A disease(s) of modern times? Is incidence still increasing? World J Gastroenterol 2008;14(36):5491-8.
3. Rodrigo L, Riestra S, Niño P, Cadahía V, Tojo R, Fuentes D, et al. Incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en población general en el área de Oviedo. Rev Esp Enferm Dig 2004;96:296-304.
4. Fernández A, Hernández V, Martínez-Ares D, Sanromán L, de Castro ML, Pineda JR, et al. Incidence and phenotype at diagnosis of inflammatory bowel disease. Results in Spain of the EpiCom study. Gastroenterol Hepatol 2015;38(9):534-40.
5. Casellas F, Panés J, García-Sánchez V, Ginard D, Gomollón F, Hinojosa J, et al. Costes médicos directos de la enfermedad de Crohn en España. PharmacoEconomics - Spanish Research Articles 201;7(1):38-46.
6. Kappelman MD, Rifas-Shiman SL, Porter CQ, Ollendorf DA, Sandler RS, Galanko JA, et al. Direct health care costs of Crohn's disease and ulcerative colitis in US children and adults. Gastroenterology 2008;135(6):1907-13.
7. Van der Valk ME, Mangen MJ, Severs M, Van der Have M, Dijkstra G, Van Bodegraven AA. Evolution of costs of inflammatory bowel disease over two years of follow-up. PLoS One 2016;11(4).
8. Castro-Alvariño J, Martinez-Ares D. Unidades de atención integral en enfermedad inflamatoria crónica intestinal. En: EIGA. Enfermedad de Crohn ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años? Congrega. A Coruña 2010;9-28.
9. Torrejón A, Masachs M, Borruel N, Castells I, Castillejo N, Malagelada JR, et al. Aplicación de un modelo de asistencia continuada en la enfermedad inflamatoria intestinal: la Unidad de Atención Crohn-Colitis. Gastroenterol Hepatol 2009;32:77-82.
10. Sanromán Álvarez L, de Castro Parga ML, Hernández Ramírez V, Pineda Mariño JR, Salgado Alvarez C, Rodríguez Grégori JM. Telematic consultations by nursing staff for patients with inflammatory bowel disease: Evaluation of its capacity for resolving problems and its costs. Enferm Clin 2014;24(2):102-10.

ANEXO I. DATOS DEL PACIENTE

Fecha __ /__ /__

NHC_____Nombre_____Médico_____

Tipo_____Inicio del cuadro (n.º días)_____Teléfono_____

TRATAMIENTO	ORAL	TÓPICO
Mesalazina		
Imurel/6 MP		
Dacortin/Urbasón/Zamene		
Budesonida/Beclometasona		
IFX/Adalimumab		
Otros:		

Clínica:	Sí	No	Días	
Dolor:				Tipo: Localización:
Diarrea:				Número: Ritmo deposicional normal:
Moco:				
Sangrado:				> 50 % depos. < 50 % depos. N.º depos. Con sangre____ Mezclado Limpiar papel
Clínica anal:				Tipo:
Vómitos:				
Fiebre:				Temperatura:

Otra clínica	Sí
Artralgia	
Eritema Nodoso	
Conjuntivitis / Uveítis	
Enfermedad perineal	

ÍNDICE DE MAYO

Variable n.º	Ptos.		Ptos.
N.º deposiciones		Hallazgos endoscopia	
Normal para el pcte.	0	Normal	0
1-2 más de lo normal	1	Enf. leve	1
3-4 más de lo normal	2	Enf. moderada	2
5 o más de lo normal	3	Enf. severa	3
Sangre en heces:		Valoración global:	
No	0	Normal	0
Restos en < 60 % depos.	1	Enf. leve	1
Evidente en la mayoría	2	Enf. moderada	2
Sólo sangre	3	Enf. severa	3
Puntuación: 0-2 nula 3-5 discreta 6-8 moderada 9-12 grave			Total

HARVEY-BRADSHAW

Variable n.º	Ptos.		Ptos.
Estado general:		Masa abdominal:	
Muy bueno	0	No	0
Regular	1	Dudosa	1
Malo	2	Definida	2
Muy malo	3	Definida y dolorosa	3
Malísimo	4		
Dolor abdominal:		Complicaciones:	
No	0	Artralgia	1
Ligero	1	Uveítis	1
Moderado	2	Eritema nodoso	1
Intenso	3	Aftas	1
		Pioderma gangrenoso	1
		Fístula anal	1
		Otras fístulas	1
		Abscesos	1
Puntuación: < 6 leve 6-12 moderada > 12 grave			Total

Notas:

Resolución TF ❑ Consulta EII ❑
Urg ❑ Otros (AP, otras espec.) ❑
Ingreso ❑

ANEXO II. DATOS DE LA ENFERMEDAD

CLASIFICACIÓN DE MONTREAL PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN:	
– Edad al diagnóstico (A):	• A1. 16 años o menos • A2. 17-40 años • A3. Más de 40 años
– Localización (L):	• L1. Íleon terminal • L2. Colon • L3. Ileocólica • L4. Tracto digestivo alto
– Patrón clínico:	• B1. No estenosante, ni fistulizante o inflamatorio • B2. Estenosante • B3. Fistulizante
p: afectación perianal asociada.	
CLASIFICACIÓN DE MONTREAL PARA LA COLITIS ULCEROSA:	
– Extensión (E):	• E1. Proctitis ulcerosa: afección limitada al recto • E2. Colitis izquierda (o colitis distal): afección limitada al colon izquierdo (el límite superior de la inflamación no supera el ángulo esplénico) • E3. Colitis extensa (pancolitis): afección más allá del ángulo esplénico
– Gravedad (S):	• S0. Colitis en remisión • S1. Colitis leve • S2. Colitis moderada • S3. Colitis grave

ANEXO III.

HARVEY-BRADSHAW PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN			
Variable n.º	Ptos.		Ptos.
Estado general:		Masa abdominal:	
Muy bueno	0	No	0
Regular	1	Dudosa	1
Malo	2	Definida	2
Muy malo	3	Definida y dolorosa	3
Malísimo	4		
Dolor abdominal:		Complicaciones:	
No	0	Artralgia	1
Ligero	1	Uveítis	1
Moderado	2	Eritema nodoso	1
Intenso	3	Aftas	1
		Pioderma gangrenoso	1
		Fístula anal	1
		Otras fístulas	1
		Abscesos	1
Puntuación: < 6 leve 6-12 moderada > 12 grave			Total

ÍNDICE DE MAYO PARA LA COLITIS ULCEROSA			
Variable n.º	Ptos.		Ptos.
N.º deposiciones		Hallazgos endoscopia	
Normal para el pcte.	0	Normal	0
1-2 más de lo normal	1	Enf. leve	1
3-4 más de lo normal	2	Enf. moderada	2
5 o más de lo normal	3	Enf. severa	3
Sangre en heces:		Valoración global:	
No	0	Normal	0
Restos en < 60 % depos.	1	Enf. leve	1
Evidente en la mayoría	2	Enf. moderada	2
Sólo sangre	3	Enf. severa	3
Puntuación: 0-2 nula 3-5 discreta 6-8 moderada 9-12 grave			Total

3.5.2. ENFERMERÍA 2.0 Y EII

Laura Marín Sánchez[1] y Antonio Torrejón Herrera[2]
[1]Enfermera Coordinadora de Ensayos Clínicos de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona
[2]Director de Sistemas de Información y TIC (CIO). Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers. Barcelona

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presentan grandes posibilidades a la hora de mejorar la eficiencia del sector sanitario.

El significativo avance de las TIC en los últimos tiempos permite su aplicación al sector salud de numerosas maneras, aportando beneficios de calidad y seguridad, así como un significativo ahorro económico. A la utilización de las TIC en el campo de la Salud la llamaremos «Salud 2.0» o «Salud digital»[1].

En Salud 2.0 encontramos dos protagonistas principales:

a) Los e-pacientes: usuarios que han dejado de ser pasivos para empezar a participar. Los pacientes ya no sólo buscan información acerca de su salud, si no que generan e intercambian contenidos.

b) Los profesionales de la salud, que cada vez más utilizan las TIC para ejercer su profesión, adaptándose al enfoque actual con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

OBJETIVOS

Objetivo general: adquirir nuevas competencias en el manejo de la información y el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos específicos:

- Ayudar a los pacientes a identificar cuáles son los recursos más valiosos para su condición de salud.
- Fomentar el autocuidado a través de una correcta intervención sobre el uso de las TIC por parte de los pacientes.

REDES SOCIALES, COMUNIDADES VIRTUALES Y TECNOLOGÍAS DE ACERCAMIENTO EN SALUD[1]

Son todas aquellas herramientas que potencian la parte social del uso de las tecnologías, acercando personas y permitiendo poner en común espacios virtuales en los que pacientes y profesionales pueden compartir información, ofrecerse apoyo y favorecerse del aprendizaje social que se produce en ellos. Permiten transmitir información, conectar personas y generar auténticas comunidades virtuales de salud.
La utilización de las nuevas tecnologías en salud aportan, por lo tanto, un gran número de beneficios a sus usuarios, tanto a profesionales como a pacientes, pero debemos saber utilizarlas.

RECOMENDACIONES PARA LA ENFERMERÍA

Las redes sociales aplicadas a la *Salud 2.0* permiten a los profesionales sanitarios, o más concretamente a la enfermería, transmitir su experiencia a un gran número de personas, conocer mejor las necesidades de sus pacientes, actualizar sus conocimientos y acceder fácilmente a otros. Sin embargo, a menudo surgen dudas sobre los límites entre lo que se puede comunicar y lo que no. No se debe olvidar que, como profesionales, se tiene la misma responsabilidad independientemente del medio que se utilice para comunicarse. Ya en el 2011 la Asociación Americana de Medicina[2] (AMA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Americana de Enfermería[3] (ANA, por sus siglas en inglés) marcaron unas directrices de cómo debía ser la «profesionalidad» en los medios sociales:

- Ética: los profesionales sanitarios, independientemente del contexto donde actúen, siempre deben hacerlo respetando los códigos deontológicos y la ética profesional. Asimismo deben actuar en el uso de las redes sociales.
- Privacidad: la confidencialidad debe mantenerse en todo momento. Debe preservarse cualquier tipo de información que pudiera facilitar la identificación del paciente.
- Seguridad: pese a que es necesario mantener la confidencialidad, se debe tener en cuenta que la privacidad en estos medios no es absoluta y que, una vez en internet, el contenido puede ser vulnerable. Se debe revisar periódicamente la configuración de seguridad y mantener actualizadas las contraseñas.
- Contenido apropiado: las opiniones nunca deben ser injuriosas, descalificativas o gratuitas. Se deben notificar los contenidos poco apropiados y comunicarse con los autores de la publicación para que puedan modificar el contenido e, incluso, eliminarlo.
- Diferenciar lo profesional de lo personal: los pacientes no son amigos en las redes sociales. El terreno personal debe separarse del profesional, incluso si es necesario utilizar dos perfiles distintos, aunque siempre siendo cuidadoso con los contenidos publicados en ambos.
- Representantes de un colectivo: cada profesional, con sus intervenciones en la red, representa al colectivo de profesionales al que pertenece, por lo que no sólo puede repercutir en su reputación individual si no en la reputación de todo el colectivo.

RECOMENDACIONES PARA LOS e-PACIENTES

Durante estos últimos años la sociedad está cambiando. Los ciudadanos desean tener un mayor poder de participación social y les gustaría ser responsables en la toma de decisiones que afectan tanto a su vida como a su salud.

Como pacientes empiezan a ser una parte activa. Se comunican y establecen relaciones con otros pacientes, profesionales e instituciones a través de internet. Intentan resolver problemas, entender sus síntomas. En definitiva, intentan crear sus propios «entornos personales de salud». Fruto de todo esto nace lo que se denomina e-paciente.

El término e-paciente fue acuñado por Tom Ferguson para describir a aquellas personas que estaban preparadas, capacitadas, empoderadas y comprometidas con su salud y la toma de decisiones.

La aparición de este tipo de pacientes pone de relieve el hecho de que muchos profesionales no se consideran preparados para trabajar con ellos, quizás porque se sienten amenazados ante el hecho de que un paciente pueda saber más sobre diversos aspectos de su

enfermedad que el propio profesional, o también porque sienta que el paciente le exige una nueva forma de tratar con él.
Como profesionales no deben tener miedo a estos pacientes, ya que internet y la web social no van a suponer una sustitución del profesional sanitario, sino una facilitación y un aporte de recursos complementarios que permitan mejorar la salud y los niveles de autocuidado de los pacientes. Simplemente se necesitan nuevos modelos de relación para los que los profesionales deben desarrollar nuevos roles y competencias relacionados con el uso de estas herramientas.
Se debe ayudar a los pacientes a identificar cuáles son los recursos más valiosos para su condición de salud, qué información es útil y cuál no, convirtiéndose en guías dentro de este gran mundo de conocimiento que es actualmente internet.

Pacientes y redes sociales

No existe una forma consensuada de cómo deben usarse las redes sociales en el ámbito de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Se sabe que son múltiples los beneficios de las redes sociales en el ámbito de la salud, pero no todo es positivo. El principal problema es que nadie puede controlar lo que se dice en ellas, provocando que corran múltiples informaciones inexactas o directamente erróneas, algo que es especialmente grave cuando se trata de información sanitaria.
Es por ello que se debe aconsejar a los pacientes que sean especialmente críticos y cautelosos con la información que obtengan a través de las redes sociales.

Cómo reconocer si una web es fiable y de calidad en el ámbito de la salud[4,5]

Hay que tener en cuenta que, al buscar en google, éste no discrimina si una web es «buena» o «mala», sino que simplemente las ordena por el número de visitas recibidas, y eso no es sinónimo de calidad.
- La página web debe mostrar de forma clara cuál es su finalidad y objetivos y a qué público se dirige.
- Una web fiable nunca debe ser anónima. Los autores y/o responsables de una página web deben identificarse de forma clara. Debe aparecer un correo electrónico de contacto en un lugar visible.
- La información debe estar actualizada. Debemos comprobar que la página principal tiene fecha de actualización y que la información que ofrece se actualiza periódicamente.
- A veces las apariencias engañan, no se debe confiar en la información que ofrece la web sólo porque esté bien redactada, por el uso de un lenguaje técnico o por su imagen.
- La información sobre la salud siempre debe diferenciarse de cualquier contenido publicitario. No hay que confiar en las recetas milagrosas, simplemente no existen.
- La página debe aportar credibilidad. Una buena forma de hacerlo es a través de las referencias bibliográficas, mostrando autores o fuentes reconocidas.
- Siempre son de más confianza las páginas web que tiene algún certificado de instituciones de calidad o están avaladas por alguna.
- Siempre que se consulte una página web se debe contrastar la información con un profesional antes de tomar cualquier decisión sobre su salud.

– En caso de que la página solicite datos personales a sus usuarios, debe existir un formulario que explique de forma clara el uso que se hará con dichos datos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Campaña F, Marín L, Torreón A. Herramientas 2.0 en enfermedad inflamatoria intestinal; 2016.
2. American Medical Association. Professionalism in the Use of Social Media [Internet]. AMA's Code of Medical Ethics. 2011 [citado 1-agosto-2015]. Disponible en: htt p://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion9124.page
3. American Nurses Association. Navigating the world of social media. 2011;13:20910. Disponible en: htt p://www.nursingworld.org/Functi onalMenuCategories/AboutANA/Social-Media/Social-Networking-Principles-Toolkit/Fact-Sheet-Navigati ng-the-World-of-Social-Media.pdf
4. Calidad web en salud. Principios básicos para reconocer páginas web fiables sobre salud. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. [Blog; actualizado el 07 de enero de 2013]. Disponible en http://www.calidadwebsalud.com/principios-basicos-para-reconocer-paginas-web-fiables-sobre-salud/ .
5. Web Médica Acreditada. http://wma.comb.es/es/wma/autoavaluacio.php



4

ACTIVIDAD DOCENTE

Ester Navarro Correal

Enfermera. UACC. Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona

Cuando hablamos de profesionales de enfermería que trabajan en unidades para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) estamos haciendo referencia a la figura de enfermería de práctica avanzada (EPA), definiendo ésta como cualquier nuevo desarrollo aplicado por enfermeras que permita ensanchar los dominios profesionales de la enfermería y ayude a mejorar su visibilidad, prestigio o autonomía laboral; aunque afecta a una minoría de enfermeras, su impacto positivo crece exponencialmente[1].

Sin embargo, la figura de la EPA aún no es una realidad en nuestro país y deberíamos trabajar fuerte para que así sea. Relacionado con las necesidades formativas, se deberían definir programas formativos *ad hoc* en las universidades, y esto sólo se podría conseguir con el trabajo conjunto entre el sistema nacional de salud y la universidad.

Según el consenso de la N-ECCO (Nurse-European Crohn and Colitis Organisation), este nivel de asistencia es «evidente que va más allá del primer nivel de titulación», y normalmente se alcanzaría tras una combinación de una práctica clínica amplia, desarrollo profesional y estudios formales.

Actualmente no hay consenso sobre el nivel de formación que deben alcanzar estos profesionales de enfermería. Los requisitos varían de un país a otro y de una organización a otra, y pueden venir dados por normas de calidad profesionales y requisitos de regulación de ámbito nacional. Se piensa que el personal de enfermería que realiza una práctica avanzada (por ejemplo, el que evalúa, diagnostica) debe tener una formación de nivel máster[2,3].

A día de hoy en España, sólo existen iniciativas desde el sector privado para promover la docencia del personal de enfermería dedicado al cuidado de pacientes con EII. Algunos ejemplos de ello son:

– Programa de estancias en unidades de referencia a nivel español con un total de 64 estancias realizadas entre los años 2012-2016.
– Curso online «FEII» acreditado con 1.876 inscripciones.
– Proyecto Enlazados: talleres de formación que se realiza en el territorio con el objetivo de tejer una red consolidada para la promoción de la formación y la investigación en enfermería inflamatoria intestinal.

Todas las iniciativas han tenido una muy buena acogida, pero está claro que uno de los retos del futuro es conseguir que la formación y la docencia se formalicen a través de los canales institucionales.

Entra claramente dentro de nuestra competencias la docencia y, sin lugar a dudas, la formación continuada. Una demostración clara de que esto es así la encontramos en el desarrollo del instrumento de evaluación de los cuidados de enfermería (IEC-EII), donde uno de los estándares de calidad valora la formación y la participación en proyectos de investigación[4].

En conclusión, debería ser una prioridad para GETEII (Grupo Enfermero de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal) empezar a abrir caminos hacia la estandarización de la actividad docente en EII.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hernández Yáñez JF. ¿Qué significa enfermería de práctica avanzada hoy y aquí? Especialidades y enfermería de práctica avanzada [citado el 4 de mayo de 2016]. Recuperado a partir de: http://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/237/RIdEC.v4n2.31.Especialidades-3.pdf

2. Mason I, Holbrook K, Kemps K, Garrick V, Johns K, Kane M. Inflammatory bowel disease nursing. Results of an audit exploring the roles, responsibilities and activity of nurses with specialist/advanced roles [citado el 4 de mayo de 2016]. Recuperado a partir de: https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/433736/004197.pdf
3. O'Connor M, Bager P, Duncan J, Gaarenstroom J, Younge L, Détré P, et al. N-ECCO Consensus statements on the European nursing roles in caring for patients with Crohn's disease or ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2013;7(9):744-64.
4. Torrejón A, Oltra L, Hernández-Sampelayo P, Marín L, García-Sánchez V, Casellas F, et al. Development of quality standards in inflammatory bowel disease management and design of an evaluation tool of nursing care. Rev Esp Enfermedades Dig Organo Of Soc Esp Patol Dig 2013;105(5):262-71.



5

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Olga Núñez García

Enfermera de Investigación de la Unidad de EII.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

INTRODUCCIÓN

La investigación clínica tiene como objetivos adquirir nuevos conocimientos sobre enfermedades que ayuden a la prevención, diagnóstico y tratamiento[1]. Todos estos objetivos persiguen mejorar la calidad de vida de las personas. Es aquí donde la enfermería juega su papel más importante, CUIDAR a las personas.

El rol de enfermería en investigación clínica se enfrenta a grandes avances, por lo cual cobra cada vez mayor importancia la gestión que realiza en los procesos de los estudios de investigación[2].

El nivel del compromiso de la enfermería con la investigación no es un tema novedoso. En 1976 la Asociación de Enfermería Americana (ANA) ya recomendó la actividad en investigación, atendiendo a los distintos niveles de formación en enfermería[3]. Actualmente, el papel de la enfermería en investigación cada vez toma más relevancia debido al creciente interés. Hoy en día, el profesional de enfermería puede acceder a esta especialidad adquiriendo nuevas competencias y más poder para ejercer una profesión con una mayor autonomía, mayor responsabilidad y con un campo de conocimientos propio.

La enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa (CU) son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas (EII) junto con la colitis indeterminada, de etiología desconocida. En muchos casos debuta en individuos jóvenes con una incidencia que va en aumento, hasta 24 casos por 100.000 habitantes al año[4,5]. En todas estas personas afectadas con dicha enfermedad, los índices de calidad de vida son inferiores al resto de la población[6] y la supervivencia de estos individuos es menor que la de la población general[7].

Los pacientes con EII necesitan una atención que sea completa y que cubra tanto sus necesidades físicas como las emocionales, sociales y laborales. Debido a que es una enfermedad crónica de etiología desconocida y que el tratamiento se basa en la sintomatología, el profesional de enfermería debe estar familiarizado con la carga psicológica que soportan estos pacientes.

El conjunto de estos datos implica la necesidad de investigar sobre estas enfermedades y, para ello, la enfermería toma un papel fundamental con el fin de descubrir distintas y mejores formas de otorgar cuidados en el avance de conocimientos y pruebas obtenidas con el fin de dar cuidados de calidad a la población con dicha patología[8].

¿Por qué es importante la investigación para la enfermería? Es importante investigar por diversos motivos[9,10]:

– Ampliar el conocimiento.
– Fundamentar científicamente los cuidados.
– Adaptar los cuidados a la demanda social.
– Consolidar un estatus profesional.

Basándonos en la legislación actual, el profesional del enfermería es «un profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermería, con conocimientos y aptitudes suficientes sobre su cuerpo de doctrina y que basa su práctica en la evidencia científica»[11]. Es precisamente el personal de enfermería el que, gracias al contacto directo con las personas, puede observar e inferir en el cuidado de la persona como ser biopsicosocial.

El modelo de enfermera investigadora está en auge en nuestro país, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para seguir adquiriendo nuevas competencias y mayor poder para ejercer la profesión de manera más autónoma. Por tanto, se puede afirmar que la investigación es una rama de la profesión de enfermería que está en desarrollo[12].

OBJETIVOS

Objetivo general: describir las pautas de actuación de la enfermería para comenzar un estudio de investigación.
Objetivo específicos:
– Informar a los profesionales de enfermería de la actividad investigadora dentro de la EII.
– Inculcar la importancia de seguir investigando para avanzar dentro de la profesión.
– Motivar al personal de enfermería que trabaja con las personas con EII.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Cuando se habla de investigación en enfermería se debe dar una visión general del rol y cómo esta forma parte de un equipo en la realización de un estudio o ensayo clínico. El contenido específico de cualquier estudio de investigación tiene varias fases que detallaremos a continuación.

1. Aprobación del estudio

Antes de la realización de cualquier estudio, se requiere un informe del Comité de Ética del organismo, centro u hospital, y su correspondiente aprobación.

2. Reclutamiento de los participantes

El reclutamiento es una de las partes más importantes en el trabajo del personal de enfermería investigador. En la mayoría de estudios, el personal de enfermería de investigación identifica dónde pueden ser captados. En el caso de que el reclutamiento sea en un hospital, habrá que hacer una revisión exhaustiva de las consultas, tanto de enfermería como médica, para identificar posibles personas que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Hay muchas personas, departamentos y organismos externos que participan en la investigación clínica y el personal de enfermería en investigación suele ser el punto de contacto con el participante desde el inicio hasta que termine el mismo, así como en la comunicación con la compañía farmacéutica si el estudio es patrocinado comercialmente.

3. Consentimiento informado

Una vez que se establece el protocolo del estudio se debe recopilar, por un lado, una hoja informativa en la que se especifican las características del estudio y, por otro lado, el consentimiento informado, el cual el participante deberá firmar para dar su aprobación y poder así participar en la investigación.

4. Recogida de datos y notificación de reacciones adversas

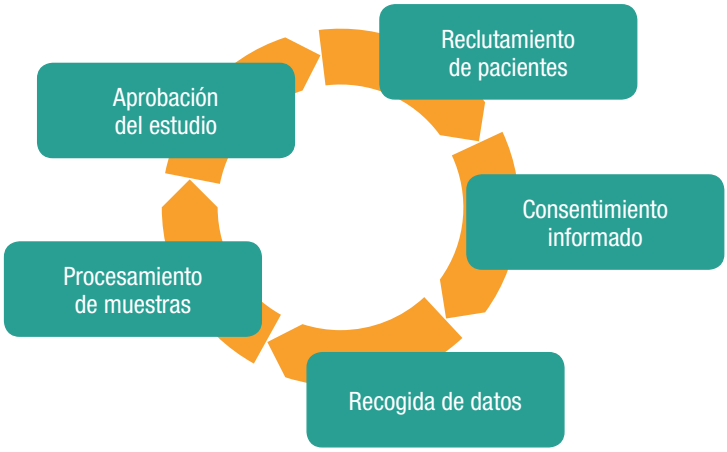
El personal de enfermería es una de las personas responsables en seguir a los pacientes a lo largo del ensayo clínico u otro tipo de estudio, por ejemplo asegurándose de que las

personas siguen el tratamiento que se les ha recomendado, que asisten a todas las citas o que se rellenan los informes según el protocolo.
En la investigación, recoger los datos es tan importante como el cuidado de los pacientes, ya que la información recogida en cada parte del proceso es la que se utilizará para determinar el resultado del estudio.
Es muy importante también que se notifique a los responsables del estudio (monitores) si ha existido o existe alguna reacción adversa durante el estudio.

5. Obtención y procesamiento de muestras

En muchos proyectos de investigación suele ser el personal de enfermería el encargado de la obtención y manejo de las muestras (sangre, heces, orina, saliva, etc.), las cuales se han de procesar utilizando diferentes técnicas y aparatos, como una máquina llamada centrífuga de laboratorio, elisas, congeladores de -80 °C, etc. En algunos casos hay que enviar las muestras a laboratorios externos o bien procesarlas en el centro de trabajo. La recogida y manejo de estas muestras es tan importante como los datos recopilados en el estudio.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN



BIBLIOGRAFÍA

1. Upper Saddle River NJ, Nieswiadomy RM. Foundations of Nursing Research. 5th ed.; 2008.
2. Zarate Samdra J, Rueda Santamaría L, Cañón Montañez W. Rol del profesional de enfermería en la investigación clínica. Rev Cuidarte 2011;2(1):246-9.
3. American Nurses Association (ANA) http://www.nursingworld.org/EspeciallyForYou/Nurse-Researchers
4. Van Assche G, Dignass A, Panes J, Beaugerie L, Karagiannis J, Allez M, et al. The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn´s disease: Definitions and diagnosis. J Crohn´s Colitis 2010;4:7-27.

5. Dignass A, Eliakim R, Magro F, Maaser C, Chowers Y, Geboes K, et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 1: definitions and diagnosis. J Crohn´s Colitis 2012;6:965-90.
6. Canavan C, Abrams KR, Hawthorne B, Drossman D, Mayberry JF. Long-term prognosis in Crohn´s disease: factors that affect quality of life. Aliment Pharmacol Ther 2006;23:377.
7. Wolters FL, Russel MG, Sijbrandij J, Schouten LJ, Odes S, Riis L, et al. Crohn´s disease: increased mortality 10 years after diagnosis in a Europe-wide population based cohort. Gut 2006;55(4):510-8.
8. International Council of Nurses. Practice professional. http://www.icn.ch/es/pilares-a-programas/professional-practice
9. Burns N, Grove SK. Investigación en Enfermería. 3ª Ed. Madrid: Elsevier; 2004.
10. Rodríguez F. Investigar para avanzar. Rev Enfermería Facultativa 2011;147:28.
11. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
12. Macia Soler L. Investigación en Enfermería. Rev Enferm Cli 2008;(18)6:287-8.

siglas y abreviaturas

6-MP: 6-mercaptopurina.

AO: anticonceptivos orales.

ATI: anticuerpos humanos anti-infliximab.

AZA: azatioprina.

Ca++: calcio.

CI: colitis indeterminada. (en 1, 18).

CU: colitis ulcerosa.

EC: enfermedad de Crohn.

EICI: enfermedad inflamatoria crónica intestinal.

EII: enfermedad inflamatoria intestinal.

EPA: enfermería de práctica avanzada.

GETEII: Grupo Enfermero de Trabajo e Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

HTA: hipertensión arterial.

i.m.: intramuscular.

i.v.: intravenoso.

IMM: inmunosupresores.

IQ: intervención quirúrgica.

l.p.m.: latidos por minuto.

MCT: ácidos grasos de cadena corta.

MP: mercaptopurina.

MTX: metotrexato.

N-ECCO: Nurse-European Crohn and Colitis Organisation.

Na+: sodio.

NE: nutrición enteral.

NP: nutrición parenteral.

Rx: radiografía.

s.c.: subcutáneo/a.

TIC: tecnologías de la información y la comunicación.

v.o.: vía oral.

VSG: velocidad de sedimentación globular.

Elaborado por:



Con la colaboración de:

abbvie

ES/HUG/1216/1781